



Instituto Federal Catarinense
Programa de Pós-Graduação em Educação Profissional e Tecnológica
Campus Blumenau

JULIANA AMADEI

**PERCEPÇÃO DOS PROFISSIONAIS ENFERMEIROS SOBRE OS REGISTROS DA
ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM E SUA ATUAÇÃO PROFISSIONAL NO
INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE**

Blumenau

2024

JULIANA AMADEI

**PERCEPÇÃO DOS PROFISSIONAIS ENFERMEIROS SOBRE OS REGISTROS DA
ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM E SUA ATUAÇÃO PROFISSIONAL NO
INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE**

Dissertação submetida ao Programa de Pós-graduação em Educação Profissional e Tecnológica do Instituto Federal Catarinense – *Campus* Blumenau para a obtenção do título de Mestra em Educação Profissional e Tecnológica.

Orientadora: Prof.^a Denise Fernandes,
Doutora

Blumenau

2024

Ficha de identificação da obra elaborada pelo autor,
através do Programa de Geração Automática do ICMC/USP, cedido ao IFC e
adaptado pela CTI - Araquari e pelas bibliotecas do Campus de Araquari e Concórdia.

A481p Amadei, Juliana
Percepção dos profissionais enfermeiros sobre os
Registros da Assistência de Enfermagem e sua atuação
profissional no Instituto Federal Catarinense. /
Juliana Amadei; orientador Denise Fernandes
Fernandes. -- Blumenau, 2024.
147 p.

Dissertação (mestrado) - Instituto Federal
Catarinense, campus Blumenau, , Blumenau, 2024.

Inclui referências.

1. Ensino médio integrado e a formação integral. 2.
História e fundamentos da enfermagem e a atuação do(a)
enfermeiro(a) no ambiente escolar. 3. Educação
profissional e tecnológica, Instituto Federal
Catarinense e enfermagem. 4. Sistematização da
assistência de enfermagem e registros da assistência.
I. Fernandes, Denise Fernandes. II. Instituto Federal
Catarinense. . III. Título.



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE
BLUMENAU - C.C. P.G. EDUCAÇÃO PROFISSIONAL TECNOLÓGICA

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS Nº 11917/2024 - CCPGEPT (11.01.09.31)

Nº do Protocolo: 23473.001113/2024-47

Blumenau-SC, 21 de junho de 2024.

JULIANA AMADEI

**PERCEPÇÃO DOS PROFISSIONAIS ENFERMEIROS SOBRE OS REGISTROS DA
ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM E SUA ATUAÇÃO PROFISSIONAL NO INSTITUTO
FEDERAL CATARINENSE**

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-graduação em Educação Profissional e Tecnológica, ofertado pelo Instituto Federal Catarinense, como requisito parcial para obtenção do título de Mestre/Mestra em Educação Profissional e Tecnológica.

Aprovado em 21 de junho de 2024

COMISSÃO EXAMINADORA

Prof^a. Dr^a. Denise Fernandes

Instituto Federal Catarinense

Orientadora

Prof^a. Dr^a. Fátima Peres Zago de Oliveira

Instituto Federal Catarinense

Prof^a. Dr^a. Dulce Dirclair Huf Bais

Universidade Federal do Paraná

Prof. Dr. Alessandro Eziquiel da Paixão
Instituto Federal Catarinense

(Assinado digitalmente em 24/06/2024 10:16)
ALESSANDRO EZEQUIEL DA PAIXÃO
PROFESSOR ENS BASICO TECN TECNOLOGICO
DEPE/ARA (11.01.02.02.02)
Matricula: ###091#3

(Assinado digitalmente em 22/06/2024 14:35)
DENISE FERNANDES
PROFESSOR ENS BASICO TECN TECNOLOGICO
CGE/RDSUL (11.01.05.11)
Matricula: ###774#2

(Assinado digitalmente em 24/06/2024 20:25)
FATIMA PERES ZAGO DE OLIVEIRA
PROFESSOR ENS BASICO TECN TECNOLOGICO
CGE/RDSUL (11.01.05.11)
Matricula: ###020#8



Documento assinado digitalmente

DULCE DIRCLAIR HUFBAIS

Data: 26/07/2024 15:44:27-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Visualize o documento original em <https://sig.ifc.edu.br/public/documentos/index.jsp> informando seu número: **11917**, ano: **2024**, tipo: **DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS**, data de emissão: **21/06/2024** e o código de verificação: **bb169c1a5e**



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE
BLUMENAU - C.C. P.G. EDUCAÇÃO PROFISSIONAL TECNOLÓGICA

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS Nº 11918/2024 - CCPGEPT (11.01.09.31)

Nº do Protocolo: 23473.001114/2024-91

Blumenau-SC, 21 de junho de 2024.

JULIANA AMADEI

PRONTUÁRIO UNIFICADO E CRONOGRAMA DE AÇÕES DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE

Produto Educacional apresentado ao Programa de Pós-graduação em Educação Profissional e Tecnológica, ofertado pelo Instituto Federal Catarinense, como requisito parcial para obtenção do título de Mestre/Mestra em Educação Profissional e Tecnológica.

Aprovado em 21 de junho de 2024

COMISSÃO EXAMINADORA

Profª. Drª. Denise Fernandes
Instituto Federal Catarinense
Orientadora

Profª. Drª. Fátima Peres Zago de Oliveira
Instituto Federal Catarinense

Profª. Drª. Dulce Dirclair Huf Bais
Universidade Federal do Paraná

Prof. Dr. Alessandro Eziquiel da Paixão

Instituto Federal Catarinense

(Assinado digitalmente em 24/06/2024 10:16)

ALESSANDRO EZEQUIEL DA PAIXÃO

PROFESSOR ENS BASICO TECN TECNOLÓGICO

DEPE/ARA (11.01.02.02.02)

Matricula: ###091#3

(Assinado digitalmente em 22/06/2024 14:35)

DENISE FERNANDES

PROFESSOR ENS BASICO TECN TECNOLÓGICO

CGE/RDSUL (11.01.05.11)

Matricula: ###774#2

(Assinado digitalmente em 24/06/2024 20:25)

FATIMA PERES ZAGO DE OLIVEIRA

PROFESSOR ENS BASICO TECN TECNOLÓGICO

CGE/RDSUL (11.01.05.11)

Matricula: ###020#8



Documento assinado digitalmente

DULCE DIRCLAIR HUF BAIS

Data: 26/07/2024 15:44:27-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Visualize o documento original em <https://sig.ifc.edu.br/public/documentos/index.jsp> informando seu número: **11918**, ano: **2024**, tipo: **DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS**, data de emissão: **21/06/2024** e o código de verificação: **54fb385cb4**

Para Pedro Jorge e Pietro, girassóis da minha existência. Para Marcos, companheiro querido de jornada.

Para Atílio e Lurdes, inspirações de minha vida.

Para Andréia, minha maior torcida.

Para Ivonei (*in memoriam*) por me ensinar que a “vida continua” – a máxima que me permite conviver com a saudade.

AGRADECIMENTOS

Neste momento de imensa felicidade, primeiramente gostaria de agradecer a Deus, por me presentear com o dom da vida, e por ser minha fortaleza em todos os momentos da minha existência.

Meus pais, gratidão pela minha vida e por serem os maiores responsáveis pelo que sou hoje.

Aos meus filhos Pedro Jorge Neto e Pietro, por serem as inspirações da minha vida, pelo amor puro doado, a dose diária de ânimo e força que tornou menos árdua essa caminhada, em especial ao Pietro que me acompanhou durante toda esta trajetória desde o meu ventre.

Ao Marcos, companheiro dessa existência, pela paciência, compreensão e por ser presente, à sua maneira, e, assim, me possibilitar o aprimoramento moral, a resiliência e força para persistir quando menos acreditei que fosse capaz.

Estendo os agradecimentos aos demais familiares e amigos que, na medida do possível, me proporcionaram o suporte espiritual, o aconchego e o afeto necessários para seguir em frente.

De forma mais que especial, quero agradecer profundamente à minha orientadora, uma pessoa maravilhosa, mais um anjo na minha vida, a professora doutora Denise Fernandes. Não tenho palavras que possam expressar minha gratidão pelas mãos dadas durante todo esse percurso, por sua empatia, paciência, compreensão, pelos ensinamentos e pela gentil forma de amenizar minhas inquietações e angústias e por acreditar em mim no momento muito especial e sensível da minha vida, minha gestação e mestrado. Gratidão eternamente.

A minha primeira professora, Bernadete Lorenzi, um espelho para mim, por ter sempre acreditado em mim, foi a grande responsável por eu ter conseguido a minha formação em enfermagem, assim contribuído para essa conquista, a minha homenagem e gratidão sempre.

Aos professores de toda a minha vida que trilharam comigo a empreitada da construção dos saberes e permitiram o desvelamento de crenças e paradigmas, em especial aos do mestrado do Instituto Federal Catarinense polo Blumenau, a minha homenagem e agradecimento.

Aos meus amigos, José Luiz e Priscila, anjos na minha vida, agradeço imensamente pelo apoio e ajuda, por sempre estarem ao meu lado, seja em momentos felizes e também de dificuldades, pelo cuidado com meus filhos, pelas palavras de coragem e conforto que me preencheram de tranquilidade em um momento de desespero e medo de não conseguir chegar até aqui. Eternamente grata.

Aos meus amigos, Carolina, Mario e Otávio, grata pela parceria nesta jornada, das viagens para Blumenau, hospedagem, pela partilha de conhecimentos. Agradeço pelo apoio nas horas de agonia e desespero, pelas mãos amigas, por nunca me permitirem abandonar a jornada, agradeço imensamente o auxílio, ajuda que me proporcionaram nessa caminhada, Sem essas pessoas especiais, eu não teria conseguido seguir até o fim. São verdadeiros anjos enviados para me salvar nos momentos de incerteza.

A minha amiga e colega Noara, um anjo na minha vida, agradeço imensamente pela força, pela ajuda, eternamente grata.

Aos professores de toda a minha vida que trilharam comigo a empreitada da construção dos saberes e permitiram o desvelamento de crenças e paradigmas, em especial aos do mestrado do Instituto Federal Catarinense polo Blumenau, a minha homenagem e agradecimento.

Abro agora um parágrafo mais que especial para agradecer profundamente a minha equipe de trabalho “SISAE Araquari”, pela compreensão e apoio nessa caminhada. Obrigado!

De forma muito especial, quero agradecer aos enfermeiros participantes da pesquisa, pelo aceite imediato em participar dessa pesquisa e pelas valiosas contribuições para a efetivação desse trabalho. Muito obrigado!

Aos meus amigos e colegas de mestrado, turma Profept 2022. Agradeço pelas parcerias em trabalhos e pesquisas, partilha de conhecimentos e experiências, sorrisos e lágrimas, além do famoso cafezinho juntos.

Agradeço também aos queridos professores que compuseram a banca de qualificação e de defesa desta pesquisa, o professor Dr. Alessandro Eziquiel da Paixão (IFC), às professoras doutoras Dulce Dirclair Huf Bais (UFPR) e Fátima Peres Zago de Oliveira (IFC). Muito obrigado pelas contribuições e direcionamentos para o amadurecimento desta pesquisa que nos levaram ao êxito no trabalho.

A todos aqueles e aquelas que, direta ou indiretamente, contribuíram com o desenvolvimento dessa pesquisa, e conseqüentemente, com o meu crescimento profissional, intelectual e pessoal. Gratidão a todos pela parceria.

“Faça o teu melhor, na condição que você tem,
enquanto você não tem condições melhores
para fazer melhor ainda” (Cortella, 2023).

RESUMO

O presente estudo visa compreender a percepção dos enfermeiros atuantes na educação profissional e tecnológica (EPT) quanto à sua contribuição na formação integral através das ações educativas de prevenção e promoção da saúde e dos registros dos atendimentos ambulatoriais. Esta pesquisa foi realizada utilizando entrevista semiestruturada e os dados foram analisados através da metodologia da análise de conteúdo. A pesquisa se insere na linha de Organização e Memórias de Espaços Pedagógicos na EPT, integrando-se ao macroprojeto 6 – Organização de espaços pedagógicos da EPT. Os resultados são apresentados em três categorias: I- Atuação do enfermeiro no ambiente escolar, em que se buscou entender a percepção dos enfermeiros quanto à sua atividade no ambiente escolar em um sistema de ensino que visa à formação integral; II- Sistematização da assistência de enfermagem no ambiente escolar, em que se buscou entender a percepção dos enfermeiros sobre as formas de registros dos atendimentos de enfermagem e sua importância no contexto escolar na contribuição para a educação integral; III- Contribuições do enfermeiro escolar na formação integral, em que se pretendeu identificar as percepções dos enfermeiros quanto aos conceitos de educação integral e formação omnilateral e o entendimento do que é a EPT proposta pelos Institutos Federais. Nessas categorias, apresentamos que a percepção dos enfermeiros sobre sua atuação no ambiente escolar é voltada principalmente para ações de promoção e prevenção em saúde. Eles compreendem que contribuem com a educação integral, sentindo-se também como educadores atuando no ambiente escolar. Os enfermeiros compreendem ser fundamental realizar ações e registros de enfermagem padronizados e sistematizados. Também se constatou que os enfermeiros sentem falta de uma proximidade com demais colegas para padronização de documentos e de registros, com o propósito de planejar ações em conjunto e trocar experiências. Diante dos resultados, foram construídos os seguintes produtos educacionais: um prontuário unificado para os atendimentos ambulatoriais e um calendário de ações de prevenção e promoção da saúde. Os produtos educacionais foram avaliados através de grupo focal e de questionário *on-line* estruturado com perguntas objetivas e discursivas. O grupo focal reuniu os profissionais enfermeiros em sala virtual onde foram realizadas discussões sobre os produtos educacionais previamente enviados. Após o momento de discussão do grupo focal, os produtos foram avaliados, via questionário *on-line* na plataforma *Google Forms*, sobre sua aceitação, utilidade e possível melhoria nos processos realizados pelos profissionais de enfermagem. Concluímos, através das percepções e da avaliação dos enfermeiros, que a pesquisa possibilitou melhorias para as suas atividades em ambiente escolar. Os produtos educacionais foram

julgados adequados e aceitos para a utilização na prática diária dos enfermeiros. Identificamos também a percepção dos enfermeiros(as) quanto à sua atuação no ambiente escolar como educadores, sendo esta atuação focada principalmente em atividades de educação em saúde. Desta forma, trazemos nossa contribuição com um dos pontos da missão dos Institutos Federais, que é oferecer uma educação integral, que aqui compreendeu as ações de educação e de atendimento ambulatorial dos enfermeiros escolares.

Palavras-chave: enfermagem; ensino; educação em saúde; educação integral; ProfEPT.

ABSTRACT

The present study aims to understand the perception of nurses working in professional and technological education (EPT), regarding their contribution to integral formation, through educational actions for prevention and health promotion and records of outpatient care. This research was carried out using semi-structured interviews and the data analyzed using content analysis methodology. The research is part of the line of Organization and Memories of Pedagogical Spaces at EPT, integrating with macroproject 6 - Organization of pedagogical spaces at EPT. The results were presented in three categories: I-Nurse's role in the school environment, where we sought to understand nurses' perception regarding the activity in the school environment in an education system that aims at integral education. II- Systematization of nursing care in the school environment, we sought to understand the nurses' perception of the forms of recording nursing care and its importance in the school context in contributing to integral education. III- Contributions of school nurses in integral training, the aim was to identify nurses' perceptions regarding the concepts of integral education and omnilateral training, the understanding of what EPT is proposed by the Federal Institutes. In these categories we present the nurses' perception about their work in the school environment being mainly focused on health promotion and prevention actions. They understand that they contribute to integral education, and nurses also feel like educators working in the school environment. They understand that it is essential to carry out standardized and systematized nursing actions and records. It was also found that nurses lack proximity to other colleagues to standardize documents and regulations with the purpose of planning actions together and exchanging experiences. Based on the results, educational products were created: a unified medical record for outpatient care and a calendar of prevention and health promotion actions. The educational products were evaluated through a focus group and a structured online questionnaire with objective and discursive questions. The focus group brought together nursing professionals in a virtual room where discussions were held about the educational products previously sent. After the focus group discussion, the products were evaluated via an online questionnaire, through the Google Forms platform, regarding their acceptance, usefulness and possible improvement in the processes carried out by nursing professionals. We concluded, through the nurses' perceptions and evaluation, that the research enabled improvements in nurses' activities in the school environment. The educational products were judged appropriate and accepted for use in nurses' daily practice. We also identified the perception of nurses regarding their role in the school environment as educators, which is

mainly focused on health education activities. In this way, we bring our contribution to one of the points of the mission of the Federal Institutes, which is to offer an integral education, which here included the actions of education and outpatient care for school nurses.

Keywords: nursing; teaching; health education; comprehensive education; ProfEPT.

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

Aben	Associação Brasileira de Enfermagem
ABNT	Associação Brasileira de Normas Técnicas
CAAE	Certificado de Apresentação de Apreciação Ética
CEP	Comitê de Ética e Pesquisa
CEPSH	Comitê de Ética para Pesquisas com Seres Humanos
Cofen	Conselho Federal de Enfermagem
Coren	Conselho Regional de Enfermagem
CPC	Código de Processo Civil
EPT	Educação Profissional e tecnológica
IF	Institutos Federais
IFC	Instituto Federal Catarinense
IFMS	Instituto Federal do Mato Grosso do Sul
LDB	Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional
MEC	Ministério da Educação
PCN	Parâmetro Curricular Nacional
PE	Processo de Enfermagem
PE	Prontuário Eletrônico
Pnaes	Programa Nacional de Assistência Estudantil
ProfEPT	Mestrado Profissional em Educação Profissional e Tecnológica
ProUni	Programa Universidade para Todos
PSE	Programa Saúde na Escola
SAE	Sistematização da Assistência de Enfermagem
SIA	Sistemas de Informações Ambulatoriais do SUS
Siab	Sistema de Informação da Atenção Básica
Sisae	Serviço Integrado de Suporte e Acompanhamento Educacional
TAEs	Técnicos Administrativos
TCLE	Termo de Consentimento Livre e Esclarecido
UAB	Universidade Aberta do Brasil

SUMÁRIO

1	INTRODUÇÃO	15
2	REFERENCIAL TEÓRICO.....	19
2.1	Ensino médio integrado e a formação integral.....	19
2.2	História e fundamentos da enfermagem e a atuação do(a) enfermeiro(a) no ambiente escolar.....	21
2.3	Educação profissional e tecnológica, Instituto Federal Catarinense e enfermagem	27
2.4	Sistematização da assistência de enfermagem e registros da assistência.....	35
3	METODOLOGIA	41
3.1	Delimitação da pesquisa	41
3.2	Coleta de dados	42
3.3	Análise dos dados	43
3.4	Produto educacional	44
3.5	Avaliação do produto educacional	45
4	RESULTADOS E DISCUSSÃO	46
4.1	Caracterização dos participantes da pesquisa	48
4.2	Categoria I: atuação do enfermeiro no ambiente escolar	52
4.3	Categoria II: sistematização da assistência de enfermagem no ambiente escolar	55
4.4	Categoria III: contribuições do enfermeiro na formação integral.....	61
5	PRODUTO EDUCACIONAL	70
5.1	Apresentando o produto educacional.....	71
5.2	Avaliação do produto educacional	72
5.3	Aprimoramento do produto educacional após avaliação.....	81
	CONSIDERAÇÕES FINAIS	83
	REFERÊNCIAS	85
	APÊNDICE A – ROTEIRO DA ENTREVISTA COM OS ENFERMEIROS	92
	APÊNDICE B – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO.....	94
	APÊNDICE C – PRODUTO EDUCACIONAL.....	97
	APÊNDICE D – QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO DO PRODUTO EDUCACIONAL	114
	APÊNDICE E – PRODUTO EDUCACIONAL APRIMORADO	118

ANEXO A – DIAGNÓSTICOS DE ENFERMAGEM.....	128
ANEXO B – MODELO DE ENCAMINHAMENTO DE SAÚDE PADRONIZADO PARA USO DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM NO IFC.....	135

1 INTRODUÇÃO

O presente estudo versou sobre a percepção dos profissionais de enfermagem nos espaços pedagógicos da Educação Profissional e Tecnológica (EPT), quanto às suas ações de prevenção e de promoção da saúde, com o foco sobre os registros dessas ações e os atendimentos prestados em um sistema de ensino que visa à formação integral. Este estudo é parte integrante do Mestrado Profissional em Educação Profissional e Tecnológica (ProfEPT) e está inserido na linha de pesquisa Organização e Memórias de Espaços Pedagógicos na EPT, em seu macroprojeto 6, versando sobre a organização de espaços pedagógicos na EPT.

Nos Institutos Federais, conforme previsto em sua lei de criação (Lei n. 11.892/2008), é ofertada a EPT, numa proposta pedagógica de educação integral. Conforme apontam Nitschke, Plácido e Pitt (2021, p. 42), na EPT compreende-se a educação integral como aquela que se pauta na politécnica e omnilateralidade, “cuja gênese encontra-se em Marx e Engels e se aproxima da concepção de escola unitária de Gramsci, para quem a politécnica vai além da dicotomia entre trabalho manual/trabalho intelectual”. É uma proposta pedagógica comprometida com a utopia de uma formação inteira, ou integral, no sentido de desenvolver as faculdades físicas e intelectuais do sujeito em uma perspectiva ampla. Frigotto, Ciavatta e Ramos (2005) entendem que uma educação integral significa garantir aos sujeitos que vivem do trabalho o direito a uma formação completa para poderem fazer uma leitura do mundo em que estão inseridos e atuar nele como cidadãos dignos e integrados a uma sociedade política.

Para Pacheco (2015, p. 15):

[...] a concepção de EPT que deve orientar as ações de ensino, pesquisa e extensão nos Institutos Federais (IF) baseia-se na integração entre ciência, tecnologia e cultura como dimensões indissociáveis da vida humana e, ao mesmo tempo, no desenvolvimento da capacidade de investigação científica, essencial à construção da autonomia intelectual.

Nessa perspectiva, a EPT busca uma formação completa do ser humano, preparando-o para a vida. Como destaca Pacheco (2015, p. 29): “Formação humana integral trata-se de superar a divisão do ser humano entre o que pensa e aquele que trabalha, produzida pela divisão social do trabalho, presente na formação voltada ao treinamento para a execução de determinadas tarefas”.

A educação integral ofertada nos IF tem seu ápice de materialização no Ensino Técnico integrado ao Ensino Médio. Cabe esclarecer que o Ensino Técnico integrado ao Ensino Médio é uma modalidade de educação profissional que busca a formação integral do estudante no que se refere à formação humana e cultural para o exercício da cidadania e da democracia, integrada

à formação para o mundo do trabalho. Essa perspectiva voltada para a formação integral agrega o respeito às posições e às demandas dos adolescentes, além de proporcionar o estímulo ao seu envolvimento no processo de construção do cotidiano da escola e da sociedade.

Cabe ainda pontuar que nesta proposta de educação integral o estudante adolescente é atendido em suas múltiplas necessidades escolares, na compreensão de que a escola é um espaço de formação cidadã de adolescentes, local para aquisição de conhecimentos e desenvolvimento crítico e político, o que contribui para construção de valores pessoais, crenças, hábitos e conceitos, fatores estes que interferem na produção social e na saúde. Essa visão de educação integral compreende, ainda, que a adolescência é uma fase de transformações significativas, com mudanças biopsicossociais que trazem consigo hábitos que podem se consolidar por toda a vida adulta. Acrescenta-se que essas transformações fazem com que a adolescência represente um momento de vulnerabilidade desses indivíduos, tendo em vista comportamentos que podem levar à exposição a diferentes riscos, inclusive relacionados à saúde.

O enfermeiro escolar é o profissional capacitado para prestar cuidados de enfermagem especializados de forma autônoma, no campo educacional, em uma equipe multidisciplinar. A atuação do enfermeiro no ambiente escolar, através das suas ações de educação em saúde, consultas de enfermagem e acolhimento, contribui para a formação integral do ser humano, redução de vulnerabilidades existentes na fase da adolescência, incentivando a adoção de hábitos de vida mais saudáveis, melhorando consequentemente a qualidade de vida dos educandos.

Os Institutos Federais de Educação Ciência e Tecnologia, que fazem parte da Rede Federal de Educação Profissional Científica e Tecnológica, visam a uma educação integral e, para essa contribuição, dispõem de profissionais enfermeiros em diversas unidades. A presença desses profissionais impulsiona as ações de educação em saúde dos escolares, participando de maneira ativa no processo de educação em saúde dos discentes, ajustando saúde e educação na construção de uma escola mais saudável e contribuindo para o ensino, aprendizagem e para uma educação integral.

A atuação do enfermeiro na educação profissional e tecnológica contribui com a formação omnilateral, através das ações de educação em saúde, como oficinas, e da participação em projetos de ensino e extensão. Essa contribuição também acontece por meio das ações de promoção e prevenção em saúde, além dos atendimentos individuais ao estudante com orientações de saúde.

Os registros dos cuidados à saúde são fundamentais para o atendimento ao estudante, pois através deles conhecemos o histórico de saúde do paciente, família, condições socioeconômicas, entre outras. Esses registros oferecem subsídios à equipe de saúde para planejamento das ações, das condutas e da organização do cuidado para o indivíduo e coletividade, buscando a integralidade na assistência, ou seja, o atendimento do paciente na totalidade. Além disso, resulta para a instituição, em termos de registro, numa gama de informações que, uma vez reunidas, irão constituir o prontuário do estudante e o histórico de ações educativas.

A Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE) facilita, organiza e agiliza o trabalho dos enfermeiros e se constitui em um instrumento metodológico dinâmico e inovador essencial para orientar a prática da enfermagem, estando prevista pelo Conselho Federal de Enfermagem (Cofen), na Resolução Cofen n. 358/2009 como Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE) (Brasil, 2009).

A SAE é viabilizada de diversas maneiras, sendo uma delas o Processo de Enfermagem (PE), composto por algumas etapas como histórico, diagnóstico, intervenções e resultados de enfermagem, podendo ser registrado, dentre outras formas, a partir de um sistema de classificação em enfermagem, veiculado em linguagem padronizada (Barros; Fakihi; Michel; 2002).

Considerando que o IFC dispõe do serviço de enfermagem em diversos *campus* e que cada um registra seus atendimentos individualmente, torna-se necessário padronizar e unificar a forma dos registros e a sistematização da assistência deste serviço, a fim de gerar melhor organização, planejamento e segurança tanto para os profissionais quanto para os estudantes e a Instituição.

Portanto, esta pesquisa translacional se desenvolveu através da questão norteadora: qual a percepção dos enfermeiros sobre suas atividades no sistema de registro da assistência de enfermagem e das ações educativas em saúde na contribuição para a educação integral no IFC? Para responder a essa pergunta, foram realizadas entrevistas com os enfermeiros que prestam assistência de enfermagem no IFC. Assim, foi possível compreender a percepção desses profissionais sobre o papel do histórico, da organização e da manutenção dos dados dos registros do cuidado de saúde e das ações educativas de promoção à saúde, e da SAE, na formação integral. Após analisar as entrevistas, identificamos os principais pontos de intervenção. Desta forma, para auxiliar a equipe de enfermagem na colaboração para uma educação integral, foram criados os seguintes produtos educacionais: um calendário de ações

educativas de promoção à saúde e um prontuário unificado para os registros da assistência em Enfermagem no IFC

2 REFERENCIAL TEÓRICO

2.1 Ensino médio integrado e a formação integral

O termo “integrado” remete, por um lado, à forma de oferta do ensino médio articulado com a educação profissional. Por outro lado, o termo também faz menção a um tipo de formação, integrada, plena, que possibilita ao educando a compreensão das partes no seu todo ou da unidade no diverso, tratando-se a educação como uma totalidade social (Ciavatta, 2014, p. 198).

Partindo desse pressuposto, lembramos que o Ensino Médio Integrado, na perspectiva da EPT, busca a formação do educando na sua totalidade, nas várias áreas do conhecimento, da ciência, da cultura e do trabalho. Frigotto, Ciavatta e Ramos (2012, p. 84) afirmam que com “a formação integrada ou do ensino médio integrado ao ensino técnico, queremos que a educação geral se torne inseparável da educação profissional em todos os campos onde se dá a preparação para o trabalho”. Nessa perspectiva, o(a) enfermeiro(a) na EPT contribui com esta preparação, educando em saúde e formando indivíduos com conhecimentos em saúde que poderão, por sua vez, ser multiplicadores desse conhecimento na sociedade.

A formação integral se materializa nos IFs, principalmente na oferta da Educação Profissional Integrada ao Ensino Médio, uma modalidade da EPT que busca a formação integral dos(as) estudantes. Essa formação integral inclui tanto a formação humana e cultural para o exercício da cidadania e democracia, quanto a preparação para o mundo do trabalho. Essa abordagem respeita as posições e demandas dos(as) adolescentes, incentivando seu envolvimento no processo de construção do cotidiano escolar e social.

Nessa proposta de ensino, é possível formar o indivíduo nas várias áreas do conhecimento, pois “o ensino médio, como educação básica e articulado com ao mundo do trabalho, da cultura e da ciência, constituem-se em direito social e subjetivo e, portanto, vinculado a todas as esferas e dimensões da vida” (Frigotto; Ciavatta; Ramos, 2012, p. 76). Para Ramos (2008, p. 14) “[...] o ensino médio é uma etapa da educação básica em que a relação entre ciência e práticas produtivas se evidencia; e é a etapa biopsicológica e social de seus estudantes em que ocorre o planejamento e a necessidade de inserção no mundo do trabalho, no mundo adulto”. A educação integral, como concebida por ambos, objetiva formar cidadãos críticos e conscientes, preparados para atuar de forma ética e transformadora no mundo.

De acordo com Ramos (2017, p. 9), “a luta pelo ensino médio integrado é a luta pelo direito à formação humana plena, tendo o trabalho como princípio educativo em um currículo centrado nas dimensões fundamentais da vida: o trabalho, a ciência e a cultura”. Percebe-se a

relevância de uma formação integral, completa do ser humano, possibilitando ao educando uma visão do todo e não uma visão fragmentada, buscando assim uma formação integral. Segundo Ciavatta (2014), “o sentido de formação integrada ou ensino médio integrado à educação profissional sob uma base unitária de formação geral é uma condição necessária para se fazer a travessia para a educação politécnica e omnilateral realizada pela escola unitária”.

Nesse sentido, observa-se o quanto é importante um processo formativo integral, possibilitando uma educação plena, formando cidadãos(ãs) com uma visão ampla, desenvolvendo o pensamento crítico, que questiona as desigualdades entre as classes sociais, buscando superar a dualidade presente no sistema capitalista, que destina o trabalho manual para as classes menos favorecidas e o trabalho intelectual para a elite, contribuindo, por fim, para a construção de uma sociedade mais justa e igualitária. Como destaca Ciavatta (2014, p. 197):

A formação integrada significa mais do que uma articulação entre ensino médio e educação profissional. Ela visa recuperar, no atual contexto histórico e sob uma específica correlação de forças entre as classes, a concepção de educação politécnica, de educação omnilateral e de escola unitária, que esteve na disputa por uma nova LDB na década de 1980, sendo perdida na aprovação da Lei n.º 9.394/96. Assim, essa expressão também se relaciona com a luta pela superação do dualismo estrutural da sociedade e da educação brasileira, a divisão de classes sociais, a divisão entre formação para o trabalho manual ou para o trabalho intelectual, e em defesa da democracia e da escola pública.

Observa-se, portanto, quão importante é um processo formativo integral, que garante ao jovem/adolescente uma educação capaz de formá-lo enquanto um cidadão dotado de pensamento crítico com vistas à superação das desigualdades.

O Serviço de Atenção à Saúde no IFC tem como finalidade a assistência à saúde de forma integral ao ser humano, objetivando o desenvolvimento de ações de prevenção e promoção da saúde, com vistas à formação completa do educando. A Lei Orgânica da Saúde (Lei n. 8.080/90) em seu art. 7º, II, trata da integralidade da assistência, entendida como “um conjunto articulado e contínuo de ações e serviços preventivos e curativos, individuais ou coletivos, exigidos para cada caso em todos os níveis de complexidade do sistema” (Brasil, 1990).

A adolescência/juventude é uma fase de transformações significativas com mudanças biopsicossociais que traz consigo hábitos que podem se consolidar por toda a vida adulta. “A saúde integral é o grau de bem-estar que permite ao adolescente crescer e se desenvolver de acordo com seu potencial biológico, psicológico e social” (Brasil, 2013, p. 9), sendo assim, um atendimento multiprofissional no contexto escolar visa ao cuidado integral ao adolescente, ou seja, em todas as dimensões, bio, psico e social, uma vez que integra a “atenção integral e o

conjunto de esforços organizados em caráter intersetorial e interdisciplinar que visam oferecer respostas adequadas às exigências da adolescência para alcançar e manter a saúde integral” (Brasil, 2013, p. 9).

Nesse sentido, percebemos a importância de um atendimento integral, ou seja, efetuado por uma equipe multidisciplinar aos adolescentes, pois como destacam Silva *et al.* (2007, p. 2): “O adolescente deve ser atendido por equipe multidisciplinar especializada e com capacidade para assistir integralmente o indivíduo em seus aspectos biopsicossocial e em contínua interação com seu meio ambiente”.

Diante disso, a atuação do enfermeiro no contexto escolar, como membro da equipe multidisciplinar, corrobora o processo da formação integral, pois são realizadas ações que visam à educação em saúde. São exemplos dessas ações as oficinas de prevenção em saúde, as rodas de conversas, as campanhas Setembro Amarelo, outubro rosa, novembro azul, entre outras, além do acompanhamento integral da saúde do estudante, que vai desde o seu histórico de saúde, acolhimento, consulta de enfermagem, encaminhamentos etc. Como enfatizam Silva *et al.* (2007, p. 2): “A proposta de se oferecer atenção integral de qualidade, a esta parcela populacional, implica na atuação harmônica da equipe multidisciplinar”. O IFC tem profissionais de enfermagem em vários *campi*, esses profissionais, juntamente com as equipes multidisciplinares, podem realizar várias ações educativas e atendimentos aos estudantes, um atendimento integral, contribuindo para sua formação cidadã.

2.2 História e fundamentos da enfermagem e a atuação do(a) enfermeiro(a) no ambiente escolar

O cuidado sempre fez parte da humanidade desde o seu princípio, como o cuidado doméstico, de mãe para filho, por exemplo. O início da enfermagem como profissão surge com Florence Nightingale, nascida na cidade de Florença, Itália, em 12 de maio do ano de 1820. Por ter nascido em uma família rica e educada, ela viveu a adolescência participando de uma sociedade aristocrática, tendo tido a oportunidade de estudar diversos idiomas e disciplinas como matemática, filosofia entre outras. Extremamente religiosa, desejava mesmo era fazer o “trabalho de Deus” – ajudar os pobres, os doentes e os menos dotados, amenizando-lhes o sofrimento e a degradação (Padilha; Mancia, 2005)

Florence Nightingale é considerada a fundadora da Enfermagem moderna em todo o mundo, obtendo um maior destaque a partir de sua participação como voluntária na Guerra da Criméia, em 1854, quando com 38 mulheres (irmãs anglicanas e católicas) organizou um hospital de 4.000 soldados internos, baixando a mortalidade local de 40% para 2%. Com o

prêmio recebido do governo inglês por este trabalho, fundou a primeira escola de enfermagem no Hospital St. Thomas – Londres, em 24 de junho de 1860. (Padilha; Mancia, 2005).

Em 1860, Florence funda a primeira Escola de Enfermagem no Hospital Thomas. As alunas tornaram-se pioneiras da enfermagem moderna, sendo enviadas a diferentes lugares para executar e ensinar suas habilidades. Até essa época, no Brasil, as funções da enfermagem eram relegadas ao plano doméstico ou religioso, sem nenhum caráter técnico. A partir da década de 90, várias escolas foram criadas no Brasil, como a escola Alfredo Pinto, em 1890, a escola Ana Nery, entre outras (Grau; Avello, 2003).

Feitosa (2023) enfatiza que a prática da enfermagem, historicamente, passou por grandes transformações técnicas e científicas, saindo do modo empírico para o científico. Esse fato contribuiu para o desenvolvimento da profissão, como também destaca o Conselho Federal de Enfermagem.

A enfermagem, por muitos anos, foi tida como uma profissão subalterna e de caridade, ou seja, de cuidar por amor ao próximo, sem querer nada em troca, com agir empírico. Esse cenário foi se transformando devido às descobertas científicas e tecnológicas e ao empenho de diversos estudiosos que contribuíram para a evolução da enfermagem moderna, que passa a ser independente, ou seja, não submetida a nenhuma outra profissão e que tem regulamentação própria. Isto significa, no contexto atual, que o exercício profissional da enfermagem, desde a formação, às competências e áreas de atuação, é regido por lei. A fiscalização do exercício profissional é a função primordial do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Enfermagem (Cofen, 2009).

A Lei 5.905/73 dispõe sobre a criação do Conselho Federal (Cofen) e dos Conselhos Regionais de Enfermagem (Coren), que se tornaram responsáveis pela elaboração de leis e resoluções que regulamentam o exercício profissional de enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem, além da sua fiscalização (Grau; Avello, 2003).

Observa-se que a trajetória da enfermagem teve como princípio fundamental o cuidado com as pessoas que necessitavam de assistência, seja individual ou coletivo. Diante do exposto, havia necessidade de uma formação específica e da regulamentação dessa profissão. Florence Nightingale destaca dois tipos de formação para tais profissionais, sendo uma para supervisora do serviço e outra para atendimento direto ao paciente. Dessa forma, a partir de 1940, surgem no Brasil novas escolas de enfermagem, tanto de nível técnico quanto de nível superior (Grau; Avello, 2003).

A enfermagem é regulamentada pela Lei n. 7.498 de 25 de junho de 1986, e pelo Decreto n. 94.406, de 8 de junho de 1987. Conforme a Lei n. 7.498/86: “É livre o exercício da

enfermagem em todo o território nacional, observadas as disposições desta lei” (Brasil, 1986). A enfermagem e suas atividades auxiliares somente podem ser exercidas por pessoas legalmente habilitadas e inscritas no Conselho Regional de Enfermagem com jurisdição na área onde ocorre o exercício (Brasil, 1986).

A enfermagem é exercida privativamente pelo enfermeiro, pelo técnico de enfermagem, pelo auxiliar de enfermagem e pela parteira, respeitados os respectivos graus de habilitação. O planejamento e a programação das instituições e serviços de saúde incluem planejamento e programação de enfermagem, sendo que a programação de enfermagem inclui a prescrição da assistência de enfermagem (Brasil, 1986).

A Lei n. 7.498/86, que regulamenta a profissão de enfermagem, em seu art. 6º, define enfermeiro como:

- I - o titular do diploma de Enfermeiro conferido por instituição de ensino, nos termos da lei;
- II - o titular do diploma ou certificado de Obstetriz, ou de Enfermeira Obstétrica, conferido nos termos da lei;
- III - o titular do diploma ou certificado de Enfermeira e a titular do diploma ou certificado de Enfermeira Obstétrica ou de Obstetriz, ou equivalente, conferido por escola estrangeira segundo as leis do país, registrado em virtude de acordo de intercâmbio cultural ou revalidado no Brasil como diploma de Enfermeiro, de Enfermeira Obstétrica ou de Obstetriz;
- IV - aqueles que, não abrangidos pelos incisos anteriores, obtiverem título de Enfermeiro, conforme o disposto na alínea *d* do art. 3º do Decreto n.º 50.387, de 28 de março de 1961. (Brasil, 1986)

O enfermeiro exerce todas as atividades de enfermagem, cabendo-lhe privativamente, conforme o art. 7º da Lei 7.498/86:

- a) direção do órgão de enfermagem, integrante da estrutura básica da instituição de saúde, pública e privada, e chefia de serviço e de unidade de enfermagem;
- b) organização e direção dos serviços de enfermagem e de suas atividades técnicas e auxiliares nas empresas prestadoras desses serviços.
- c) planejamento, organização, coordenação, execução e avaliação dos serviços da assistência de enfermagem; [...]
- h) consultoria, auditoria e emissão de parecer sobre matéria de enfermagem;
- i) consulta de enfermagem;
- j) prescrição da assistência de enfermagem;
- l) cuidados diretos de enfermagem a pacientes graves com risco de vida;
- m) cuidados de enfermagem de maior complexidade técnica e que exijam conhecimentos de base científica e capacidade de tomar decisões imediatas. (Brasil, 1986)

O profissional de enfermagem atua com autonomia e em consonância com os preceitos éticos e legais, técnico-científico e teórico-filosófico; exerce suas atividades com competência para promoção do ser humano na sua integralidade, segundo os princípios da ética e da bioética, e participa como integrante da equipe de enfermagem e de saúde na defesa das Políticas

Públicas, com ênfase nas políticas de saúde que garantam a universalidade de acesso, integralidade da assistência, resolutividade, preservação da autonomia das pessoas, participação da comunidade, hierarquização e descentralização político-administrativa dos serviços de saúde (Cofen, 2017).

As principais atribuições do enfermeiro escolar e sua especialização têm seu relato encontrado no Brasil na década de 1930. A saúde escolar desse período caracterizou-se por políticas públicas de saúde fiscalizadoras, impositivas e dominadoras e pela carência de profissionais de enfermagem com formação acadêmica. Coube, desta forma, ao serviço de saúde escolar “fiscalizar a saúde do escolar” (Rasche; Santos, 2013). No decorrer da história, a atuação da enfermagem na escola teve como propósito um caráter assistencialista. Atualmente, o enfermeiro no contexto escolar desenvolve ações de educação em saúde como atividades pedagógicas, buscando uma formação integral. (Pires *et al.*, 2012).

O papel do enfermeiro escolar varia entre os países, porém o objetivo de sua atuação é identificar necessidades e melhorar a saúde e o bem-estar dos alunos. De acordo com Muniz *et al.*:

Experiências internacionais mostram que os enfermeiros realizam intervenções com alunos, pais e funcionários da escola para promover a saúde e o sucesso acadêmico dos estudantes. Essas atividades contribuem para a diminuição do absenteísmo, aumento da adesão à imunização, melhoria do manejo de condições crônicas, prevenção de doenças, apoio na identificação e gerenciamento de problemas mentais e questões de saúde, bem como suporte psicossocial, permitindo assim que os estudantes permaneçam na escola e melhorem seu desempenho acadêmico (Muniz *et al.*, 2021, p.75).

Nesse sentido, o IFC, em sua política de atendimento aos estudantes, visa a um atendimento multiprofissional composto por docentes e profissionais das áreas de pedagogia, serviço social, psicologia, enfermagem, nutrição, odontologia, entre outras. A enfermagem contribui na educação integral, através das suas atividades de educação em saúde e atendimentos juntamente com a equipe multiprofissional, proporcionando ao educando cuidados de qualidade e acesso aos serviços de saúde, principalmente aos que se encontram em situação de vulnerabilidade.

Lima *et al.* (2014, p. 227) entendem que:

Promover a saúde, é olhar o indivíduo adolescente e o seu contexto social, possibilitando o acesso às informações sobre os malefícios do uso do álcool e drogas, incentivo a um aporte nutricional adequado, oferta de métodos contraceptivos, orientações sobre a sexualidade, a prática de atividades físicas e lazer para um bom desenvolvimento físico, emocional, intelectual e social. Essas ações englobam uma escuta diferenciada e focada nos problemas deste grupo, direcionando, assim, uma assistência embasada na promoção e prevenção de agravos.

Considera-se que o espaço escolar é um local primordial de práticas e ações de promoção e prevenção da saúde dos adolescentes, sendo esse tipo de atividade importante para a formação pessoal e profissional desses indivíduos, aumentando o interesse dos gestores em manter essas atividades de forma contínua (Assunção *et al.*, 2020).

Assunção *et al.* (2020) enfatizam as principais estratégias e metodologias utilizadas por enfermeiros na educação sobre saúde no ambiente escolar, entre elas: a oficina, o círculo de cultura e o teatro como estratégias bem sucedidas para discutir temas como drogas, violência e sexualidade. Analisou-se que, entre os temas trabalhados, perpassam dois grandes eixos: sexualidade e violência, além das discussões sobre o uso de drogas, higiene pessoal, desnutrição, entre outros, de importância nessa fase da vida.

As ações de saúde na escola devem contemplar: avaliação inicial (instrumento de coleta de dados sobre a saúde do adolescente); avaliação do crescimento e desenvolvimento (peso, altura, pressão arterial); ações de saúde bucal; avaliação da imunização; ações de saúde mental; prevenção de violências; prevenção do uso de drogas; prevenção de DST/AIDS; promoção da saúde sexual e reprodutiva; promoção da alimentação saudável e prática de atividade física, entre outras (Brasil, 2013).

É necessário um olhar integral e integrado para capacitar em saúde, ou seja, um trabalho multidisciplinar para trabalhar algumas temáticas, como, por exemplo: alimentação saudável, ações contra violência, higiene, segurança, planejamento familiar. Para a prevenção de aspectos de riscos, é importante desenvolver ações como verificação da carteira de vacinação, acidentes, situações de gravidez precoce, orientação sobre sexualidade e prevenção de doenças sexualmente transmissíveis (Kirsch *et al.*, 2022). Nesse sentido:

A(o) enfermeira(o) escolar é um(a) personagem presente nos centros de ensino em países desenvolvidos como o Reino Unido, França, Escócia, Suécia e os Estados Unidos há mais de 100 anos na história, ressaltando assim a função assistencial e a educação em saúde. Ter essa personagem nas escolas auxilia na solução de um problema que existe atualmente nos colégios, pois, estabelecer um profissional de enfermagem de referência em cada centro educativo é uma mais-valia, devido ao conhecimento e experiência profissional de saúde e promoção de estilos de vida saudáveis (Anjos *et al.*, 2022 a, p. 4).

O Decreto Presidencial n. 6.286, de 2007, institui o Programa Saúde na Escola (PSE), com orientações para promover a saúde e a educação integral para crianças e adolescentes. O PSE planeja contribuir para o fortalecimento de ações na perspectiva do desenvolvimento integral dos educandos e proporcionar à comunidade escolar a participação em programas e projetos que articulem saúde e educação, para o enfrentamento das vulnerabilidades que comprometem o pleno desenvolvimento de crianças e adolescentes. Possui ainda a

característica de reconhecer e acolher as ações de integração entre saúde e educação já existentes e tem impactado positivamente na qualidade de vida dos educandos (Brasil, 2013).

Anjos *et al.* (2022a) enfatizam que o(a) enfermeiro(a) contribui significativamente na vida dos estudantes, principalmente na fase da adolescência. O enfermeiro promove a adoção de práticas educativas, por meio de consultas de enfermagem, palestras e rodas de conversas. Sendo assim, enfatiza-se que, por meio dessas ações, o profissional de enfermagem consegue incentivar o autocuidado dos adolescentes, proporcionando conhecimentos sobre sua saúde, diminuindo, assim, os fatores de riscos e tornando pessoas com hábitos mais saudáveis, aumentando a qualidade de vida desse público.

A atuação do enfermeiro no espaço escolar contribui para uma formação integral, proporcionando ao estudante o conhecimento sobre saúde, o desenvolvimento crítico, a segurança, o autocuidado, além de estimular a prática de hábitos saudáveis. A atuação do enfermeiro proporciona um ambiente de acolhimento, onde o adolescente pode esclarecer suas dúvidas, seus questionamentos e garantia de seus direitos, possibilitando uma melhor qualidade de vida e bem-estar.

Anjos *et al.* (2022b, p. 9) entendem que:

O enfermeiro é o principal facilitador de ações de educação, segurança e promoção em saúde no ambiente escolar, atua desenvolvendo atividades de caráter preventivo, além de realizar orientações em saúde através da integralidade do cuidado, por meio do diálogo baseado na escuta ativa do aluno, e o incentivo a prática de hábitos saudáveis e do autocuidado.

Existem atividades de promoção à saúde voltadas para a população adolescente desenvolvidas em uma abordagem educativa preventiva na escola, que estimulam esses adolescentes a adotarem atitudes e valores que podem evitar situações de risco. Vê-se que processo de educação em saúde, enquanto uma das atribuições dos enfermeiros, estimula sua presença no ambiente escolar, favorecendo o processo de educação em saúde, assim como nos Institutos Federais de Educação Ciência e Tecnologia, que fazem parte da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, e contam com profissionais de Enfermagem de nível superior em muitas de suas unidades. (Assunção *et al.*, 2020).

O enfermeiro no ambiente escolar é fundamental para o desenvolvimento e crescimento dos discentes e para a promoção e prevenção da saúde de todos os envolvidos no espaço escolar. O perfil de cuidador e educador do profissional enfermeiro faz com que ele se sobressaia nos espaços pedagógicos, por facilitar a disseminação de informações sobre saúde e bem-estar. (Bastos *et al.*, 2021).

No IFC, a enfermagem possui seu Regimento Interno, regulamentado pela resolução n. 05/2019 Consuper, que dispõe sobre o Regimento Interno dos Serviços de Enfermagem no IFC. Esse tem como objetivo;

Organizar e normatizar o exercício da enfermagem no âmbito dos campi deste Instituto, e contém diretrizes básicas para o funcionamento do serviço na Instituição. Está amparado nas Normas Regulamentadoras dos Conselhos Federal e Regional de Enfermagem (COFEn e COREn-SC), no Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, aprovado pela Resolução Cofen n. 564/2017, na Lei no 7.498, de 25/06/1986, que dispõe sobre a regulamentação do exercício profissional da Enfermagem, e no Decreto no 94.406, de 08 de junho de 1987, que regulamenta a Lei n.º 7.498(IFC, 2019).

Em consideração, o regimento de enfermagem é coerente com a missão institucional, qual seja, proporcionar educação profissional, atuando em ensino, pesquisa e extensão comprometidos com a formação cidadã, a inclusão social e o desenvolvimento regional; com as características da população a ser assistida; com a disponibilidade e organização dos recursos humanos e materiais; e deve ser adotado por todos os profissionais da enfermagem lotados neste Instituto (IFC, 2019). Conforme o regimento de enfermagem:

A Equipe de Enfermagem atuará, preferencialmente, em ações preventivas e de promoção à saúde, direcionadas para a melhoria da qualidade de vida dos discentes, servidores e demais membros da comunidade escolar, por meio de palestras socioeducativas de orientação à saúde pessoal e coletiva, e participará das campanhas nacionais de combate às endemias e epidemias, dentre outras, conforme a necessidade observada em cada localidade, e segundo as ações pela Reitoria conforme calendário institucional (IFC, 2019).

Nesse sentido, a atuação da enfermagem no ambiente escolar faz muita diferença na vida dos discentes, pois mediante ações de educação em saúde, orientações e consultas de enfermagem, o enfermeiro poderá estimular hábitos de vida mais saudáveis, proporcionando aos adolescentes uma melhor qualidade de vida.

2.3 Educação profissional e tecnológica, Instituto Federal Catarinense e enfermagem

A educação e o trabalho fazem parte da história da humanidade. O homem, ao contrário dos outros seres vivos, são seres capazes de pensar e constroem relações sociais entre si e com a natureza para sua sobrevivência. Ao analisarmos as relações que os homens constroem ao longo da história, percebe-se que o trabalho está nas entrelinhas de todo o processo. O trabalho pode ser considerado parte da humanidade, incorporando todos os elementos que movem as relações da humanidade: linguagem, cultura, política, educação, ciência e técnica (Padoin; Amorim, 2016).

Sendo assim, na perspectiva da EPT, temos que esse modelo educacional visa a uma formação integral do ser humano, ou seja, em todas as dimensões da vida humana, preparando o estudante para o mundo do trabalho. O IFC, que faz parte da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica, conta com profissionais de enfermagem, que contribuem através das suas ações e atendimentos de saúde com a formação dos discentes para o mundo do trabalho, sendo considerados educadores em saúde.

Saviani (2007) apresenta relevantes contribuições teóricas capazes de compreender essa relação, especialmente ao afirmar que trabalho e educação são atividades peculiares aos seres humanos, os quais se diferenciam dos outros animais por meio da racionalidade e da ação sobre a natureza, para produzirem a própria existência. Nas comunidades primitivas, o homem adotava o modo de produção comunal e aprendia a produzir sua própria existência e a trabalhar, no ato dessas atividades. Ademais, apropriou-se coletivamente dos meios de produção para satisfazer suas necessidades e, dessa forma, os indivíduos trabalhavam, educavam-se, construíam e transmitiam o conhecimento às outras gerações.

O trabalho faz parte da humanidade e possibilita ao ser humano transformar a natureza para saciar suas necessidades, além de fazer o indivíduo demonstrar suas habilidades, iniciativas e ações, podendo também aperfeiçoá-las através dele. A ocupação tem muito sentido na vida do indivíduo, por ir além da sobrevivência e trazer dignidade, bem-estar, socialização, experiências, conhecimento, enfim, por completar o ser humano.

No Brasil, a formação para o trabalho iniciou-se no período da colonização do país. Conforme Vieira e Souza Junior (2016), os primeiros aprendizes foram os indígenas e os escravizados. Na época, os filhos dos colonos tinham uma educação propedêutica, ou seja, a preparação para darem continuidade nos estudos, visando a uma formação para serem os futuros dirigentes.

Nesse sentido, com a chegada da família real portuguesa, em 1809, foi criado o Colégio das Fábricas. Conforme destaca Moura (2007), esse fato marcou o início da educação profissional no Brasil. Ao longo do século XIX, outras instituições eminentemente privadas foram surgindo, como a Escola de Belas Artes (1816), os Asilos da Infância dos Meninos Desvalidos (1854) e o Instituto Comercial do Rio de Janeiro (1861). Ainda no século XIX, em 1858, surgiram os Liceus de Artes e Ofícios do Rio de Janeiro, Salvador, Recife, São Paulo, Maceió e Ouro Preto (Moura, 2007). Essas instituições tinham o caráter assistencialista, destinadas ao atendimento de crianças pobres e órfãs, com o intuito de auxiliar os meninos “desvalidos da sorte”, de maneira que não representassem risco algum para a sociedade. Aliado a isso, a intenção era igualmente formar trabalhadores para suprir a mão de obra dos setores da

economia que estavam em pleno desenvolvimento, com propostas direcionadas para o ensino de ofícios como sapataria, carpintaria etc. (Moura, 2007).

A educação profissional no Brasil tem, em sua origem, um caráter assistencialista, ou seja, buscou atender aqueles mais vulneráveis, com condições socioeconômicas precárias. Sendo assim, a EPT busca superar essa dualidade histórica. Como destaca Moura (2007, p. 6):

Diante disso, o início do século XX trouxe uma novidade para a história da educação profissional do país quando houve um esforço público de organização da formação profissional, modificando a preocupação mais nitidamente assistencialista de atendimento a menores abandonados e órfãos, para a da preparação de operários para o exercício profissional. Assim, em 1906, o ensino profissional passou a ser atribuição do Ministério da Agricultura, Indústria e Comércio, mediante a busca da consolidação de uma política de incentivo para preparação de ofícios dentro destes três ramos da economia.

Em 1909, o então presidente Nilo Peçanha criou as primeiras Escolas de Aprendizes Artífices para o ensino profissional, instituições estas consideradas precursoras das escolas técnicas federais, tendo como objetivo de formar operários e mão de obra, através do ensino prático-repetitivo, de conhecimentos básicos necessários à execução (Castro; Plácido; Schenkel, 2020).

A partir do processo de industrialização desencadeado na década de 1930, iniciou-se um período de significativa expansão, marcado por uma política de criação de novas escolas industriais e introdução de novas especializações nas escolas já existentes, uma vez que a educação popular passou a ser considerada um importante instrumento para o projeto de nação brasileira (Vieira; Souza Junior, 2016).

Em 1942, entrou em vigor a Reforma Capanema, trazendo as Leis Orgânicas da Educação Nacional, com o intuito de adequar os rumos da educação ao contexto político, econômico e social, bem como com o intuito de atender aos interesses econômicos da época (Schenkel, 2012).

Também em 1942 foi criado o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai), seguido do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac), em 1946, bem como dos demais “S” nos períodos seguintes, evidenciando a opção governamental daquele período pelo sistema de controle privado da educação profissional (Moura, 2007). O Sistema S visava atender às demandas oriundas da divisão social e técnica do trabalho, organizado sob a lógica do paradigma taylorista-fordista, de maneira que cada trabalhador fosse especialista na realização de apenas uma tarefa, fragmentando o processo e separando o trabalhador do produto de seu trabalho. A partir dessa lógica, o caráter dualista da educação foi novamente reafirmado, com a perspectiva do ensino secundário e normal destinado à formação das elites, enquanto o

ensino profissional seguia treinando adequadamente os filhos de operários para os ofícios (Moura, 2007).

Verificamos que a educação profissional se configurou por um caráter assistencialista. Nesse sentido, “à educação profissional foi marcada pelo caráter assistencialista, com proposta de atender especialmente os que tinham propensão ao ‘crime e vícios’, bem como os ‘desfavorecidos de fortuna’” (Padoin; Amorim, 2016, p. 5). Diante disso, percebemos uma dualidade histórica, em que os menos favorecidos eram preparados para o trabalho manual, enquanto o trabalho intelectual ficava reservado à elite.

A trajetória histórica da educação profissional apresentou uma perspectiva assistencialista, notadamente por amparar e acolher pobres e órfãos. Na Primeira República, com a proposta de um Estado intervencionista, a educação passou a ser entendida como necessária para o desenvolvimento do país, ensejando a criação da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica, em 1909 (Castro; Plácido; Schenkel, 2020).

No ano de 2003, início do governo Lula, houve a implementação, na área educacional, de políticas que se contrapõem às concepções neoliberais e abrem oportunidades para milhões de jovens e adultos da classe trabalhadora, buscando ampliar o acesso à educação, permanência e aprendizado nos sistemas de ensino. Algumas medidas foram tomadas como: criação do fundo de manutenção e desenvolvimento da educação básica e de valorização dos profissionais da Educação (Fundeb); criação do Programa Universidade para Todos (ProUni), maior programa de bolsas da história do país; criação da Universidade Aberta do Brasil (UAB), programa de cursos superiores à distância, além da abertura de mais de uma dezena de novos *campi* universitários e quatro novas universidades. Sendo assim, houve a ampliação de milhares de vagas nas Universidades públicas brasileiras e, ao mesmo tempo, encaminhou-se a criação dos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia (Pacheco, 2015).

Observamos que, ao longo da história, a educação profissional teve um caráter assistencialista e neoliberal, centrada em preparar os educandos para o mercado de trabalho. Atualmente, a EPT vem buscando superar esses paradigmas, centrando-se em uma educação inovadora, focada no desenvolvimento integral do ser humano. De acordo com Pacheco (2015, p. 12).

A Rede Federal, por sua excelência e vínculos com a sociedade produtiva, tem condições de protagonizar um projeto político-pedagógico inovador, progressista e capaz de construir novos sujeitos históricos, aptos a inserir no mundo do trabalho, compreendendo-o e transformando-o na direção de um novo mundo possível, capaz de superar a barbárie neoliberal e restabelecer o ideal da modernidade de liberdade, igualdade e fraternidade, sob a ótica das novas possibilidades abertas à humanidade neste princípio de século.

A Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica foi pensada na perspectiva de estimular o desenvolvimento regional, conter mobilidades inter-regionais e estimular a desconcentração industrial nas regiões tradicionalmente polarizantes, como o sudeste brasileiro, notadamente São Paulo e Rio de Janeiro. A Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica no Brasil é muito significativa e produz fluxos e dinâmicas em espaços que há muito não têm tanta visibilidade e desenvolvimento (Castro; Plácido; Schenkel, 2020).

O objetivo principal da EPT não é formar pessoas para o mercado de trabalho, mas sim para o mundo do trabalho, ou seja, um indivíduo que tanto pode ser um técnico quanto um escritor ou um filósofo. Atividades como música, artes plásticas, teatro e literatura devem fazer parte da formação dos nossos estudantes. Busca-se superar o preconceito de classes de que um trabalhador não pode ser um intelectual, um artista, ou seja, de que a universidade é um espaço para as elites e a escola técnica para os trabalhadores (Pacheco, 2015).

Diante disso, a EPT busca a superação da divisão de classes, do trabalho manual e do trabalho intelectual e da formação para atender às necessidades do mercado de trabalho, buscando formar um cidadão para a vida. Como também destaca Grinspun (2001, p. 92): “a educação tecnológica está baseada na concepção de uma educação transformadora, progressista que vai além de uma proposta de ensino na escola para aprofundar-se com o projeto político pedagógico da escola, nos dias atuais deve integrar as diferentes categorias do saber”. Nesse sentido, a enfermagem corrobora com a formação dos discentes, educando-os em saúde, formando-os cidadãos, com conhecimento do processo saúde/doença, tornando-os adultos mais saudáveis e multiplicadores desse conhecimento nos ambientes familiares, no trabalho, entre outros.

Para Saviani (2007), a educação no ensino médio, o conhecimento está relacionado ao processo do trabalho, os estudantes aprendem como a ciência e seus princípios são aplicados no processo produtivo, ou seja, não se quer formar técnicos especializados, mas politécnicos. Entende-se por “politécnicos” os que dominam os fundamentos científicos das diferentes técnicas utilizadas na produção moderna.

Observamos que no período de 2003 a 2010 houve uma expansão significativa na EPT, como destaca Pacheco (2015, p. 7) “a instalação, entre 2003 e 2010, de 214 novas escolas vem ampliar a Rede Federal na perspectiva de colaboração com os demais sistemas de ensino para fortalecimento da oferta de EPT e, ao mesmo tempo, encaminha-se a criação dos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia”.

Assim, instituíram-se, no Brasil, os Institutos Federais de Educação Profissional e Tecnológica, visando à unificação das unidades de ensino profissional em torno de um projeto

de educação nacional voltado não só para desenvolvimento de conhecimentos gerais, de ciências e das suas tecnologias, mas principalmente direcionado para o desenvolvimento do trabalho humano, englobando, assim, uma formação politécnica, ou seja, uma formação humana integral ou omnilateral (Feitosa, 2023). Segundo Pacheco (2010, p. 12):

Os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia são a síntese daquilo que de melhor a Rede Federal construiu ao longo de sua história e das políticas de educação profissional e tecnológica do governo federal. São caracterizados pela ousadia e inovação, necessárias a uma política, é um conceito que tem em vista antecipar, aqui e agora, as bases de uma escola contemporânea do futuro e comprometida com uma sociedade radicalmente democrática e socialmente justa.

O Instituto Federal Catarinense (IFC) foi criado pela Lei Federal n. 11.892, de 29 de dezembro de 2008, e teve origem na integração das escolas agrotécnicas de Concórdia, Rio do Sul e Sombrio e dos colégios agrícolas de Araquari e Camboriú, que eram vinculados à Universidade Federal de Santa Catarina (Brasil, 2008).

Hoje, a trajetória formativa do IFC se integra às demandas sociais e aos arranjos produtivos locais/regionais com cursos da educação profissional e tecnológica que compreendem: qualificação profissional, educação profissional técnica de nível médio, graduação e pós-graduação – *lato e stricto sensu*. O IFC possui atualmente 15 *campi*, distribuídos nas cidades de Abelardo Luz, Araquari, Blumenau, Brusque, Camboriú, Concórdia, Fraiburgo, Ibirama, Luzerna, Rio do Sul, Santa Rosa do Sul, São Bento do Sul, São Francisco do Sul, Sombrio e Videira, e a Reitoria, instalada na cidade de Blumenau (Brasil, 2008).

Os Institutos buscam superar o conhecimento fragmentado que perdurou por muitos séculos, tendo como objetivo reunir de forma conjunta a educação, o trabalho, a ciência e a tecnologia, com foco na formação do ser humano integral, no trabalho e na pesquisa como princípios educativos e científicos, superando a ideia do trabalho para produção, ou seja, de formar o indivíduo apenas para o mercado de trabalho.

De acordo com Pacheco (2015, p. 25):

A referência fundamental para a educação profissional e tecnológica é o ser humano e, por isso, o trabalho, como categoria estruturante do ser social, é seu elemento constituinte. Trata-se, pois, de uma formação que se dá no decorrer da vida humana, por meio das experiências e conhecimentos, ao longo das relações sociais e produtivas. A educação para o trabalho nessa perspectiva se entende como potencializadora do ser humano, enquanto integralidade, no desenvolvimento de sua capacidade de gerar conhecimentos a partir de uma prática interativa com a realidade, na perspectiva de sua emancipação.

No âmbito do IFC, a enfermagem integra uma equipe multiprofissional de assistência estudantil instituída pelo Decreto 7.234/2010, que dispõe sobre o Programa Nacional de

Assistência Estudantil. Os profissionais de enfermagem compõem o quadro de servidores Técnicos Administrativos da Educação (TAEs), vinculados à assistência estudantil em diversos Institutos. No IFC, esses profissionais encontram-se lotados no setor de Serviço Integrado de Suporte de Acompanhamento Educacional (Sisae) dos *campi* (Brasil, 2010).

A assistência estudantil, na perspectiva de educação, é vista como direito e compromisso com a formação integral do estudante. É uma política pública que estabelece um conjunto de ações que buscam contribuir para o melhor desempenho acadêmico dos estudantes, reduzir as desigualdades socioeconômicas, promover a justiça social e a permanência e êxito durante a formação dos estudantes (Brasil, 2010).

O acompanhamento aos estudantes, no IFC, é disciplinado pela Resolução n. 022/2022, que estabelece a Política de Atendimento ao Estudante do IFC. Essa política de atendimento fundamenta-se em um conjunto de princípios e objetivos norteadores de programas e ações que visam promover o acolhimento, a permanência e o êxito dos estudantes na instituição, tendo em vista a promoção do atendimento integral e interdisciplinar ao estudante, visando colaborar com o processo de ensino-aprendizagem, a saúde, o bem-estar, a permanência e o êxito estudantil (IFC, 2022).

Os programas e ações são desenvolvidos diretamente nos *campi* por equipe multiprofissional composta por docentes e profissionais das áreas de pedagogia, serviço social, psicologia, enfermagem, nutrição, odontologia, medicina, entre outras. Inúmeras atividades e programas compõem a política de atendimento aos discentes ofertadas conforme particularidades dos *campi* (IFC, 2022).

A política de atendimento ao estudante do IFC, em sua seção III, que trata da promoção da saúde, diz que “é dever do IFC zelar pelo bem-estar e promover a saúde dos estudantes” (IFC, 2022). Nesse sentido, o atendimento de enfermagem no IFC está seguindo a missão dos Institutos Federais, ao visar ao atendimento sistemático e integral do ser humano com priorização de trabalhar a promoção e prevenção da saúde do indivíduo e coletividade (IFC, 2022)

Conforme a Resolução n. 5/2019 Consuper, de 22 de março de 2019:

Entende-se como Atendimento Ambulatorial de Enfermagem do Instituto Federal Catarinense a assistência de enfermagem prestada aos membros da comunidade interna da instituição (alunos e servidores), segundo os recursos humanos e materiais disponíveis, conforme missão, visão e valores institucionais, que visam proporcionar educação profissional, atuando em ensino, pesquisa e extensão comprometidos com a formação cidadã, a inclusão social e o desenvolvimento regional. Consideram-se, ainda, os princípios de respeito ao paciente e à família, visando à promoção da saúde e à prevenção de doenças, baseadas no conhecimento técnico-científico, na ética e

humanização, na integração e no trabalho em equipe dos profissionais de enfermagem (IFC,2019).

O serviço de enfermagem do IFC está atualmente distribuído por diversos *campi*: Araquari, Camboriú, Concórdia, Rio do Sul, Santa Rosa do Sul e Videira, sendo vinculado ao Sisae. Nos *campi* onde não há enfermeiro(a), o atendimento ocorre pelos profissionais que integram a equipe multidisciplinar. Na Reitoria, o serviço de enfermagem está subordinado à Diretoria de Gestão de Pessoas (IFC, 2019).

O Serviço de Enfermagem no IFC “atuará, preferencialmente, em ações preventivas e de promoção da Saúde, direcionadas à melhoria da qualidade de vida dos discentes, servidores e demais membros da comunidade escolar, por meio de oficinas, palestras socioeducativas, de orientação pessoal e coletiva” (IFC, 2019). Segundo Brunner e Suddarth (2005, p. 26): “Os programas de Saúde Escolar fornecem serviços valiosos para os alunos e também podem servir à comunidade escolar. As crianças e adolescentes com problemas de saúde estão em risco de ter um desempenho deficiente ou ineficiente na escola”. Nesse sentido, percebemos como é importante a atuação do serviço de saúde na escola, ao contribuir para o sucesso do aprendizado e para uma formação integral.

Ações de educação em saúde na escola devem ser planejadas, definindo pontos prioritários, com temáticas de promoção da saúde como alimentação saudável, higiene bucal, saúde sexual e reprodutiva, prevenção de DST/AIDS, prevenção da gravidez na adolescência, prática de atividade física, etc. (Brasil, 2013).

O ambiente escolar é um espaço para múltiplos aprendizados: “Considera-se que o espaço escolar é um dos importantes lócus cenários de práticas e ações de promoção e prevenção da saúde dos adolescentes, sendo esse tipo de atividade importante para a formação pessoal e profissional desses indivíduos” (Assunção *et al.*, 2020, p. 6).

Anjos *et al.* (2022 a, p. 5) enfatizam que:

Diante da experiência no contexto escolar e depois da leitura de textos sobre a temática, percebeu-se que o enfermeiro contribui significativamente na vida dos estudantes, principalmente na fase da adolescência. O enfermeiro é muito importante na adoção de práticas educativas, por meio de consultas de enfermagem, palestras e rodas de conversas. Visto isso, salienta-se que por meio dessas ações o profissional de enfermagem consegue incentivar o autocuidado dos adolescentes, proporcionando conhecimentos sobre sua saúde, diminuindo assim os fatores de riscos e aumentando a qualidade de vida desse público-alvo.

A atuação do enfermeiro no ambiente escolar contribui para o ensino-aprendizagem, permanência e êxito dos estudantes na escola, estimulando os adolescentes a adotarem mudanças no estilo de vida, hábitos mais saudáveis, na promoção e prevenção da saúde, e

consequentemente, melhora em sua qualidade de vida. Portanto, a atuação da enfermagem na escola contribui com a educação omnilateral proposta pelos IF através das suas ações de educação em saúde, tanto coletivas como individuais, inseridas nas políticas educacionais de permanência estudantil e das políticas de saúde.

2.4 Sistematização da assistência de enfermagem e registros da assistência

Historicamente, a prática da enfermagem passou por grandes transformações técnicas e científicas, saindo do modo empírico para o científico. Esse fato contribuiu para o desenvolvimento da profissão. Com isso, surgiu a Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE), que se trata de uma metodologia de trabalho dos profissionais da enfermagem que proporciona desenvolver habilidades de modo sistematizado, organizado e planejado que se reflete diretamente na qualidade da assistência prestada à pessoa, à família e à coletividade.

Desta forma, a SAE sistematiza, organiza o serviço de enfermagem quanto ao método, pessoal e instrumento (manuais, protocolos e regimentos), dando possibilidades para a realização do PE, que também é denominado por alguns autores de consulta de enfermagem. A SAE também pode ser entendida como uma ferramenta metodológica utilizada a fins de tornar a assistência de enfermagem sistematizada, com o objetivo de orientar a equipe de enfermagem quanto à promoção da qualidade da assistência prestada (Feitosa, 2023).

Percebe-se a relevância da SAE para uma assistência de enfermagem de qualidade, como destaca Feitosa (2023, p. 31):

A SAE foi construída, utilizando como fundamentação diferentes teorias pensadas e escritas por grandes estudiosos da enfermagem, ficando para trás, uma enfermagem, centrada no modelo biomédico, ou seja, ações pautadas na doença, meramente executora de tarefas. A enfermagem atual busca uma assistência descentralizada com decisões consensuais, uma gestão inovadora e flexível do trabalho em equipe por meio da SAE.

A SAE é regulamentada no Brasil pela Resolução n. 358/2009 do Conselho Federal de Enfermagem (Cofen), preconizando que sua implantação deve ocorrer em todas as unidades de atendimento à saúde que ofereçam assistência de enfermagem. O PE deve ser realizado de modo deliberativo e sistemático em todos os ambientes, públicos ou privados, em que ocorre o cuidado de Enfermagem, sejam Hospitais, Instituições, domicílios, escolas, associações comunitárias, fábricas, entre outras. Nesse contexto, o PE é denominado como consulta de enfermagem.

Conforme Resolução n. 358/2009 do Cofen;

O processo de enfermagem é um instrumento metodológico que orienta o cuidado profissional de enfermagem e a documentação da prática profissional. O processo de Enfermagem organiza-se em cinco etapas:

I - Coleta de dados de Enfermagem ou Histórico de Saúde - processo deliberativo, sistemático e contínuo, realizado com auxílio de métodos e técnicas variadas, que tem por finalidade a obtenção de informações do processo saúde/doença sobre a pessoa, família ou coletividade.

II - Diagnóstico de Enfermagem - processo de interpretação e agrupamento dos dados coletados na primeira etapa, que culmina com a tomada de decisão sobre os conceitos diagnósticos de enfermagem que representam, com mais exatidão, as respostas da pessoa, família ou coletividade em um dado momento do processo saúde e doença, e constitui a base para seleção de ações ou intervenções com as quais se objetiva alcançar os resultados esperados.

III - Planejamento de Enfermagem - determinação de ações e intervenções que serão realizadas face às respostas da pessoa, família ou coletividade humana em um dado momento do processo saúde e doença.

IV - Implementação - realização das ações ou intervenções determinadas no planejamento de enfermagem.

V - Avaliação/Evolução de Enfermagem - processo deliberativo, sistemático e contínuo de verificação de mudanças na pessoa, família ou coletividade em um dado momento do processo saúde e doença para determinar se as ações ou intervenções de enfermagem alcançaram os resultados esperados; e de verificação da necessidade de mudanças ou adaptações nas etapas do processo de enfermagem (Cofen, 2009).

A SAE organiza o serviço de enfermagem, dando possibilidades para a atuação do PE, que também é denominado por alguns autores de consulta de enfermagem, o qual se refere a uma ferramenta metodológica utilizada a fins de tornar a assistência de enfermagem sistematizada, com a finalidade de orientar a equipe de enfermagem quanto à promoção da qualidade da assistência prestada, pois o cuidado deixa de ser empírico e passa a ser baseado em evidências científicas. Isso se deve ao raciocínio clínico e à tomada de decisões do enfermeiro para o diagnóstico de enfermagem e os resultados obtidos quanto às intervenções prescritas (Dias *et al.*, 2022).

Abreu e colaboradores (2020) concluíram em seu estudo “Percepção das adolescentes sobre a consulta de Enfermagem na Atenção Básica” que para as adolescentes, a consulta de enfermagem representa uma forma de esclarecimento de dúvidas sobre saúde, além de promover um vínculo de confiança da adolescente com o enfermeiro. Nos relatos, ficou evidente a importância da consulta de enfermagem por possibilitar questionamentos e conversar sobre assuntos considerados íntimos. Desta forma, a consulta de enfermagem ao adolescente se apresenta como uma tecnologia leve de intervenção da realidade, por meio da promoção da escuta e diálogo, tendo o próprio adolescente como protagonista nas suas escolhas que influenciam o processo de saúde-doença.

Assim, o IFC que faz parte da rede federal de educação profissional e tecnológica e visa uma formação integral do educando, conta com profissionais de enfermagem em diversos Campi, e importante que o trabalho desses profissionais seja sistematizado, padronizados, pois

isso, gera segurança para os profissionais, além de aumentar a qualidade da assistência de enfermagem para a comunidade acadêmica.

Segundo Smeltzer e Bare (2005, p. 53): “As etapas do processo de enfermagem: histórico, diagnóstico, planejamento, implementação e evolução são empregadas quando se constrói um plano de ensino para satisfazer as necessidades de ensino e aprendizado de um indivíduo”. A SAE, através do processo de enfermagem, contribui para a formação integral, por ocorrer o ensino e aprendizagem sobre o processo saúde e doença do indivíduo, família e coletividade, tanto relativamente à pessoa quanto ao coletivo, através das ações ou intervenções de prevenção e promoção da saúde.

O registro de enfermagem é um dos mais importantes instrumentos de comunicação. A comunicação, através das anotações de enfermagem, é imprescindível para a atuação da enfermagem. Nesse sentido:

Entende-se que os registros são elementos imprescindíveis no processo do cuidar humano e, quando redigidos de maneira que retratam a realidade a ser documentada, possibilitam a comunicação permanente, podendo destinar-se a diversos fins como ensino, pesquisas, processos jurídicos, planejamento e outros (Oliveira; Cadette, 2009, p. 302).

A Resolução Cofen n. 514/2016 “trata da necessidade de nortear os profissionais de enfermagem para a prática dos registros de enfermagem no prontuário do paciente, garantindo a qualidade das informações que serão utilizadas por toda equipe de saúde da Instituição” (Cofen, 2016b, p. 10). A anotação dos cuidados de enfermagem é extremamente importante por fornecer subsídios ao enfermeiro e aos demais profissionais de enfermagem quanto ao planejamento de ações, intervenções e conduta, além de uma análise dos cuidados prestados e a resposta do paciente. Frente aos avanços tecnológicos, ressalta-se a importância de um sistema informatizado para registros da assistência de enfermagem no IFC.

A Resolução Cofen n. 564/2017, em seu capítulo III, artigos 36 a 38, considera como dever:

Art. 36 Registrar no prontuário e em outros documentos as informações inerentes e indispensáveis ao processo de cuidar de forma clara, objetiva, cronológica, legível, completa e sem rasuras.

Art. 37 Documentar formalmente as etapas do processo de Enfermagem, em consonância com sua competência legal.

Art. 38 Prestar informações escritas e/ou verbais, completas e fidedignas, necessárias à continuidade da assistência e segurança do paciente (Cofen, 2017).

Já a Resolução Cofen n. 429/2012, em seu texto principal, traz alguns fatos relevantes à prática de enfermagem na aplicação e execução das anotações de enfermagem:

Art. 1º É responsabilidade e dever dos profissionais da Enfermagem registrar, no prontuário do paciente e em outros documentos próprios da área, seja em meio de suporte tradicional (papel) ou eletrônico, as informações inerentes ao processo de cuidar e ao gerenciamento dos processos de trabalho, necessárias para assegurar a continuidade e a qualidade da assistência (Cofen,2012).

Os registros de enfermagem são fundamentais para atuação da enfermagem, pois através deles conseguimos conhecer melhor o histórico de saúde do estudante, suas condições sociais, psicológicas e familiares. Diante disso, podemos fazer um planejamento de assistência, tanto individual como coletivo para nossos estudantes, melhorando a qualidade da assistência de enfermagem para os discentes, além de oferecer segurança aos profissionais de enfermagem e aos estudantes e familiares.

Na área da saúde, diversas instituições, como as Unidades Básicas de Saúde (UBS), hospitais e ambulatórios, já dispõem de sistemas informatizados para registro, processamento, análise de dados e transmissão da informação, como exemplo o Sistema de Informação da Atenção Básica (Siab), E-SUS Hospitalar, Sistemas de Informações Ambulatoriais do SUS (SIA), entre outros. O IFC ainda não dispõe de um sistema padronizado de registro, muito menos um sistema informatizado de registros da assistência à saúde. Os profissionais enfermeiros atuam em um processo de produção de informação e de comunicação constantemente, para isso é necessário um processo sistematizado, com facilidade quanto a sua análise, com vistas à geração de conhecimento, definição de condutas, encaminhamentos e acompanhamento de fluxos de atendimentos.

Azevedo *et al.* (2019) concluíram em seu estudo sobre “Documentação do Processo de Enfermagem em Instituições Públicas” que a maioria dos setores estudados documenta o PE e faz anotações de enfermagem, mas há setores onde a documentação não corresponde às exigências formais. A viabilidade da documentação de todas as fases do PE em determinados tipos de setores precisa ser mais bem estudada. Sendo assim, é importante no IFC uma padronização dos registros de enfermagem, buscando cumprir com as exigências formais.

Godoi *et al.* (2012, p. 4) entendem que:

A necessidade da existência de um documento no qual as informações relativas ao histórico de saúde do indivíduo fossem registradas não é nova. A palavra prontuário, é originária do latim *Promptuarium* e significa local no qual as coisas são guardadas ou depositadas, aquelas que serão necessárias a qualquer momento. Os prontuários são elementos essenciais para o desenvolvimento de atividades de administração de qualquer unidade de saúde, para os cuidados e a atenção aos pacientes e, ainda, para subsidiar pesquisas. O prontuário torna-se, progressivamente, um repositório de informações.

O suporte impresso foi por muito tempo o único dispositivo utilizado para armazenar as informações desse tipo de documento. Nas últimas décadas, o surgimento e proliferação de

novas tecnologias contribuíram para que os prontuários não fossem somente um repositório de informações. Com o uso mais frequente dos computadores nos mais diversos centros de saúde e hospitais, cada vez mais se observa que o enfermeiro utiliza esses recursos. Além disso, o uso da tecnologia tem colaborado na eficiência com vistas à obtenção de maiores vantagens, entendendo que o volume de informações com que se trabalha nos dias atuais torna a documentação manual cada vez mais ineficiente, incompleta, e o seu uso ineficiente pode comprometer o resultado do atendimento aos usuários dos sistemas de saúde (Godoi *et al.*, 2012).

Ávila *et al.* (2022) apontam em seu estudo que o Prontuário Eletrônico (PE) permite ao profissional conhecer mais detalhadamente o usuário, suas condições clínicas, sua família, seu contexto social e seu histórico de atendimentos, além das situações de saúde presentes no território onde atua. Diferentemente do prontuário em papel, no qual as anotações eram livres e não padronizadas, o PE introduziu um modelo de registro que requer a inclusão de mais informações e representa um avanço na gestão do cuidado na atenção básica, por ter se concretizado como uma ferramenta que potencializa o planejamento do cuidado em saúde e que contribui para a construção do vínculo entre profissional e paciente, auxiliando na organização do fluxo do cidadão no sistema, na qualidade do atendimento, no aprimoramento da comunicação no âmbito da equipe do usuário, contribuindo para disponibilizar ao profissional informações mais qualificadas e completas.

Desta forma, infere-se que o PE se concretiza como ferramenta que potencializa o planejamento do cuidado em saúde, ao contribuir para o conhecimento mais aprofundado da realidade de cada usuário e de suas necessidades de cuidado. A SAE é um instrumento importante na atuação do enfermeiro, ao organizar o cuidado.

Soares *et al.* (2015) mostram em seu estudo pontos facilitadores e desafiadores, em que os participantes consideram a SAE facilitadora para o planejamento e organização da assistência, porém, apontam a existência interna de algumas dificuldades para sua implementação. Contudo, o sucesso da operacionalização da SAE se dá por meio de um desenvolvimento mútuo.

Nesse sentido, percebemos a importância da SAE para a organização da assistência de enfermagem. Segundo Hermida (2006), o planejamento da SAE deve sofrer as adequações necessárias a cada contexto institucional, pois realidades distintas podem apresentar exigências também distintas. Exemplificando, uma instituição que tem um serviço de enfermagem organizado com filosofia, missão e objetivos, pode subtrair tal etapa do seu processo de implantação. A assistência de enfermagem deve corresponder às metas do serviço de

enfermagem e da organização, ou seja, é necessária coerência na filosofia, metas e objetivos da organização, do serviço de enfermagem e da unidade.

Nesse sentido, no ambiente escolar é necessário organizarmos e adaptarmos o PE conforme especificidades do nosso público atendido. Importante esclarecer que a anotação de enfermagem é realizada por toda a equipe de enfermagem (técnicos, auxiliares) enquanto a evolução de enfermagem é uma atividade privativa do enfermeiro.

3 METODOLOGIA

3.1 Delimitação da pesquisa

O estudo, do ponto de vista da sua natureza, foi desenvolvido como uma pesquisa translacional, devido estabelecer a conexão entre a pesquisa básica e a aplicada, a partir de um problema concreto do ambiente do exercício profissional do pesquisador, gerando produtos e práticas.

A pesquisa translacional “busca construir pontes entre conhecimentos acadêmicos gerados na pesquisa em educação e ensino para sua aplicação em produtos e processos educativos voltados às demandas da sociedade e às necessidades regionais e nacionais” (Capes, 2019, p. 3).

Quanto à abordagem de pesquisa, trata-se de uma pesquisa qualitativa, pois a pesquisa qualitativa visa entender o fato na totalidade, na sua complexidade, utilizando dados subjetivos, uma vez que:

A pesquisa qualitativa não procura enumerar e/ ou medir os eventos estudados, nem emprega instrumental estatístico na análise dos dados. Parte de questões ou focos de interesses amplos, que vão se definindo à medida que o estudo se desenvolve. Envolve a obtenção de dados descritivos sobre pessoas, lugares e processos interativos pelo contato direto do pesquisador com a situação estudada, procurando compreender os fenômenos segundo a perspectiva dos sujeitos, ou seja, dos participantes da situação em estudo (Godoy, 1995, p. 58).

Do ponto de vista dos objetivos, a pesquisa se apresentou como exploratória, tendo em vista que:

Este tipo de pesquisa visa proporcionar maior familiaridade com o problema, com vistas a torná-lo mais explícito ou a construir hipóteses. A grande maioria dessas pesquisas envolve: (a) levantamento bibliográfico; (b) entrevistas com pessoas que tiveram experiências práticas com o problema pesquisado; e) análise de exemplos que estimulem a compreensão (Gil, 2002, p. 25).

Em relação aos procedimentos técnicos, esta pesquisa é considerada de campo, pois a pesquisa de campo, conforme enuncia Fonseca (2002, p. 32) “caracteriza-se pelas investigações em que, além da pesquisa bibliográfica e/ou documental, se realiza coleta de dados junto a pessoas, com o recurso de diferentes tipos de pesquisa.”

O público envolvido na pesquisa foi composto por os enfermeiros que atuam na Assistência de Enfermagem no Instituto Federal Catarinense (IFC), em efetivo exercício em 2023.

3.2 Coleta de dados

A coleta de dados realizou-se no período de junho a agosto de 2023, por meio de entrevista semiestruturada com os profissionais enfermeiros que atuam na assistência de enfermagem no IFC.

Essas entrevistas ocorreram com duração aproximada de 60 minutos cada, realizadas de maneira *on-line*, por meio da plataforma virtual *Google Meet* e gravadas através do programa *Open Broadcaster Software* (OBS Studio).

Plataformas virtuais foram aplicadas em virtude da localização dos *campi* do IFC, distribuídos ao longo de todo estado de Santa Catarina. Optou-se, assim, pela realização da entrevista de maneira *online*, evitando o deslocamento da pesquisadora a várias cidades diferentes. Os recursos tecnológicos disponíveis atualmente, como aplicativos de videoconferência, câmeras de alta resolução e internet de alta velocidade, permitem que a conversa com o entrevistado possa acontecer de forma fluída e produtiva, mesmo à distância. Além disso, com o recurso de gravação da entrevista, foi possível analisar, após a coleta, as falas e expressões, garantindo mais precisão na coleta de dados.

As entrevistas foram gravadas, transcritas e armazenadas em um arquivo digital, ou seja, um HD externo, pertencente à pesquisadora, acessado exclusivamente pela pesquisadora e sua orientadora. As entrevistas foram transcritas com o auxílio do programa computacional “MAXQDA”, que é um *software* de análise de dados qualitativos, com integração à Inteligência Artificial e que possibilita a transcrição automática, o que auxilia nos processos de transcrições. Ele proporciona o suporte a vários tipos de transcrições, incluindo literal e não literal. Nesta pesquisa foi utilizada a opção literal, a qual captura cada palavra, incluindo pausas e expressões não verbais. A tecnologia de transcrição do MAXQDA auxilia nas transcrições literais, garantindo um registro abrangente do conteúdo falado (VERBI, *Software* MAXQDA, 2024).

O roteiro da entrevista foi baseado em cinco tópicos assim distribuídos: na parte I do roteiro da entrevista, foram levantados dados de caracterização dos participantes da pesquisa, como por exemplo, nome, idade, cargo, tempo de atuação no serviço público e na enfermagem e na enfermagem escolar. Na parte II do roteiro foram abordadas perguntas sobre experiência profissional na Educação Profissional e Tecnológica; na parte III, a entrevista abordou a forma de anotações/registros das ações a atuação da enfermagem na EPT/IFC/ESCOLA; na parte IV, a entrevista tratou de questões sobre as ações de educação em saúde e na parte V abordamos sobre o entendimento da educação profissional e tecnológica proposta pelos IFs. O roteiro de entrevista está inserido em sua íntegra em Apêndice A e o Termo de Consentimento Livre

Esclarecido (TCLE) em Apêndice B. As entrevistas foram conduzidas com perguntas abertas, agrupadas conforme a finalidade dos dados que se pretendia obter.

Para realização do referencial bibliográfico, foram utilizados livros de enfermagem, legislações/resoluções federais e do IFC, materiais como artigos, referentes ao tema de pesquisa na plataforma *Scielo*, utilizando os descritores: “atuação enfermeiro e equipe multiprofissional”, “atuação enfermeiro e saúde pública”, “enfermagem”, “prontuário eletrônico”, “história da enfermagem”, “enfermagem e prontuário eletrônico”, “profissão de enfermagem”, “atenção à saúde na escola”, “sistematização de enfermagem”, “processo de enfermagem”, “sistematização da assistência de enfermagem”, “enfermagem e educação”, “atuação enfermeiro na escola/educação”, “registros de enfermagem”, “importância dos registros de enfermagem”, “anotações de enfermagem” entre outros, além de materiais referenciados das disciplina do mestrado.

3.3 Análise dos dados

Os dados foram analisados através da análise de conteúdo proposta por Bardin (2016), na modalidade temática, com as categorias e codificação definidas *a posteriori* indutiva. Análise de Conteúdo é o:

[...] conjunto de técnicas da análise das comunicações visando obter por procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das mensagens e indicadores (quantitativos ou não) que permitam a inferência de conhecimentos relativos às condições de produção/recepção (variáveis inferidas) dessas mensagens (Bardin, 2016, p. 48).

Para Bardin (2016), a organização da análise de conteúdo dá-se por diferentes fases, distribuídas em uma ordem cronológica tripla. Estes “pólos cronológicos” são, segundo o autor (2016, p. 125): “1) a pré-análise; 2) a exploração do material; 3) o tratamento dos resultados, a inferência e a interpretação”.

Bardin (2016, p. 125) sintetiza a pré-análise nos seguintes termos:

Geralmente, esta etapa possui três missões: escolha dos documentos a serem submetidos à análise, a formulação de hipóteses e dos objetivos e a elaboração de indicadores que fundamentam a interpretação final. Estes três fatores não se sucedem, obrigatoriamente, segundo uma ordem cronológica, embora se mantenham estreitamente ligados uns aos outros”. A escolha de documentos depende dos objetivos, ou, inversamente, o objetivo só é possível em função dos documentos disponíveis; os indicadores serão construídos em função das hipóteses, ou, pelo contrário, as hipóteses serão criadas na presença de certos índices.

Essas missões descritas pelo autor foram alcançadas com a elaboração e a aplicação dos instrumentos de coleta de dados, as transcrições das entrevistas, a definição das hipóteses e dos

objetivos a serem alcançados com a interpretação das entrevistas e o desenvolvimento do produto educacional, somados à avaliação do produto educacional, que trouxe subsídios para a interpretação da viabilidade e eficácia deste último.

O *corpus* é o conjunto dos documentos a serem submetidos aos procedimentos analíticos. A sua constituição implica, muitas vezes, escolhas, seleções e regras. É fundamental observar algumas regras: a) exaustividade, sugere-se esgotar todo o assunto sem omissão de nenhuma parte; b) representatividade, preocupa-se com amostras que representem o universo; c) homogeneidade, nesse caso os dados devem referir-se ao mesmo tema, serem coletados por meio de técnicas iguais e indivíduos semelhantes; d) pertinência, é necessário que os documentos sejam adaptados aos objetivos da pesquisa e e) exclusividade, um elemento não deve ser classificado em mais de uma categoria.

Primeiramente, foi realizada a pré-análise com a constituição do *corpus*, que foi as transcrições das entrevistas. Após isso, foi feita a codificação com o auxílio do programa MAXQDA2024. Os códigos gerados pelo programa foram revisados, selecionados quanto à sua frequência e interpretados e apresentados quanto à sua informação principal. Segundo Flick (2009), o avanço da tecnologia também trouxe mudanças na pesquisa qualitativa. Desde 1980, iniciaram-se avanços tecnológicos com a introdução de computadores na pesquisa qualitativa.

Atualmente, existe uma variedade de programas de *software* disponíveis, entre eles o MAXQDA, que auxilia nos processos de análises e transcrições da pesquisa qualitativa. O MAXQDA auxilia a pesquisa qualitativa, mas não a realiza nem a automatiza, embora esse auxílio possa representar um impacto sobre a pesquisa. Como ainda é o autor que escreve por meio da utilização do processador de textos, é, ainda, o pesquisador que realiza a codificação etc., com o uso do MAXQDA. As categorias foram criadas através da análise do centro de informações presentes nos tópicos de entrevista, gerando as categorias a serem discutidas.

3.4 Produto educacional

As percepções encontradas na pesquisa deram embasamento para a construção do produto educacional, definido como um prontuário unificado para uso pelos profissionais da enfermagem do IFC e um cronograma de ações de educação para a prevenção e promoção à saúde, que está inserido, na íntegra, no Apêndice C.

O prontuário unificado será utilizado para os registros da assistência de enfermagem. Ele busca contemplar todas as etapas do PE, tais como: anamnese (histórico de saúde), exame físico, diagnóstico, prescrição, implementação e avaliação/evolução de enfermagem. O cronograma de ações de educação em saúde foi proposto mensalmente, com ações pensadas no

público de estudantes adolescentes, contemplando as campanhas nacionais e considerado espaço para ações específicas de cada *campus*.

Nesse sentido, com um prontuário unificado e com ações de educação em saúde padronizadas, respeitando as especificidades de cada local, contribui-se com a educação integral proposta pela EPT.

3.5 Avaliação do produto educacional

Os produtos educacionais foram enviados aos participantes da pesquisa via *e-mail* para análise. Após 15 dias, realizamos um grupo focal para a análise e debate sobre as informações sobre a forma de aplicação dos produtos. A avaliação ocorreu através de um questionário com perguntas objetivas e discursivas via *Google Forms*. As respostas do questionário foram avaliadas e apresentadas em forma de gráficos e discutidas quanto à aceitação ou à rejeição do produto educacional, bem como foram feitas considerações e sugestões para a sua melhoria. O questionário de avaliação está inserido em sua íntegra no Apêndice E.

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

A pesquisa foi realizada com os enfermeiros que atuam na Assistência de Enfermagem, no Instituto Federal Catarinense (IFC), em efetivo exercício em 2023, mediante entrevista semiestruturada. Com a pesquisa, buscamos compreender a percepção do enfermeiro quanto às suas atividades no sistema de registro da assistência de enfermagem e das ações educativas em saúde na contribuição para a educação integral dos discentes. As entrevistas foram gravadas, transcritas e armazenadas em um arquivo digital, ou seja, um HD externo pertencente à pesquisadora, acessado exclusivamente pela pesquisadora e sua orientadora. A pesquisa tem a aprovação do Comitê de Ética para Pesquisas com Seres Humanos – CEPESH-IFC sob a identificação do Certificado de Apresentação de Apreciação Ética (CAAE): 71119523.5.0000.8049.

Ao longo do texto, foram apresentadas as transcrições literais de suas falas, sendo que cada participante da entrevista recebeu uma identificação alfanumérica, representando o número do entrevistado, como por exemplo, o entrevistado 1 foi identificado como E1 e assim sucessivamente.

Os códigos foram produzidos com o objetivo de compreender a percepção dos enfermeiros sobre suas atividades no sistema de registro da assistência de enfermagem e sobre as ações educativas em saúde na contribuição para a educação integral. Para isso, analisamos as respostas dos diferentes participantes da pesquisa para a mesma pergunta através do programa computacional MAXQDA2024, e agrupamos os códigos pelos tópicos da entrevista. Após isso, os códigos foram analisados pela pesquisadora e selecionados em ordem de frequência.

A categorização foi realizada agrupando os códigos semelhantes em uma classe de significado, gerando três grandes categorias: I - Atuação do enfermeiro no ambiente escolar, II - Sistematização da assistência de enfermagem no ambiente escolar e III - Contribuições do enfermeiro escolar na educação integral.

Os resultados serão apresentados em seções dispostas da seguinte forma: Caracterização dos participantes da pesquisa, com dados coletados do roteiro da entrevista do tópico I (Caracterização dos participantes da pesquisa). Segue-se com as categorias da análise de conteúdo: Categoria I – Atuação do enfermeiro no ambiente escolar, realizado com dados obtidos das entrevistas com o tópico II do roteiro de entrevista (Experiência profissional na Educação Profissional e Tecnológica). Posteriormente, temos a Categoria II – Sistematização da assistência de enfermagem no ambiente escolar, realizado com dados obtidos das entrevistas

com o tópico III do roteiro de entrevista (Registros das ações na atuação da enfermagem na EPT/IFC/Escola). Por fim, a Categoria III – Contribuições do enfermeiro na educação integral, realizado com dados obtidos das entrevistas nos tópicos IV e V, respectivamente, do roteiro de entrevista (Ações de educação em saúde e entendimento da educação profissional e tecnológica).

Segundo Bardin (2016, p. 133), a codificação é o processo pelo qual os dados brutos são transformados sistematicamente e agregados em unidades, as quais permitem uma descrição exata das características pertinentes do conteúdo.

As categorias são rubricas ou classes que reúnem um grupo de elementos (unidades de registro, no caso da análise de conteúdo) sob um título genérico, agrupamento esse efetuado em razão das características comuns destes elementos.

Bardin (2016, p. 147) define alguns critérios para categorização:

O critério de categorização pode ser semântico (categorias temáticas: por exemplo, todos os temas que significam ansiedade ficam agrupados na categoria “ansiedade, enquanto os que significam a descontração, ficam agrupados sob o título conceitual “descontração”), sintático (os verbos, os adjetivos), léxico (classificação das palavras segundo o seu sentido, com emparelhamento dos sinônimos próximos) e expressivo (por exemplo, categorias que classificam as diversas perturbações da linguagem).

Nesse sentido, os códigos foram agrupados conforme as características comuns das unidades de registros, formando as categorias conforme o Quadro 1, a seguir:

Quadro 1 – Categorização e codificação dos dados obtidos através entrevistas semiestruturada a profissionais enfermeiros em efetivo exercício em 2023 no Instituto Federal Catarinense

Categorias	Códigos
Atuação do enfermeiro no ambiente escolar	Prevenção e promoção à saúde, trabalho em equipe, identidade de grupo, agendas educativas, valorização dos enfermeiros no ambiente escolar.
Sistematização da assistência de enfermagem no ambiente escolar.	Necessidade de registros padronizados, continuidade do tratamento, melhoria do atendimento, valorização do histórico de saúde e necessidade de um sistema seguro.
Contribuições do enfermeiro na formação integral	Planejamento unificado de ações de saúde, contribuição do enfermeiro na EPT, desenvolvimento integral, potencial dos alunos como agentes de mudança, autocuidado e prevenção de agravos, capacitação em educação para o enfermeiro.

Fonte: Criado pela autora

Na primeira categoria: Atuação do enfermeiro no ambiente escolar, buscou-se entender a percepção dos enfermeiros quanto à sua atividade no ambiente escolar em um sistema de

ensino que visa à formação integral. Essa categoria engloba principalmente questões voltadas às práticas exercidas pelos enfermeiros no ambiente escolar, contrastando essas práticas de enfermagem em outros ambientes já vivenciados pelo profissional e identificando a percepção do enfermeiro nas atividades e adaptações de ações necessárias quanto ao exercício em ambiente escolar. Analisando os códigos criados nessa categoria, encontramos em ordem de frequência: prevenção e promoção à saúde, trabalho em equipe, identidade de grupo, agendas educativas, valorização dos enfermeiros no ambiente escolar.

Na segunda categoria: Sistematização da assistência de enfermagem no ambiente escolar, a intenção foi entender a percepção dos entrevistados sobre as formas de registros dos atendimentos de enfermagem e sua importância no contexto escolar como contribuição para a educação integral. Nesta categoria as questões elaboradas na entrevista buscam identificar as formas de registro das ações praticadas pelos enfermeiros no ambiente escolar, a utilização desses dados após o registro e a sua percepção quanto à necessidade e importância desses registros em um ambiente escolar. Os códigos gerados nessa categoria, em ordem de frequência foram: necessidade de padronização, continuidade do tratamento, melhoria do atendimento, valorização do histórico de saúde e necessidade de um sistema seguro.

Por fim, na terceira categoria: Contribuições do enfermeiro escolar na formação integral, a pretensão foi identificar as percepções dos enfermeiros quanto aos conceitos de educação integral e formação omnilateral propostos pelos Institutos Federais. Também se abordou o entendimento do que é a EPT proposta pelos IFs e seu papel como educador. Os códigos gerados nessa categoria, em ordem de frequência foram: planejamento unificado de ações de saúde, contribuição do enfermeiro na EPT, desenvolvimento integral, potencial dos alunos como agentes de mudança, autocuidado e prevenção de agravos, capacitação em educação para o enfermeiro.

4.1 Caracterização dos participantes da pesquisa

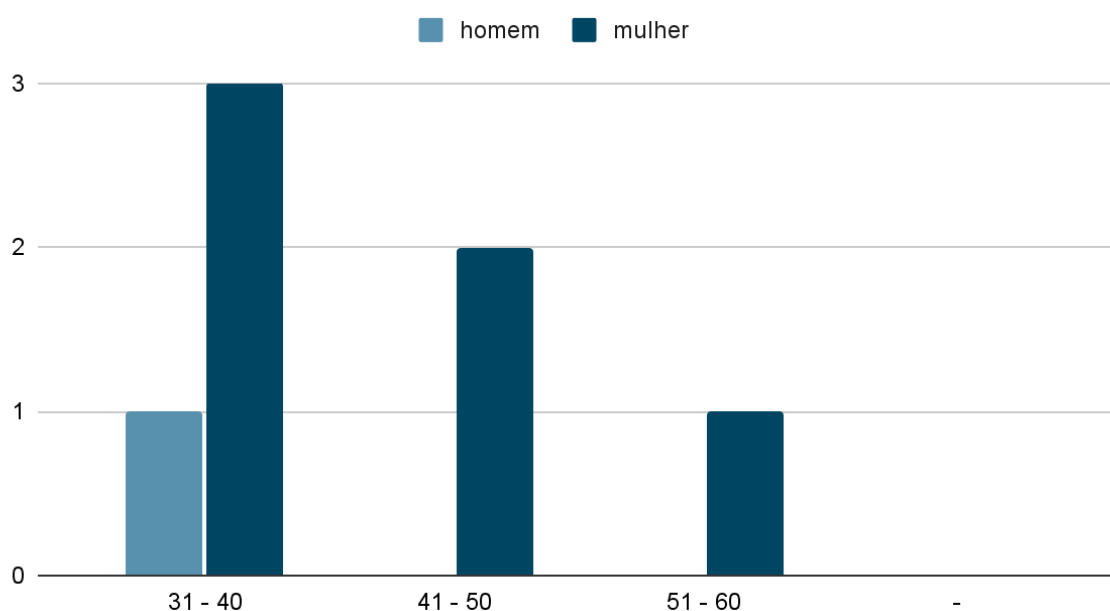
Inicialmente, identificamos as características pessoais dos enfermeiros. Nessa busca, questionamos idade, gênero, nível de formação acadêmica, dados sobre sua atuação na enfermagem e na enfermagem escolar.

Na caracterização da faixa etária dos enfermeiros em ativo exercício em 2023, foi constatado que 4 dos participantes possuem idade entre de 31 a 40 anos; 2 estão na faixa etária de 41 a 42 e 1 dos participantes está na faixa etária de 50 a 58 e já se encontra em processo de aposentadoria. Desta forma, identificamos um grupo de enfermeiros(as) composto, em sua maioria, por jovens profissionais, entre 30 e 40 anos.

Na identificação dos gêneros dos participantes, observou-se que a presença feminina é predominante: dos 7 participantes, temos 6 mulheres e 1 homem. Estes dados podem ser observados no Gráfico 1.

Segundo Silva *et al.* (2020), esse fato é histórico e cultural na enfermagem brasileira, pois se parte do pressuposto de que o cuidar é uma característica feminina, e, por isso, esse seria o público considerado mais indicado para exercer a profissão. No IFC essa realidade não foi diferente, posto que também predomina o sexo feminino, tendo como foco a promoção e prevenção da saúde, a fim de que os alunos desenvolvam a prática do autocuidado.

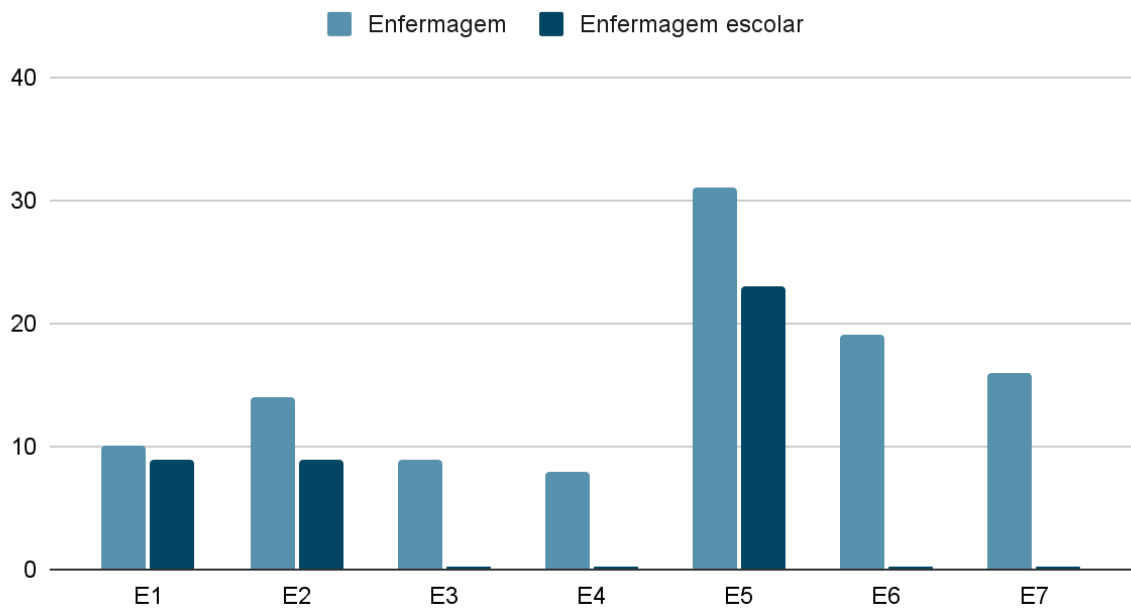
Gráfico 1 – Caracterização dos participantes de pesquisa quanto a idade e gênero



Fonte: Criado pela autora.

Em relação ao tempo de atuação na enfermagem, todos os enfermeiros apresentam experiência acima de 5 anos na atividade de enfermagem. Um dos participantes atua na enfermagem há 31 anos e está prestes a gozar de sua aposentadoria. Os demais atuam há 19, 16, 14, 10, 9 e 8 anos cada. Quanto à atividade de enfermeiro escolar, verificamos que essa experiência se reduz, apenas ocorrendo após o ingresso em cargo efetivo em IFs. Esses dados podem ser observados no Gráfico 2, onde apresentamos quatro enfermeiros recém-contratados com experiência de 3 meses de atuação em ambiente escolar e demais enfermeiros com maior experiência em ambiente escolar. Aqui ressaltamos que do total de 7 enfermeiros participantes da pesquisa, mais da metade, ou seja, quatro, são recém contratados, o que nos remete à importância de ações de acolhimento e de formação desses novos profissionais frente à proposta da EPT dos Institutos Federais.

Gráfico 2 – Caracterização dos participantes de pesquisa quanto ao tempo de atuação na enfermagem e tempo de atuação na enfermagem escolar



Fonte: Criado pela autora.

Quanto à caracterização dos enfermeiros em relação ao seu histórico profissional pregresso e à atual atuação no IFC, questionamos “Você visualiza muitas diferenças na atuação do profissional de enfermagem no IFC quando comparado com os outros locais que atuou? Quais diferenças?”

Quanto à experiência profissional anterior ao IFC, os entrevistados já atuaram em diversas instituições anteriormente ao IFC, dentre elas: ambiente hospitalar, vigilância epidemiológica, Estratégia Saúde da Família, Instituto Federal do Mato Grosso do Sul (IFMS), universidades na função de docente, Senac, Serviço de Nefrologia, Colégio Agrícola de Camboriú que fazia parte da UFSC, Gerência Regional de Saúde de Concórdia, Auditoria de planos de Saúde, Secretaria Municipal e Estadual de Saúde e Secretaria de Justiça do Ministério da Saúde.

Os participantes da pesquisa visualizaram muitas diferenças na atuação profissional no ambiente escolar (IFC) quando comparado com outros locais de atuação como hospitais, unidades básicas de saúde, entre outros. Dentre as principais diferenças estão o tipo de público atendido e as ações e atendimentos de enfermagem. Eles destacam que no ambiente escolar trabalha-se muito mais ações de educação em saúde, orientações de saúde, buscando atender às demandas do público-alvo, que são estudantes adolescentes. Essas diferenças são bem explicadas e exemplificadas, conforme podemos observar na fala dos entrevistados E1, E3 e E5:

Eu visualizo assim o nosso ambiente de trabalho, ele é bem diferenciado e até quando eu comecei aqui no IFC eu senti muito assim. Eu digo que eu tive meio que uma crise de identidade, né? E de atuação, né [...] você vem para cá, A atuação é diferente, né? [...] Quando eu comecei aqui, a gente atende, né? Questões ambulatoriais assim, mas muito básicas, né? E a nossa principal função é atividades de educação em saúde, né? Então, você tem que estar integrado aí nessas questões, integrado no meio pedagógico, né? A gente faz parte de uma equipe pedagógica, uma equipe multiprofissional. Então, assim, a atuação é bem diferenciada (E1).

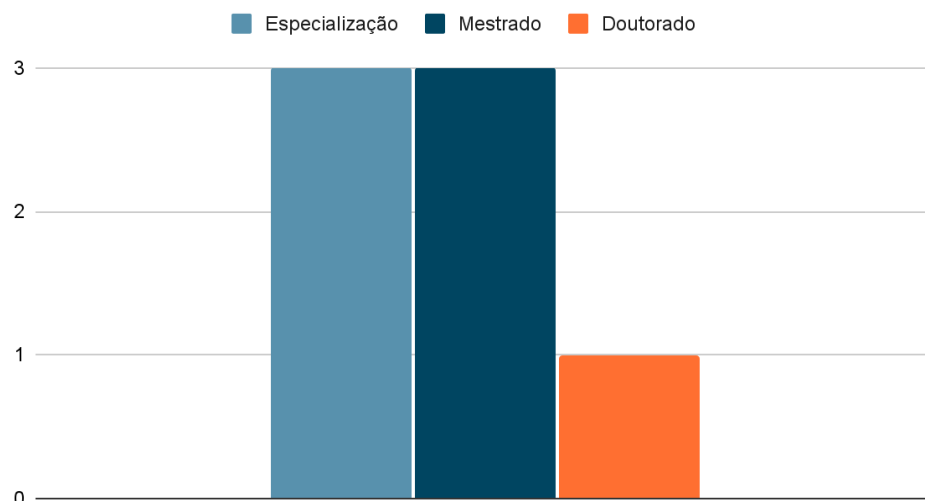
Mas existem sim diferenças, né? A gente sabe que a demanda dentro da escola ela vai ser diferente, ela vai ter uma. Não que as outras áreas também não tenham essa ação educacional, mas a gente também precisa pensar muito na prevenção, na promoção de saúde. Então, talvez difere nesse sentido. E até mesmo o público, né, de atuação [...] Quando a gente tem essa faixa etária de ensino médio ou principal, é público, vai ser o adolescente, né? Então muda o perfil atendido, muda as demandas, né? Então, realmente assim é bem diferente, né? [...] Então, nesse sentido, parece um pouco, mas realmente ele difere em muitos pontos (E3).

[...] as diferenças são bem consideráveis, porque toda a estrutura de um hospital é puramente assistencial. Eu trabalhei em clínica médica, trabalhei em CTI, né, em clínica de apoio, em que você atendia pacientes pós operatórios de emergência oriundos da emergência. Então, a dinâmica de trabalho, todo o processo de trabalho bem diferente de você estar numa instituição de ensino, né? No setor de saúde de uma instituição de ensino (E5).

Nessa perspectiva, confirma-se a ideia de Rasche e Santos (2013) para quem a presença do enfermeiro na escola é determinante na atenção aos processos de promoção em saúde ao estimular debates técnicos, ao apresentar sua perspectiva em relação aos processos de saúde e doença, além de fortalecer as relações sociais entre profissionais da educação e saúde.

Nesse sentido, a atuação do enfermeiro na escola é de um educador em saúde. Os entrevistados têm uma vasta experiência profissional, principalmente em ambiente hospitalar, mesmo assim eles têm a clareza de que na escola a atuação é muito mais voltada para ações de educação em saúde do que assistência.

Gráfico 3 – Caracterização dos participantes de pesquisa quanto ao nível de formação acadêmica



Fonte: Criado pela autora.

Quanto ao nível de formação dos entrevistados, três possuem especialização, três, mestrado e um, doutorado. Apesar de não existir “ainda” uma formação acadêmica para enfermagem no ambiente escolar, acreditamos que a constante profissionalização do enfermeiro escolar é essencial para a manutenção e promoção de uma boa atuação. As formações acadêmicas permitem uma atualização de conhecimentos e conceitos, de visão de mundo e de atuação, e as pesquisas podem agir como agentes transformadores de sua práxis e do ambiente de trabalho.

4.2 Categoria I: atuação do enfermeiro no ambiente escolar

Para compreender a percepção dos enfermeiros sobre sua atuação profissional no IFC, foi necessário entender qual a percepção deles sobre como deve ser a atuação do enfermeiro na escola. Frente aos dados analisados nas entrevistas, geramos os códigos: prevenção e promoção à saúde, agendas educativas, trabalho em equipe multidisciplinar, valorização dos enfermeiros no ambiente escolar e identidade de grupo.

Os enfermeiros destacam a **prevenção e promoção à saúde** e **agendas educativas**, na atuação do enfermeiro no ambiente escolar. Assim, sua atuação deve ser voltada para ações de educação em saúde, buscando promover a adoção de hábitos saudáveis e o autocuidado nos estudantes, a fim de prepará-los para a vida. Como se observa nas falas dos enfermeiros E1, E4 e E5, a seguir coletadas a partir da questão “Como você acha que deve ser a atuação do enfermeiro na escola”?

Eu acredito que nessa nossa função e ela deve ser muito mais voltada à prevenção, né? Então, e as atividades aí relacionadas a educação em saúde, promoção de saúde? Prevenção, né? Mas nesse sentido, não. Não muito focada na questão ambulatorial e sim na questão de promoção da saúde (E1).

“Eu acho muito importante, principalmente a parte da educação em saúde, a gente trabalhar isso no aluno. Eu acho que isso é de suma importância” (E4).

“Mas eu acho que o principal seria mesmo desenvolver ações de promoção à saúde dos estudantes” (E5).

Constatou-se também a importância de um trabalho integrado para o acompanhamento do estudante, ou seja, o trabalho multiprofissional, de acordo com o código, um **trabalho em equipe multidisciplinar**, que visa olhar de forma interdisciplinar o discente. Isso pode ser percebido na seguinte fala:

Eu penso que a enfermagem. Ela pode atuar de maneira multiprofissional com a equipe de outros profissionais da área de saúde e da área pedagógica [...] O tripé dentro de uma instituição de ensino poderia inclusive trabalhar junto com o corpo docente ou o na questão de ações disciplinas, né, transversais. Você pode trabalhar a temática saúde em qualquer disciplina, né? [...] Poderia se trabalhar em parceria sim, com gestão municipal nesse sentido aí sim, né? De campanha e até na questão da assistência, né, dos encaminhamentos [...] Até mesmo com projetos com projetos de educação e saúde (E5).

Identificamos as percepções, através das falas dos enfermeiros entrevistados, sobre o papel do enfermeiro na escola, que se desenvolve de forma complexa e abrangente. O enfermeiro no ambiente escolar desempenha um papel fundamental na promoção e prevenção dos alunos, na realização de ações educativas e preventivas e na garantia de um ambiente saudável e seguro para a comunidade escolar.

Nesse sentido, Maciel *et al.* (2010) enfatizam a importância da inserção do profissional enfermeiro na saúde escolar, traçando o seu papel na escola, qual seja, a função educativa e assistencial para a proteção e promoção da saúde do escolar, proporcionando a esse estudante um ambiente físico e emocional adequado ao seu crescimento e desenvolvimento, ajudando-o a compreender a importância dos exames de saúde periódicos, estimulando-o a utilizar os recursos de saúde da comunidade, contribuindo para a prevenção e promoção da saúde e controle das doenças transmissíveis. Vê-se, ainda, a compreensão da necessidade da sua participação para avaliar os problemas de saúde pessoais dos estudantes, de sua família e de sua comunidade, por meio de atendimentos individuais ou de educação em saúde realizada em atividades coletivas. Destaca-se também a importância deste profissional de saúde no espaço escolar para a diminuição da violência contra criança e adolescente.

O contexto escolar representa um espaço primordial para adquirir conhecimentos, habilidades, mudanças de comportamento e estilos de vidas, por ser um local no qual o educando desenvolve vínculos permanentes, e geralmente permanece por um tempo prolongado (Bastos *et al.*, 2021). No IFC, há estudantes oriundos de várias cidades, regiões e até de outros estados que permanecem na Instituição em tempo integral. Em alguns *campi* há moradia estudantil, onde os estudantes residem para estudar. Diante deste contexto, a atuação do enfermeiro tem importância para o acompanhamento e orientações de saúde desses discentes.

Para a atuação do enfermeiro na escola, os participantes da pesquisa elencaram como essencial a **valorização dos enfermeiros no ambiente escolar**. Esta relação com a atuação dos enfermeiros no ambiente escolar fica clara quando identificamos a necessidade desta valorização, ao analisarmos as falas obtidas através da pergunta: “Diante da sua realidade no *campus*, você encontra espaço e apoio para desenvolver as atividades educativas? Como isso poderia melhorar, quais setores deveriam/poderiam apoiar?”.

Os entrevistados relatam que possuem espaço para realizar as ações de educação em saúde, mencionam novamente ser importante um trabalho em equipe multiprofissional para um atendimento integral do estudante. No entanto, percebem ser necessário uma valorização dos enfermeiros como educadores para o reconhecimento do trabalho e assim para uma melhor integração da equipe multiprofissional, como percebemos nas falas a seguir:

Bem, como eu disse, foi. A gente até conseguiu desenvolver algumas ações, sim, mas com bastante dificuldade. Assim, o apoio era. [...] Um pouco difícil, né? Um pouco restrito. [...] Sem apoio da gestão, você não consegue. [...] Né? Sim. Se a gestão não reconhecer que aquela equipe tem que estar ali para aquele propósito [...] Então, isso enquanto não, não, não ter esse reconhecimento de que aquela equipe também é uma equipe de educadores, não só o corpo docente. Nós somos profissionais da educação e que estão ali para desempenhar esse papel de educador. Não, não, não. A gente não consegue. Chega no meio do caminho, esbarra com uma situação [...] Fazem aula de meia hora para ter reunião, fazem aula de meia hora para ter tal coisa. Como que quando vai do interesse da gestão, a gente consegue ajustar o calendário. Por que que não é justo calendário pra também pra desenvolver ações em prol da saúde a considerar que são profissionais da educação e isso você está educando. (E5).

Diante disso, percebemos que os entrevistados indicam a importância da valorização das ações de educação em saúde promovidas pelos enfermeiros no contexto escolar. Enfatiza-se a necessidade de a equipe ser valorizada e apoiada pela gestão para as atividades de educação em saúde, proporcionando, assim, uma formação integral aos estudantes.

Constatou-se ser fundamental na escola um trabalho em equipe, com apoio de toda comunidade escolar. Ficou claro nas falas dos participantes que o apoio da gestão, o trabalho em equipe multiprofissional, especialmente nas atividades educativas da enfermagem, além das parcerias com redes de atendimento (Secretaria de Saúde Municipal etc.) fortalece a realização de ações de educação em saúde, tornando-se um incentivo para os profissionais enfermeiros, garantindo a adesão nas atividades, além de ser um ponto motivador para realização das ações.

A realização dessas ações também ajudou a compor uma **identidade de grupo**, uma vez que os entrevistados entendem ser fundamental uma aproximação entre os profissionais de enfermagem para troca de experiências, programação de atividades, padronização de documentos, protocolos, regimentos entre outros. Isso pode ser observado nas falas dos participantes quando questionados sobre “Você consideraria benéfico uma aproximação com os demais profissionais enfermeiros para troca de experiências e programar atividades?

Com certeza. Eu acho que os campos, eles têm que andar bem alinhados, né? Uns tem mais estrutura, outros tem menos. Mas as ações eu acho que sim. Elas podem ser organizadas para que? Para que todos consigam falar a mesma língua. É importante para essa troca de informação, né? Às vezes o enfermeiro tem uma ideia interessante, o outro tem outra ideia e a gente pode ir adaptando (E7).

“E eu acredito que sim e que eu não conheço os profissionais e. [...] Não sei se são profissionais proativos e comprometidos, resolutivos assim. E aí pode ser bacana” (E2).

É possível identificar nas falas dos entrevistados a falta de uma aproximação com o grupo para troca de experiência, planejamento de ações, projetos, padronização de documentos etc. Nesse sentido, o IFC, através de seus gestores, precisa pensar estratégias para haver uma aproximação maior entre os profissionais enfermeiros como encontros, reuniões para troca de experiências, padronização de documentos institucionais entre outros.

Também se constatou que os enfermeiros sentem falta de uma orientação ao entrarem na instituição sobre como funciona o serviço de enfermagem dentro da instituição, como, por exemplo, formas de registros, regimentos etc. Sendo assim, o IFC, através de seus gestores, precisa ter um planejamento para orientar os profissionais de enfermagem ao entrarem na instituição, conforme vemos na fala:

Então, de repente é isso. Assim, se tem alguém que orienta, que organiza o grupo, né? Isso é importante também. Então, de repente, se isso fosse organizado de uma forma mais proativa, eu acho que seria benéfico esse contato com outros profissionais, porque muitas vezes a gente acaba entrando em discussões que não são muito, não são muito boas ou proativas assim (E2).

4.3 Categoria II: sistematização da assistência de enfermagem no ambiente escolar

A Sistematização da Assistência de Enfermagem no ambiente escolar (SAE) é fundamental para uma assistência de enfermagem com mais qualidade, devido à organização do serviço de enfermagem. Ao abordar esse tema no roteiro de entrevista, as respostas às questões foram concentradas nos seguintes códigos apresentados em ordem de frequência: necessidade de registros padronizados, melhoria do atendimento, continuidade do tratamento, valorização do histórico de saúde, necessidade de um sistema seguro.

Os entrevistados entendem que anotações/registros são formas de anotar toda e qualquer situação, acontecimento, atendimento, histórico, consulta de enfermagem relativa ao estudante e também qualquer situação ocorrida no setor. Enfatizam que um registro das ações de enfermagem é fundamental para o exercício da profissão, além de ser uma questão legal.

Quanto às formas de anotações/registros de ações e atendimentos de enfermagem serem padronizadas no IFC, os participantes da pesquisa entendem ser fundamental que a forma de registros seja sistematizada, padronizada, como se percebe em suas falas sobre a codificação de **necessidade de registros padronizados.**

Olha, eu acredito que seria interessante seguir o padrão até mesmo para futuramente a gente fazer pesquisas, né? E eu preferiria um sistema online, né? Poderia ser até próprio dentro lá do dos nossos sistemas que a gente já tem dentro do sistema federal. Mas que ficasse um registro de fácil acesso (E1).

“Mas como se fosse assim realmente um prontuário, sabe? Eu sinto falta disso” [...] eu sinto falta dessa questão assim, de ser algo mais prontuário mesmo, com cara de prontuário [...] É padronizado que é bem melhor, né” (E3).

“A gente tem aqui no ambulatório, mas tem os registros e acabamos fazendo uma planilha no drive, né? Ali a gente tem os dados do estudante e vai fazendo os registros, mas eu acho que precisaria ser padronizado” (E4).

Eu acho fundamental, eu acho. Até houve uma tentativa da gente, pelo menos no campus, da gente tentar fazer isso, porque somos mais de uma profissional. Então, até mesmo para que dentro do próprio campus existisse essa continuidade ali dos registros [...] até porque a próprio exercício profissional da enfermagem diz que a enfermagem tem que trabalhar com registro da enfermagem, tem que registrar o que faz e isso tem que ter uma continuidade, né. Esses registros (E5).

Sim, eu acho importante, porque daí tem uma forma padrão de atendimento, porque muitas vezes pelo vício de atendimento, você acaba às vezes deixando passar alguma abordagem que poderia ter sido feita ou alguma situação. Então acho importante ter isso de forma padronizada. (E6).

Percebemos nas falas dos participantes que fica clara a importância da padronização da forma de registros no IFC e o desejo que seja um prontuário em um sistema informatizado (*software*). Eles mencionam a importância de utilizar as tecnologias para melhorar as formas de registros. Os entrevistados destacam que o sistema *on-line* de registros melhora a qualidade do cuidado, promove a continuidade do cuidado, facilita a comunicação entre os profissionais e contribui para a formação integral.

Nessa perspectiva, o Cofen (2015) define prontuário como;

Documento único constituído de um conjunto de informações, sinais e imagens registradas, geradas a partir de fatos, acontecimentos e situações sobre a saúde do paciente e a assistência a ele prestada, de caráter legal, sigiloso e científico, que possibilita a comunicação entre os membros da equipe multiprofissional e a continuidade da assistência prestada ao indivíduo.

Nesse sentido, é importante o IFC possuir documentos padronizados, como protocolos e prontuários dos estudantes, pois isso organiza o serviço de enfermagem, melhora qualidade do atendimento à comunidade escolar, proporciona segurança aos profissionais de enfermagem, além de atender às resoluções do Cofen.

De acordo com Brito, Velozo e Pavanelli (2016, p. 10):

O registro do paciente, referente à assistência prestada, envolve vários aspectos e respalda ética e legalmente o profissional pelo cuidado, bem como o paciente. A inadequação e a ausência de registros podem comprometer a assistência ao paciente, trazendo prejuízos a instituição e a equipe de enfermagem. A padronização dos registros (anotações e evoluções) de enfermagem é necessária, visto que existem

falhas no que se refere a adequações gramaticais, de linguagem, exatidão, brevidade, legibilidade, identificação e terminologia técnica.

O contexto escolar representa um espaço primordial para adquirir conhecimentos, habilidades, mudanças de comportamento e estilos de vidas, por ser um local no qual o educando desenvolve vínculos permanentes e, geralmente, permanece por um tempo prolongado (Bastos *et al.*, 2021). No IFC, há estudantes oriundos de várias cidades, regiões e até de outros estados e que permanecem na Instituição em tempo integral. Diante desse contexto, a atuação do enfermeiro é de extrema importância para o acompanhamento e orientações de saúde desses discentes.

Constatou-se que os entrevistados possuem conhecimento dos registros de enfermagem e da sua importância para a **melhoria do atendimento e continuidade do tratamento**, como observa-se nas falas quando questionados sobre “Você considera importante os registros/anotações dos atendimentos e ações de enfermagem? Por quê?”

“Considero. Acho muito importante para ter esse acompanhamento. A gente tem uma forma assim, mas digamos que oficial né?” (E1).

“Com certeza. Porque é dar continuidade ao tratamento e conhecer o público que você tá trabalhando” (E4).

“Fundamental, primordial. Tá, e eu já gostaria de antemão sugerir que a gente utilizasse um sistema eletrônico que fosse integrado” (E6).

Com certeza. Eu acredito que qualquer atendimento, qualquer em qualquer situação que o aluno nos busque. Eu acho importantíssimo a gente anotar para identificar principalmente o padrão de frequência que esse aluno está procurando a o ambulatório e para que a gente deixe claro tudo o que aconteceu naquele atendimento. [...] Às vezes ai o aluno que tá malzinho tá com diarreia, vômito, enfim, vou lá no no, no sistema de registro dele e verifico não é um paciente celíaco, por exemplo, a se alimentou de alguma coisa que não fez bem, Então já começa a fazer uma relação, né, de uma possível do possível diagnóstico. E isso vai ajudar até a eu identificar qual que é a gravidade da situação, né. A é um paciente que convulsionou, mas ele já convulsionou alguma vez na vida, então esses dados eles são importantíssimos e a gente precisa cada vez mais colocar muitos detalhes para que a gente possa enriquecer essa anotação (E3).

Diante das falas dos participantes, percebe-se que eles reconhecem a importância dos registros de enfermagem e do histórico de saúde do estudante para seus atendimentos, assim como a questão legal para atuação profissional. Isso se confirma com o código de ética profissional, Resolução n. 564/2017, Resolução Cofen n. 429/2012 e Resolução Cofen n. 358/2009, que tratam sobre os registros de enfermagem e SAE.

Os registros dos cuidados à saúde são fundamentais para o atendimento ao estudante, pois através deles conhecemos o histórico de saúde do paciente, família, condições socioeconômicas, entre outras. Eles oferecem subsídios à equipe de saúde para planejamento

de ações, conduta e organização do cuidado para o indivíduo e coletividade, buscando a integralidade na assistência, ou seja, o atendimento do paciente na totalidade. Além disso, resulta para a instituição, em termos de registro, numa gama de informações que, uma vez reunidas, irão constituir o prontuário do paciente e o histórico de ações educativas. Os registros ainda oferecem segurança para o estudante, para o profissional e para a instituição.

Importante ressaltar que os entrevistados mencionam a importância de registros não editáveis para evitar problemas e garantir a integridade das informações, ou seja, um sistema seguro, *on-line* ou não, para uso de informações sigilosas, garantindo assim respaldo e segurança ao estudante, aos profissionais e ao IFC. Conforme vemos, as falas relacionam-se aos códigos **valorização do histórico de saúde e necessidade de um sistema seguro**.

Os participantes da pesquisa consideram importante o IFC possuir um histórico de registros dos discentes e egressos, pois isso proporciona respaldo legal, para fins de pesquisa, acompanhamentos dos discentes, organização institucional, subsídios para ações e intervenções de saúde, continuidade do atendimento, ou seja, o histórico de registros é fundamental para aumentar a qualidade de atendimento aos estudantes, como se percebe nas falas quando questionados sobre: “Você considera importante o IFC possuir um histórico dos registros de ações de enfermagem dos discentes e egressos do IFC?”:

“Isso por uma questão legal, né?” (E1).

“Sim, eu acho que é importante ter uma ideia do fluxo de atendimento de cada campus e do quantitativo de material ou de profissionais que podem ser necessários para cada campus” (E2).

Com certeza, né? A gente tem que pensar em educação continuada e educação permanente. Então, para que a gente possa comprovar isso que está sendo realizado, né? A gente vai precisar sim, criar o sistema de registro. O ideal é que fosse padronizado também entre os IFC, para que realmente a gente consiga comprovar as nossas ações também, né? Como enfermeiros. E eu acho que é nesse sentido, assim a gente. Eu acho importantíssimo ter um sistema de registro. Ata, né? Isso aí (E3).

Muito importante. A gente sente muita falta disso e eu já fui em busca disso, achando que existia e que tava em algum local que ninguém sabia, né? Porque a gente não encontrou a enfermeira. Então eu achei que existia,” [...] e a gente fica como? Entende? É nosso respaldo, o nosso aparato pra trabalho. Não tem como. Eh. E é mais uma separação (E4).

Eu acho importante pelo fato de que você vai fazer esse acompanhamento daquele estudante, né? Por exemplo, se ele começa a ir várias vezes no setor, você pode até conseguir verificar situações que porventura passa despercebidas. [...] Ah, e também você atender algum aluno, se você não tem o histórico, desconhece né? Não conhece a fundo o histórico do estudante. Você corre o risco muitas vezes de de se equivocar, né? Na tua avaliação, na tua análise, porque você desconhece muitas vezes que aquele estudante ele tem um problema qualquer de saúde, né? Ou ele venha a ter um processo alérgico. Enfim, você desconhece o histórico, você não tem como avaliar, analisar e avaliar, né? Aquela situação. [...] Também, até pra fins de você traçar, mapear, né? Planejamentos futuros aí, mapear a estrutura material, né? [...]

E ele se recorda que teve uma situação no campus, mas ele não lembra e tal. Então se existisse já aquele histórico ali, até mesmo para fins dele de pesquisa ou até mesmo né de. Da pessoa ter essa informação, né? Nesse sentido (E5).

Fundamental. Eu estudei epidemiologia e eu já. Meus olhos brilham quando eu penso numa corte, mas eu acho fundamental para os próprios alunos. E imagina se a gente fizesse parte do Conecte SUS? A gente poderia evoluir. Depois, quando o aluno vai lá, muda de cidade, coisa e tal, a pessoa lá do município vai poder consultar (E6).

Porque de suma importância, né? Até por questão de de quando esse egresso, né? Ele ele precisar informação? Você tem a informação? Que tal o momento que ele foi atendido? Tal situação aconteceu com ele e você registrou aquilo? Ele está ciente, né? Tanto para defesa dele quanto para nossa defesa também, né? (E7).

Dessa forma, confirmam-se as falas dos entrevistados com a resolução do Cofen (2015) que define o prontuário do paciente como um acervo documental padronizado, organizado e conciso referente ao registro dos cuidados prestados ao paciente por todos os profissionais envolvidos na assistência. A palavra prontuário deriva do latim “*promptuarium*”, que significa lugar onde se guarda aquilo que deve estar à mão, o que pode ser necessário a qualquer momento.

Ávila *et al.* (2022) entendem que o prontuário eletrônico permite ao profissional conhecer mais detalhadamente o paciente, suas condições clínicas, sua família, seu contexto social e seu histórico de atendimentos. Permite também identificar as situações de saúde presentes no território onde atuam, pois tem se concretizado como uma ferramenta que potencializa o planejamento do cuidado em saúde. O PE contribui para a construção do vínculo entre profissional e paciente, a organização do fluxo do cidadão no sistema, a qualidade do atendimento, o aprimoramento da comunicação no âmbito da equipe do usuário, auxiliando a disponibilizar ao profissional informações mais qualificadas e completas.

Feitosa (2023) enfatiza que o prontuário de forma manual dificulta o atendimento, pois requer um tempo maior para que seja realizado o preenchimento de todas as etapas da consulta de enfermagem. A ausência de informatização torna-se um fator que contribui para a desmotivação dos profissionais em realizar o PE.

Diante disso, o IFC, que conta com cursos na área de tecnologia, como desenvolvimento de *software*, poderá considerar desenvolver um sistema informatizado *on-line* para uso dos profissionais de enfermagem, melhorando, assim, a qualidade da assistência ao estudante, melhor acompanhamento, além de motivar os profissionais na realização dos registros.

Quanto à forma que os participantes registram seus atendimentos, quatro participantes registram manualmente, em papel ou caderno e três dos participantes registram em planilha no *drive*. Vale ressaltar que os entrevistados demonstraram preocupação com os registros no *drive*

quanto à segurança das informações. A enfermagem é uma profissão fortemente dependente de informações precisas e oportunas para executar a grande variedade de intervenções envolvidas no cuidado. Dessa forma, os registros de enfermagem são elementos imprescindíveis ao processo do cuidar e, quando redigidos de maneira que retratem a realidade a ser documentada, possibilitam a comunicação entre a equipe de saúde, além de servir a diversas outras finalidades, tais como: ensino, pesquisas, auditorias, processos jurídicos, planejamento, fins estatísticos e outros. (Cofen, 2015)

Dessa forma, o Cofen (2015) orienta que para serem consideradas autênticas e válidas, as ações registradas no prontuário do paciente deverão estar legalmente constituídas, ou seja, possuir assinatura do autor do registro (art. 368 do Código de Processo Civil – CPC) e inexistência de rasura, entrelinhas, emenda, borrão ou cancelamento, características que poderão gerar a desconSIDERAÇÃO jurídica do documento produzido como prova documental (art. 386 do CPC). Salientamos que as declarações constantes do documento particular, escrito e assinado, presumem-se verdadeiras em relação a quem o assinou (art. 368 do CPC), fator importante na defesa profissional em processos judiciais e éticos.

Quanto a informações que devem constar no registro de enfermagem, os participantes da pesquisa destacam: nome do paciente, data, hora, idade, situação, queixa principal, histórico de saúde, contato dos responsáveis, procedimento e conduta/encaminhamento e foto do discente.

Segundo Cofen (2015), os registros de enfermagem devem ser precedidos de data e hora, conter assinatura e identificação do profissional com o número do Coren, identificação do paciente, sinais e sintomas, todos os cuidados prestados, intercorrências. Os registros devem conter informações completas, exatas, com dados subjetivos e objetivos e pertinentes para a continuidade da assistência ou para condutas a serem tomadas. É importante registrar todas as informações em formato adequado e em ordem cronológica.

Cabe citar também que as informações sobre um estudante só deverão ser transmitidas mediante o entendimento de que tais dados não serão divulgados para pessoas não autorizadas. A lei protege as informações sobre um paciente que esteja sob cuidados profissionais de saúde. O profissional de enfermagem é obrigado por lei e pela ética a manter confidencialidade de qualquer informação relacionada à doença e ao tratamento do cliente (Cofen, 2015).

Importante destacar que conforme código de ética da enfermagem Resolução 564/2017, em seu artigo 52, é dever do profissional de enfermagem manter sigilo sobre fato de que tenha conhecimento em razão da atividade profissional, exceto nos casos previstos na legislação ou por determinação judicial, ou com o consentimento escrito da pessoa envolvida, ou de seu

representante, ou responsável legal. Ainda segundo a Resolução, em seu art. 52: “§ 1º Permanece o dever mesmo quando o fato seja de conhecimento público e em caso de falecimento da pessoa envolvida”, o artigo continua mencionando que: “§ 2º O fato sigiloso deverá ser revelado em situações de ameaça à vida e à dignidade, na defesa própria ou em atividade multiprofissional, quando necessário à prestação da assistência.”

Subentende-se que os registros de enfermagem permeiam todas as fases da SAE, devendo ser anotadas no prontuário do paciente as informações completas, desde o histórico, exame físico, diagnóstico de enfermagem, prescrição da assistência, até a evolução/avaliação de enfermagem (Pimpão *et al.*, 2010). Os entrevistados reconhecem a importância da SAE e realizam, em partes, as etapas do processo. Diante disso, é importante a padronização de um documento de consulta de enfermagem para que todos os profissionais realizem todas as etapas do PE.

A SAE é um instrumento necessário na atuação do enfermeiro na assistência ao paciente. Pode ser uma forma de organização, planejamento e avaliação dos cuidados prestados ao paciente, além de contribuir para o planejamento, conduta e ações para o indivíduo e/ou coletivo.

Como destaca Feitosa (2023) A SAE tem o objetivo de proporcionar aos profissionais uma maior qualidade na assistência prestada, segurança e autonomia profissional. Ela organiza o serviço de enfermagem, proporcionando uma melhor assistência aos estudantes. A SAE deve ser implantada em todos os ambientes que prestam assistência de enfermagem, conforme resolução do Cofen n. 358/2009. Diante disso, é fundamental que seja implantada no IFC de forma sistematizada, padronizada, visando um melhor atendimento aos nossos estudantes.

O IFC possui o serviço de enfermagem em diversos *campi*, nos quais os registros de enfermagem são realizados individualmente. Padronizar as formas de registros dos atendimentos prestados pela equipe de enfermagem é fundamental, por poder aprimorar e unificar a assistência de enfermagem desde o acolhimento até as ações de promoção e prevenção em saúde no IFC. Essa unificação pode proporcionar uma manutenção e aumento da qualidade e integralidade da assistência ao paciente, além de proporcionar organização, planejamento e segurança ao paciente e também aos profissionais de enfermagem.

4.4 Categoria III: contribuições do enfermeiro na formação integral

O enfermeiro é o profissional capacitado para prestar cuidados de enfermagem especializados com autonomia no campo educacional, em uma equipe multiprofissional. A atuação do enfermeiro no ambiente escolar, através das suas ações de educação em saúde,

consultas de enfermagem, acolhimento, pode contribuir para a formação integral do estudante, além da redução de vulnerabilidades existentes na fase da adolescência, incentivando adoção de hábitos de vida mais saudáveis, melhorando, conseqüentemente, a qualidade de vida dos educandos.

Para apresentar as considerações sobre essa categoria, as falas e discussões serão norteadas pelos códigos: planejamento unificado de ações de saúde, potencial dos alunos como agentes de mudança, contribuição do enfermeiro na EPT, desenvolvimento integral, capacitação em educação para o enfermeiro.

Em relação às percepções dos enfermeiros para sua contribuição em uma educação integral, o **planejamento unificado de ações de saúde** foi citado com maior frequência. Os participantes da pesquisa definem como ações de educação em saúde: palestras, dias alusivos, *folders* informativos via *e-mail*, *site* institucional, dinâmica com orientações, rodas de conversas, campanhas outubro rosa, novembro azul e produção de materiais educativos como panfletos e cartazes. Enfim, em toda e qualquer ação de orientação que vise à promoção e à prevenção da saúde você está educando em saúde, até mesmo por meio de uma orientação no corredor.

Entendem que realizar ações de educação e prevenção em saúde no contexto escolar é fundamental, como observamos nas falas quando questionados sobre “Você considera importante realizar ações de educação e prevenção em saúde no contexto escolar?”.

“Ter esses profissionais de saúde para pensar em ações de promoção da saúde, né. Exclusivamente para aquela comunidade” (E2).

“E a formação. Então, eu acredito que a educação em saúde ela teria que estar incluída lá na creche, né. Lá nos primeiros passos” (E3).

“Com certeza. Com certeza a gente tá trabalhando com pessoas em formação, né? E é esse o momento de orientar e de levar as informações pra eles” (E4).

“Fundamental. Como eu falei, eles seriam. Eh. No momento em que ele tá ali, ele tá num momento de aprendizagem, né. Eh. [...] O profissional de saúde. Ele tem esse papel educador dentro do contexto escolar.” (E5).

“Fundamental, principalmente porque é quando eles estão estão formando alguns pensamentos. Então é aí que eles podem prospectar esse, esse conhecimento, essa conhecimento para o autocuidado, né?” (E7).

Quanto à construção de um cronograma de ações de educação em saúde, programadas em conjunto, todos os participantes têm desejo de que uma agenda construída em conjunto seja colocada em prática no IFC, caso sejam respeitadas as particularidades de cada *campus*. Isso

foi observado nas falas dos participantes em resposta às perguntas: “Você considera importante ter um cronograma de ações de educação em saúde construído em conjunto, unificado entre os *campus*?”.

Sim. Eu não sei se unificado, sabe? Porque eu acredito que não. Não seria possível que fosse unificado esse cronograma por causa da diferença, né? Da realidade de cada campus, né? [...] mas que tivesse essa abertura da própria instituição, né? O início de cada ano letivo e fornecesse esse espaço para a gente fazer esse cronograma. Mas eu acredito que unificado não sei se funcionaria (E1).

Eu acredito que daria para ter sim. Para a gente ter uma padronização, né? Talvez até a alusivos aos meses, né? Por exemplo, aqui que a gente vai fazer no dezembro vermelho. Daria para ter essa base, né? De calendário de Ministério da Saúde e andar junto com a saúde que está lá? Externa, né? [...] Então eu acho que daria para a gente pensar em algo assim. Que seja, né? Uniformizado entre os campos. (E3).

“Sim, eu acho que é importante. [...] De repente, seria legal ter um cronograma e poder compartilhar ou pensar nessas ações junto o que cada campus pode desenvolver sobre um determinado tema, né? E de uma forma que também não fique sobrecarregado, né?” (E2).

“Acho. Acho. Serve como um uma linha de trabalho, né? Pra todos. Acho muito importante” (E4).

“Eu acho fundamental ter esse planejamento. Não digo no cronograma um planejamento mesmo das ações, entendeu? Ah, obviamente, talvez cada campo pudesse fazer, o seu molde de acordo com a sua realidade. Mas haver um calendário, haver um cronograma.” (E5).

“Assim, se for uma coisa que a gente vai construir em conjunto, eu acho importante, sim. Agora, se for uma coisa que veio bem assim, de cima para baixo, eu sou contra” (E6).

Eu acho que pode ser separado, porque cada campus, é claro, algumas coisas tem que ser em conjunto. Outubro Rosa todo outubro. Rosa Todo mundo faz alguma coisa padrão ou parecido. Mas aí cada campus vai ter que adaptar a sua realidade, né? [...] Então tem que ser adaptado também, né? 50% o padrão e 50% adaptado a cada necessidade (E7).

Cabe citar que os entrevistados mencionam que, para o desenvolvimento das ações de saúde, é fundamental o apoio da gestão, equipe multiprofissional e docentes. *“Sem apoio é difícil. [...] Tem que ter apoio, principalmente da gestão”. “A gestão não botar no calendário, não apoiar. Fica difícil, né? É meio complicado” (E5).* Nesse sentido, é importante que o IFC tenha um planejamento das ações, por demandar de organização e recursos financeiros.

Constatou-se que os participantes têm desejo de que uma agenda de ações educativas seja colocada em prática no IFC, pois isso sistematiza as ações de saúde, com a realização de atividades de maneira organizada e planejada. *“Muito. Dessa forma, a gente não ia se sentir*

tão solto como a gente se sente. A gente já tá engajado” (E1). Sendo assim, ações organizadas e sistematizadas no ambiente escolar geram segurança para os profissionais, fortalecem o trabalho em equipe multiprofissional e possibilitam a contribuição para formação integral dos estudantes.

Nessa perspectiva, percebemos que os entrevistados reconhecem a importância de ações de educação em saúde visando a uma formação integral do estudante. O enfermeiro contribui significativamente na vida dos estudantes, principalmente na fase da adolescência. O enfermeiro colabora na adoção de práticas educativas, por meio de consultas de enfermagem, ações de saúde como rodas de conversas, palestras, oficinas etc. Visto isso, salienta-se que, por meio dessas ações, o profissional de enfermagem consegue incentivar o autocuidado dos adolescentes, proporcionando conhecimentos sobre sua saúde, diminuindo assim os fatores de riscos e aumentando a qualidade de vida desse público-alvo (Anjos *et al.*, 2022 a).

Os entrevistados têm conhecimento da importância de desenvolver ações de educação em saúde no ambiente escolar e procuram realizar ações de educação em saúde nos seus *campi* como campanhas outubro rosa, novembro azul, sexualidade, etc. Os participantes da pesquisa destacam a importância de ter ações alinhadas/padronizadas entre os *campi*, respeitando as especificidades de cada local e também parcerias com a rede de atendimento como Secretarias Municipais de Saúde para desenvolvimento de ações.

Assim, o IFC, que possui profissionais de enfermagem, pode, por meio deles, estimular os adolescentes quanto ao autocuidado, hábitos de vida mais saudáveis e torná-los replicadores dos conhecimentos em saúde na sociedade, estimulando o **potencial dos alunos como agentes de mudança**.

Cabe pontuar que os entrevistados mencionam a importância do uso da tecnologia para o desenvolvimento de ações, por serem meios que chamam a atenção do público-alvo, que são estudantes adolescentes. Isso pode ser observado nas falas quando questionados sobre: “Quais ações de educação e prevenção em saúde são desenvolvidas no seu *campus*?”.

A gente vai começar esse ano a desenvolver, né? Mas sempre quando tem, por exemplo, alguma semana, por exemplo, dezembro, novembro, azul outubro rosa, a gente coloca cartazes e informando, né? Como eu comecei há pouco, foram feitas duas, três campanhas pequenas ainda. Mas a gente pretende fazer exposições, palestras, orientações, fazer jogos interativos também, né, para que eles consigam e [...] Naquele jeito deles prestar atenção, né? Como eu falei, a tecnologia a gente vai ter que usar no nosso trabalho, né? Porque é algo que tu consegue prender eles e lá falar por um bom tempo. Às vezes a gente não, não vai ser atrativo, então busca de alguma forma que eles consigam. [...] Assimilar e aprender em forma que se torne algo bem atrativo para eles. Que às vezes é usando uma tecnologia (E7).

“A questão de drogas, a questão de sexualidade na adolescência, infecções sexualmente transmissíveis e gravidez não planejada, métodos contraceptivos.” [...] “Além disso, também outros temas, como primeiros socorros, oficinas de primeiros socorros, né” (E1).

Nesse sentido, percebemos que as falas dos entrevistados estão em consonância com a proposta da EPT, que é proporcionar uma educação integral do ser humano que se baseia na integração entre ciência, tecnologia e cultura como dimensões indissociáveis da vida humana, buscando desenvolver no estudante capacidades intelectuais e científicas essenciais para sua autonomia intelectual e participação como cidadão na sociedade. A educação integral também fará com que esse estudante seja capaz de integrar as demandas sociais e os arranjos produtivos locais/regionais, pois, nas falas das entrevistas observamos que os participantes apontam que precisamos pensar nas especificidades de cada local.

Uma das questões abordadas na entrevista refere-se ao entendimento quanto à educação profissional e tecnológica. Essas percepções estão agrupadas na codificação **contribuição do enfermeiro na EPT**. Nesse tópico, vários conceitos foram destacados pelos entrevistados, como formação para o mundo do trabalho, educação integral, formar cidadão, processo de formação do cidadão em várias áreas, como percebemos na fala:

A educação profissional e tecnológica e a formação voltada para o mundo do trabalho. Então que. Que visa uma formação integral não somente de disciplinas básicas, mas para um ensino técnico que realmente integre o estudante para a realidade local, para o mundo do trabalho como cidadão (E5).

A EPT pode construir novos sujeitos históricos, capazes de se inserir no mundo do trabalho, compreendendo-o e transformando-o na direção de um novo mundo possível, capaz de superar a dualidade estrutural, de divisão de classes e restabelecer o ideal da modernidade de liberdade, igualdade e fraternidade, sob a ótica das novas possibilidades abertas à humanidade (Pacheco, 2010). Como enfatiza Grinspun (2001, p. 92): “A educação tecnológica está baseada na concepção de uma educação transformadora, progressista que vai além de uma proposta de ensino na escola para aprofundar-se junto com o projeto político pedagógico da escola, nos dias atuais deve integrar as diferentes categorias do saber”.

Quando questionados sobre de que forma você acredita que sua profissão contribui na EPT? Os entrevistados destacam que essa contribuição se dá através de educação em saúde, como se observa nas falas:

“Ah! Principalmente porque traz a vertente e a importância da saúde para a formação desse estudante. [...] Eu acho que isso é o principal” (E2). “Eu acredito que contribui muito nesse sentido, né? De. De educação, né? Para a vida, né?” [...] “Então, acho que eu, a nossa profissão, ela influencia nesse sentido, na melhora da qualidade de vida pessoal de cada cada cidadão” (E1).

Percebemos que os entrevistados reconhecem que contribuem com a educação integral através das ações de educação em saúde, pois a educação em saúde forma pessoas mais saudáveis, com conhecimento do processo saúde/doença. O estudante com conhecimento em saúde levará esse ensino para a vida dele e será um adulto com melhor qualidade de vida, além de multiplicar este conhecimento no meio em que vive, contribuindo, assim, com uma sociedade mais saudável. Como enfatizam Anjos *et al.* (2022 b), o enfermeiro consegue incentivar o autocuidado dos adolescentes, proporcionando conhecimentos sobre sua saúde, diminuindo assim os fatores de riscos, tornando-os pessoas com hábitos mais saudáveis, aumentando a qualidade de vida desse público.

Uma das questões levantadas durante a entrevista foi a formação omnilateral. Constatou-se que os entrevistados têm desconhecimento sobre o termo “Omnilateral”, apesar de ser um importante conceito na EPT aplicada nos IFs.

“Não conheço” (E4), “Não sei te responder” (E1), “Eu desconheço totalmente esse termo. Nunca ouvi falar” (E7), “Olha, eu nunca, nunca trabalhei com essa palavra. E para falar a verdade, não” (E6). Cabe ressaltar que apenas um dos entrevistados conseguiu definir a formação omnilateral.

Essa formação omnilateral. Ela, como diz ela, é bem abrangente. Ela não restringe a uma. [...] Uma, um assunto ou uma parte específica, né? Ele vai ter esse conhecimento abrangente e como eu já tinha falado antes na questão, né, da da, do papel ali, do profissional enquanto educador, né? Porque ele vai levar aquela bagagem também, né? Na sobre saúde, então, na formação dele e aquela formação cidadã, ele não está só estudando uma disciplina técnica ou não. A. As básicas, né? Está se formando um profissional. É que ele tá levando toda essa bagagem, né? De enquanto profissional(E5).

Porém conseguem expressar quando questionados sobre qual sua contribuição para a formação omnilateral dos estudantes do seu *campus*?

E eu não entendo muito o que significa esse termo. Mas eu penso assim, que a principal contribuição é essa de trazer a questão da saúde. Porque de nada adianta ter um estudante que vai ser um profissional bem formado, com muito conhecimento técnico, mas que não tem uma saúde, não tem uma preocupação com seus hábitos de vida (E2).

Diante disso, percebemos que a maioria dos entrevistados desconhece o termo “omnilateral”, mas consegue definir o seu papel para contribuir na formação omnilateral. Lima (2024, p. 2) define a educação omnilateral como “uma educação emancipatória”, cujo objetivo é a formação integral do ser humano, que contemple as dimensões não somente técnicas, mas culturais, criativas, críticas e cidadãs. Como destacam Araújo *et al.* (2024), a formação omnilateral visa a uma conjugação entre trabalho, cultura e ciência, uma formação integral do estudante, ou seja, busca a formação de cidadãos criativos, autônomos, críticos, reflexivos e

com consciência do seu papel na sociedade. É, portanto, uma “concepção de formação humana, com base na integração de todas as dimensões da vida no processo formativo” (Ramos, 2008, p. 2).

Nesse sentido, é necessário que o IFC, através do núcleo pedagógico e da gestão, traga essas temáticas para serem discutidas nas formações dos servidores, por ser importante os profissionais possuírem o entendimento da educação proposta pela EPT dos IFs.

Os entrevistados conseguem definir a educação integral, apesar de apresentar fragilidades em suas falas, mas reconhecem a importância da atuação da enfermagem na contribuição do desenvolvimento integral dos estudantes, como se observa nas falas quando questionados: “sobre educação integral, como você define?”, aqui apresentadas com a codificação **desenvolvimento integral**.

“É no mesmo sentido que eu falei de da de educar para o para o todo, né, De educar tanto não só né, na nossa área de saúde a nossa área da enfermagem, mas sim de todas as disciplinas, todas as atividades serem de certa forma integrada, né? Seria nesse sentido” (E1).

“Bom, eu defino dentro desse contexto mesmo, né? Não se limitar só às disciplinas, mas a toda uma formação cidadã que envolve diversas, diversas áreas, né? Todo um contexto bem amplo. Formando pessoas para o mundo, né? (E5).

“Eu sei que você tá me perguntando, mas eu acho que é preparar como um todo, né? Preparar o aluno de forma completa pra ele sair daqui pronto para pra atuar e com com outros conhecimentos além da parte técnica” (E4).

“A seria nesse sentido, no sentido de. (...) De contribuir para a educação para a vida do estudante, para a saúde e qualidade de vida. Eu acho que é isso, né? O omnilateral também seria isso, né? Em todos. No todo, né?” (E1).

Nessa perspectiva, as definições dos participantes da pesquisa estão próximas ao conceito de educação integral de Ciavatta (2014), que é possibilitar ao educando o conhecimento do todo, uma educação na sua totalidade social. Sendo assim, o enfermeiro no ambiente escolar é um protagonista em educar em saúde, proporcionando aos discentes conhecimentos em saúde e o desenvolvimento que estimula hábitos de vida mais saudáveis, consequentemente melhorando sua qualidade de vida.

Uma vez identificados os enfermeiros como educadores e partícipes da formação integral dos discentes, analisaremos os dados referentes à codificação **capacitação em educação para o enfermeiro**. Uma vez que na escola o papel primordial do enfermeiro escolar é educar em saúde, suas ações através dos atendimentos, consultas de enfermagem no ambiente escolar podem proporcionar aos educandos conhecimentos e o desenvolvimento do pensamento

crítico relacionados aos seus hábitos de vida, processo de saúde/doença, prevenção de agravos e doenças entre outras.

Acredita-se que o enfermeiro no ambiente escolar faz diferença na vida dos estudantes, ao proporcionar conhecimentos que levarão para a vida. Os entrevistados se compreendem como educadores no ambiente escolar, como podemos perceber nas falas quando questionados sobre “Você compreende um educador em sua função de profissional de enfermagem?” As respostas já avaliadas e as a seguir corroboram com a percepção do enfermeiro na participação da educação e na formação integral dos discentes: “*Sim, me vejo como um educador*” (E7); “*De certa forma, assim que a gente realiza atividades de educação em saúde*” (E1); “*Com certeza.*” (E5); “*Ah, com certeza. Com certeza. A todo momento a gente tá educando, né? Tá levando informação*” (E4).

Segundo Pacheco (2010), todos os que interagem com educandos são educadores, cada um dentro da especificidade de sua tarefa. Professores, técnicos, funcionários etc. são todos trabalhadores em educação e suas atuações na escola devem ser integradas pedagogicamente, tendo o reconhecimento da escola enquanto ação educativa.

Cabe ressaltar que dois participantes da pesquisa desconhecem a missão da EPT dos IFs, “*Não*” (E4). “*Não conheço. Ainda não. Ainda não conheço*” (E3). Enquanto um diz conhecer superficialmente, “*Conheço superficial ainda. Ainda não. Não estou bem-adaptado a ela ainda. Tá bom*” (E7). Quatro dos entrevistados relatam que conhecem a missão da EPT, porém não sabem expressá-la, conforme as falas: “*Olhe, eu acho que eu já cheguei a ler em algum momento, mas não, não lembro. Não estou lembrado, mas já*” (E1). “*Conheço, mas não sei se saberia dizer assim, mas eu sei que existem missão, valores, né?*” (E2). “*Aí eu conheço agora de cabeça, mas não foram tantos anos escutando que agora eu esqueci. Mas eu conheço assim né? Digamos eu conheço*” (E5). “*Sim, conheço*” (E6).

A EPT dos IFs tem como missão proporcionar educação profissional, atuando em ensino, pesquisa e extensão, comprometida com a formação cidadã, a inclusão social, a inovação e o desenvolvimento regional. A concepção de educação profissional e tecnológica que subsidia as ações de ensino, pesquisa e extensão nos Institutos Federais baseia-se na integração entre ciência, tecnologia e cultura como dimensões indissociáveis da vida humana e, ao mesmo tempo, no desenvolvimento da capacidade de investigação científica, essencial à construção da autonomia intelectual e participação cidadã.

Desta forma, dentro das missões dos IFC, capacitar e valorizar o enfermeiro é necessário para que ele atue frequentemente e efetivamente como um educador capacitado, capaz de contribuir significativamente para formação integral, oferecendo orientações sobre saúde,

promovendo o autocuidado e atuando como um agente de mudança na disseminação de conhecimento.

5 PRODUTO EDUCACIONAL

Antes de apresentarmos o produto educacional pretendido pela pesquisa, faz-se necessário entendermos o que são produtos educacionais e o processo da sua elaboração. Kaplún (2003, p. 46) nos ajuda a entender o que é um produto educacional e o porquê da complexidade existente em sua elaboração, ao dizer que este se trata de:

[...] um objeto que facilita a experiência de aprendizado; ou, se preferirmos, uma experiência mediada para o aprendizado. Esta definição aparentemente simples tem várias consequências. A que mais nos importa é a que diz que um material educativo não é apenas um objeto (texto, multimídia, audiovisual ou qualquer outro) que proporciona informação, mas sim, em determinado contexto, algo que facilita ou apoia o desenvolvimento de uma experiência de aprendizado, isto é, uma experiência de mudança e enriquecimento em algum sentido; conceitual ou perceptivo, axiológico ou afetivo, de habilidades ou atitudes, etc.

Sendo assim, uma videoaula, uma oficina, um prontuário, um protocolo, uma cartilha ou um livro só podem ser considerados produtos educacionais se proporcionarem, facilitarem ou enriquecerem as experiências de aprendizagem para quem deles se servir. Um produto educacional deve proporcionar mudanças significativas no processo de ensino-aprendizagem, por isso sua criação não é uma tarefa simples. Além da sua característica de desenvolvedor de uma experiência de aprendizado e mudança, a criação de um produto educacional deve seguir algumas etapas, dentro de alguns critérios, que variam desde a sua elaboração até a sua aplicação. Por isso, devemos ficar atentos a esse percurso.

Kaplún (2003, p. 47) afirma que “o processo de produção de um material educativo é uma tríplice aventura: a da criação, a do próprio material e a do uso posterior, que muitas vezes escapa às intenções iniciais e aos cálculos dos criadores”.

Esse processo de produção de um produto educacional é descrito por Kaplún (2003) ao revelar que existem três eixos norteadores que devem ser seguidos no momento de realizar a análise e a construção dos produtos educacionais, considerados pelo autor como materiais educativos ou mensagens educativas. Estes eixos são descritos, em ordem sequencial, como sendo:

a) Eixo conceitual: este eixo refere-se aos estudos dos conteúdos que serão abordados no produto educacional, sua seleção e organização, na busca de se conhecer de forma mais aprofundada o tema e a opinião de autores que sejam referência na temática do produto, a fim de que, assim, possamos “conhecer a fundo a matéria em questão, os conceitos que articulam, os mais importantes debates suscitados por ela, etc.” (Kaplún, 2003, p. 48).

b) Eixo pedagógico: é “o articulador principal de um material educativo[...] é através dele que estabeleceremos um ponto de partida e um ponto de chegada, em termos de tentativa, para o destinatário do material” (Kaplún, 2003, p. 49).

Trata-se de um itinerário pedagógico, que conta com uma sondagem inicial junto ao público-alvo, buscando, por meio de uma análise das ideias construtoras destes sobre a temática do produto, identificar seus conhecimentos prévios sobre tal temática e, assim, promover possíveis conflitos conceituais, ou seja, “tornar problemática a concepção inicial do sujeito”, gerando uma “insatisfação conceitual” nos sujeitos, que nos possibilitará apresentar uma “nova construção ou reconstrução” desta temática, mediante um produto educacional que atenda às necessidades deste público-alvo, proporcionando-lhes, assim, a construção de novas percepções sobre este mesmo tema (Kaplún, 2003, p. 50-51).

c) Eixo comunicacional: refere-se ao modo como a história do produto será contada e apresentada. Para tal, devemos considerar as características dos sujeitos aos quais tal produto se destina, tendo “um bom banco de experiências, códigos, histórias e imagens que provêm dos próprios destinatários” (Kaplun, 2003, p. 54). Trata-se de um eixo desafiador, pois se corre o risco de que, devido à complexidade do tema abordado no eixo conceitual, o produto caia no didatismo e se torne pouco atrativo ou pouco funcional. Kaplún, (2003, p. 54), declara que “é preciso animar-se a romper moldes para que a mensagem educativa não seja, uma vez mais, equivalente a um sermão impresso ou a uma chatice audiovisual”.

Por fim, é importante ressaltar que tal “história tem que agradar-nos (se não, a quem agradará?), mas não estamos escrevendo (só) para nós mesmos” (Kaplún, 2003, p. 55). Portanto, algo que nos agrada talvez não agrade ao público-alvo do produto educacional. Daí surge a importância de conhecer estes participantes e de moldar um produto que se adeque às expectativas do público.

5.1 Apresentando o produto educacional

Esta pesquisa teve em vista compreender as percepções da equipe de enfermagem quanto às atividades da sistematização da assistência de enfermagem e das ações de educação em saúde no IFC na formação integral dos educandos. A fim de contribuir com esses profissionais, para uma consciente e persistente atuação na formação humana integral dos estudantes, as percepções e dificuldades foram elencadas e formaram a base para a construção do produto educacional. Essa análise resultou na elaboração prévia dos produtos educacionais, e na segunda versão melhorada, após aplicação e avaliação via grupo focal e questionário *on-line*, com os enfermeiros participantes da pesquisa.

Os produtos educacionais criados foram: prontuário unificado, para uso dos profissionais da enfermagem do IFC, e cronograma de ações de educação, para a prevenção e promoção à saúde. Os produtos Prontuário Unificado e o Cronograma de Ações estão inseridos em sua íntegra nos Apêndices C e D respectivamente.

5.2 Avaliação do produto educacional

Os produtos educacionais construídos foram enviados aos participantes da pesquisa para análise via *e-mail*, e agendado um encontro *on-line* via grupo focal após um período de 15 dias. No grupo focal, foi estimulada a análise e o debate sobre a qualidade e aplicabilidade do produto educacional, analisando todos os trechos de informações inseridas nos produtos educacionais. O grupo focal foi gravado para tomada de notas sobre os itens a serem melhorados e a percepção do aceite do produto, porém sua intenção foi a sensibilização para a realização da avaliação, de maneira individual, através de questionário padronizado.

A avaliação foi realizada a fim de identificar o percentual e os graus de aceitabilidade e a opinião quanto o produto, além da tomada de nota sobre pontos fortes e fracos realizada através de questões com respostas discursivas.

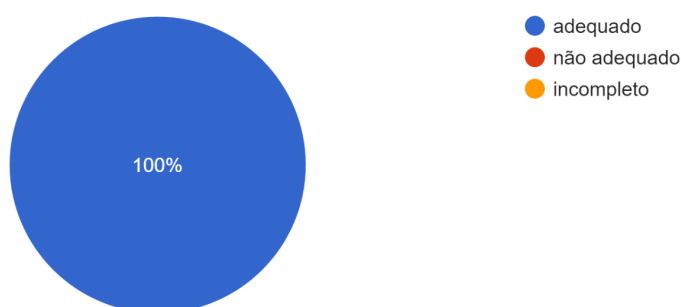
As respostas do questionário foram avaliadas e apresentadas em forma de gráficos para questões optativas, e os textos em seu formato literal, para as questões discursivas. Os dados foram analisados quanto à aceitação ou à rejeição dos produtos educacionais, bem como as considerações e sugestões para a sua melhoria, conforme segue abaixo.

No Gráfico 4, referente à primeira questão, observamos que todos os participantes consideraram adequado o conteúdo apresentado no prontuário unificado.

Gráfico 4 – Avaliação da adequação das informações solicitadas aos pacientes no produto educacional: prontuário de assistência de enfermagem

1. Você considera adequado o conteúdo a ser registrado no prontuário de assistência de enfermagem apresentado?

7 respostas



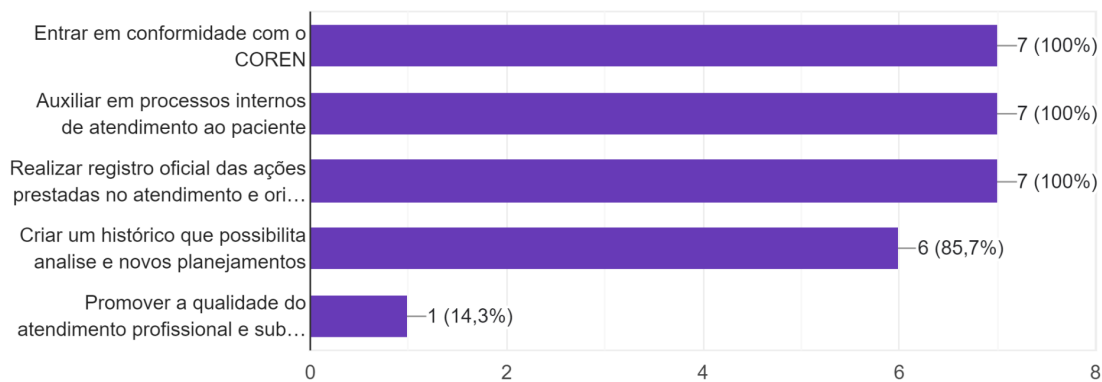
Fonte: Criado pela autora.

Os participantes apontam como vantagem realizar registros da assistência de enfermagem em prontuário padronizado, devido atender às legislações/resoluções do exercício profissional, além de auxiliar nos processos internos da assistência de enfermagem e de ter um histórico das ações e atendimentos de enfermagem, possibilitando uma melhor organização e planejamento de ações (Gráfico 5).

Gráfico 5 – Avaliação da identificação de vantagens ao utilizar um prontuário de assistência de enfermagem padronizado

3. Quais as vantagens que você identifica ao fazer o registro da assistência de enfermagem em prontuário padronizado? Pode ser selecionado mais de uma opção.

7 respostas



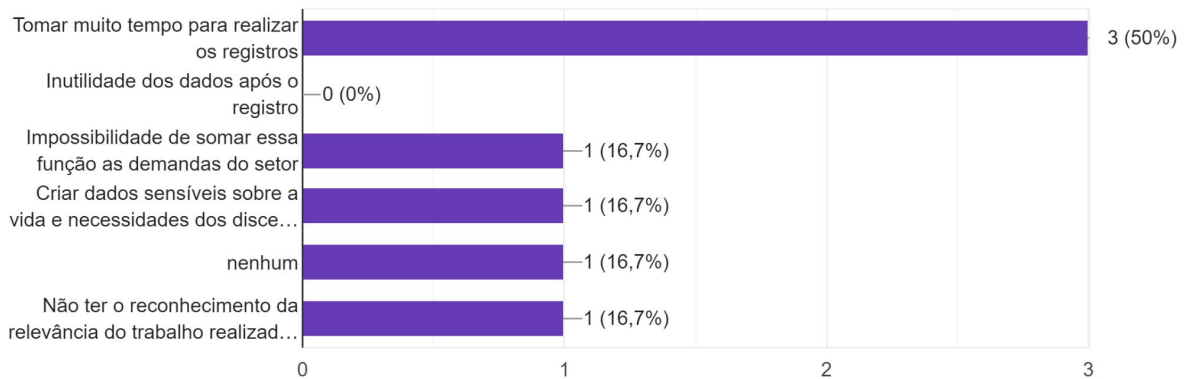
Fonte: Criado pela autora.

Quanto às desvantagens ao fazer os registros, três entrevistados entendem que pode levar muito tempo para realizar os registros, um enxerga a impossibilidade de somar essa função às demandas do setor, um menciona a preocupação em criar dados sensíveis sobre a vida e necessidades dos estudantes, um ainda aponta não ter o reconhecimento da relevância do trabalho realizado e um entende não ter nenhuma desvantagem (Gráfico 6).

Gráfico 6 – Avaliação da identificação de desvantagens ao utilizar um prontuário de assistência de enfermagem padronizado

4. Quais as desvantagens que você identifica ao fazer o registro da assistência de enfermagem em prontuário padronizado? Pode ser selecionado mais de uma opção.

6 respostas



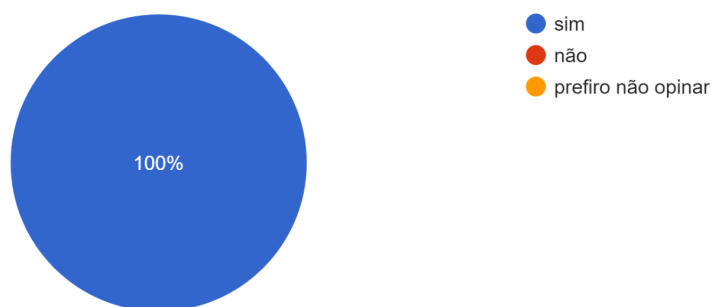
Fonte: Criado pela autora.

No Gráfico 7, observamos que 100% dos entrevistados consideram que as anotações/registros da assistência de enfermagem no IFC em prontuário padronizado irão melhorar a assistência de enfermagem aos estudantes e comunidade escolar.

Gráfico 7 – Avaliação da consideração sobre melhorias na assistência de enfermagem ao paciente devido utilizar um prontuário de assistência de enfermagem padronizado

5. Você considera que as anotações/registros da assistência de enfermagem no IFC em prontuário padronizado de fato irão melhorar a assistência de enfermagem ao paciente?

7 respostas



Fonte: Criado pela autora.

Na questão 6, abaixo apresentada, observamos que os entrevistados acreditam que os registros de enfermagem em prontuário padronizado no IFC, podem melhorar de fato a assistência ao estudante. Afirmam que através dos registros e do histórico de saúde, é possível o conhecimento do público atendido, possibilitando uma melhor resolutividade dos problemas.

Abordam ainda que os registros de enfermagem em prontuário padronizado qualificam a consulta de enfermagem, melhoram a qualidade dos atendimentos e possibilitam continuidade

do cuidado. Somados a isso, também proporcionam quantificar os atendimentos e ações, além de darem subsídios para planejamento de ações de prevenção em saúde. Nesse sentido, proporciona-se um atendimento de saúde de forma contínua.

A questão 6 indagou: Quais motivos acredita que as anotações/registros da assistência de enfermagem em prontuário padronizado no IFC podem melhorar de fato a assistência de enfermagem ao paciente? Por quê? As respostas foram as seguintes:

“Manter uma história progressão da atenção de enfermagem aplicada ao aluno ou servidor, assim como conhecimento de informações pertinentes a esse atendimento”.

“Meio de obter informações importantes sobre o paciente possibilitando melhor resolutividade do problema”

“Porque esse processo facilita os próximos atendimentos ao aluno”

“Melhora o seguimento, da mais qualidade ao serviço, e ainda, é possível quantificar os atendimentos”.

“[...] a consulta de enfermagem porque favorece que nessa oportunidade seja abordada a saúde do estudante de forma integral e continuada”.

“Sistematizar e padronizar ajuda a organizar as informações para planejar melhor as ações de prevenção”.

“Acredito que os registros são fundamentais para podermos realizar a avaliação da qualidade da atuação do profissional de enfermagem. Contribui para a comunicação dos procedimentos realizados com os demais membros da equipe, o que proporciona a continuidade da assistência prestada. Proporciona respaldo ao profissional, no âmbito de sua atuação, como garantia das atividades executadas, evitando por exemplo, a duplicidade de alguma atividade ou a ausência de sua realização. Cabe destacar a relevância da melhoria da qualidade no atendimento ao paciente, no sentido de que os registros podem gerar indicadores para o desenvolvimento de ações de promoção/ prevenção a agravos à saúde coletiva para a comunidade institucional. Além disso, sob o aspecto legal, é responsabilidade do profissional de enfermagem a realização dos registros e anotações das suas atividades”.

Os entrevistados concordam que os registros da assistência de enfermagem e as ações de prevenção e promoção da saúde contribuem para formação integral dos estudantes, pois os registros proporcionam informações aos profissionais para possíveis intervenções e ações de prevenção e promoção da saúde, além de capacitar os estudantes em relação aos cuidados com a própria saúde, e de torná-los multiplicadores desse conhecimento no meio em que convivem. Verificamos essas percepções nas respostas obtidas na questão discursiva 7.

A questão 7 indagou: Você considera que os registros da assistência de enfermagem e as ações de prevenção e promoção à saúde contribuem para a formação integral? Explique.

“Sim, pois através dos atendimentos gera-se maior conhecimento de causa aos profissionais”.

“Sim, possibilita análise dos dados encontrados que apresentem maior demanda”

“Com certeza, os registros ajudam a traçar novas metas de ações de prevenção de saúde e colaboram para que possamos enxergar o que precisa ser feito”.

“Com certeza. A saúde está atrelado a qualidade de vida, sendo assim, esse aluno que foi capacitado para cuidar de sua saúde estará apto até mesmo de replicar conhecimentos”.

“Sim, pois a saúde é um tema transversal na formação pessoal e profissional do estudante”.

“sim, pois as ações devem ser pautadas na realidade dos alunos”.

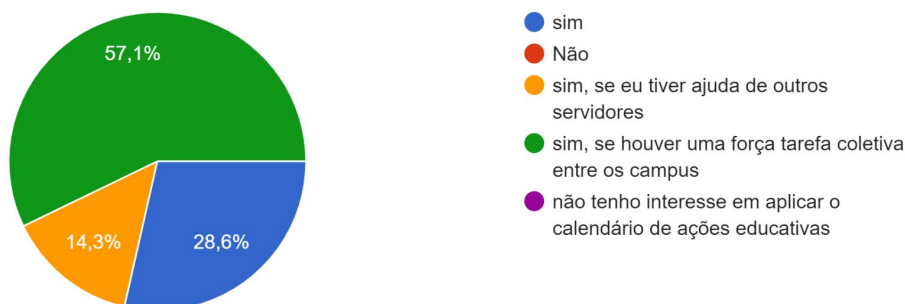
“Sim. Acredito que os registros constituem em indicadores importantes para subsidiar o desenvolvimento de ações de promoção/ prevenção a agravos à saúde na instituição, bem como, incentivar pesquisas e ações extencionistas com a participação dos estudantes”.

Observa-se no Gráfico 8 que 57% dos entrevistados consideram possível aplicar o cronograma de ações de educação em saúde se houver uma força tarefa coletiva entre os *campi*, 28,6% consideraram possível e 14,3% consideram possível se tiverem ajuda de outros servidores.

Gráfico 8 – Avaliação da consideração sobre a possibilidade da aplicação de calendário unificado entre os campus de ações de educação em saúde

8. Você considera possível aplicar o calendário unificado entre os campus do IFC de ações de educação em saúde?

7 respostas



Fonte: Criado pela autora.

Os entrevistados sentem-se motivados em fazer parte destas ações propostas na pesquisa, conforme demonstrado no Gráfico 9.

Gráfico 9 – Avaliação sobre a motivação na aplicação diária dos produtos educacionais: prontuário de assistência de enfermagem e calendário de ações de educação em saúde

9. Você se sente motivado em fazer parte destas ações de registro e de ações de educação em saúde?

6 respostas



Fonte: Criado pela autora.

A partir das respostas obtidas no Gráfico 9, observam-se resultados satisfatórios quanto à aprovação dos produtos educacionais e quanto à possibilidade deles efetivamente apresentarem soluções para a dinâmica da equipe de enfermagem. A criação deste produto educacional somente trará benefícios aos profissionais de enfermagem e, assim, aos educandos, se os enfermeiros se sentirem motivados e desejarem utilizar os produtos educacionais em suas práticas profissionais.

A questão 10 perguntou: Quanto ao calendário apresentado de ações de educação em saúde unificado, quais itens retiraria? Quais itens adicionaria?

6 respostas

“Estão ok assim”.

“nenhum”

“Não mudaria”.

“Tudo ok”.

“considerando a minha demanda atual e o apoio que eu poderia ter para desenvolvê-las, acredito que um calendário bimestral seria mais plausível. Não vejo atualmente a possibilidade de desenvolver ações mensais, mesmo que algumas ações dessas envolvam atividades simples como enviar um e-mail sobre o tema, isso também demanda pesquisa e elaboração, ou seja, tempo”.

“está excelente”.

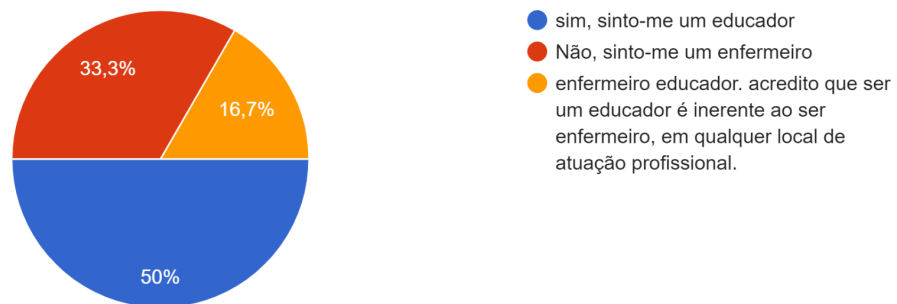
Percebe-se na questão 10 que os entrevistados concordam com o calendário apresentado de ações de educação em saúde. Acreditamos ser importante uma revisão anual do calendário de ações com os profissionais de enfermagem para planejamentos, adaptações e revisão, além de troca de experiência quanto à sua aplicabilidade.

Percebe-se, no Gráfico 10, que 50,1% dos entrevistados sentem-se como educadores realizando ações de educação em saúde, 33,3% sentem-se enfermeiro e 16,7% sentem-se um enfermeiro educador.

Gráfico 10 – Avaliação sobre a auto identificação do enfermeiro quanto a sua atividade de educador quando promove as ações de educação em saúde

11. Você se sente educador ao realizar as ações de educação em saúde?

6 respostas



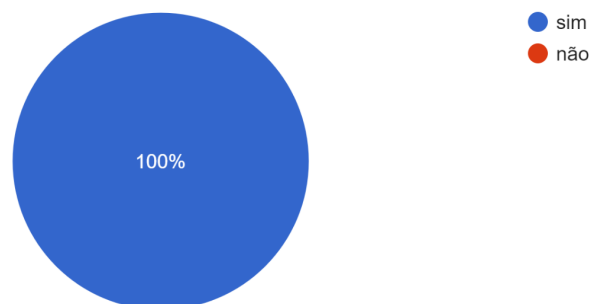
Fonte: Criado pela autora.

O Gráfico 11 demonstra que todos os entrevistados concordam que as atividades de educação em saúde contribuem para a formação omnilateral.

Gráfico 11 – Avaliação sobre a contribuição para o desenvolvimento omnilateral dos estudantes promovido pelas ações de educação em saúde

12. Ao realizar atividades e as ações de educação em saúde, acredita que essas contribuem para a formação omnilateral? Por que?

7 respostas



Fonte: Criado pela autora.

A partir das respostas apresentadas na questão 13, percebemos que os entrevistados consideram importante um contato contínuo com demais colegas para troca de experiências e para a padronização de ações, documentos entre outros.

A questão 13 indagou: Você considera necessário o contínuo contato com os colegas profissionais de enfermagem dos demais *campi* para que essas ações sejam realizadas e fortalecidas? Por qual motivo?

7 respostas

“Sim, pois a troca de experiências gera maior efetividade nas ações”.

“Sim, para o alinhamento das atividades e troca de experiências.”

“Sim, para termos ideia do andamento das atividades e como estão se comportando.”

“Certeza. A padronização é essencial para a qualidade do serviço.”

“sim, para trocar ideias sobre as possibilidades de ações e até mesmo realizar alguma dessas em conjunto ou simultaneamente.”

“Sim, a atividade deve ser em conjunto com todos os enfermeiros, inclusive os técnicos”

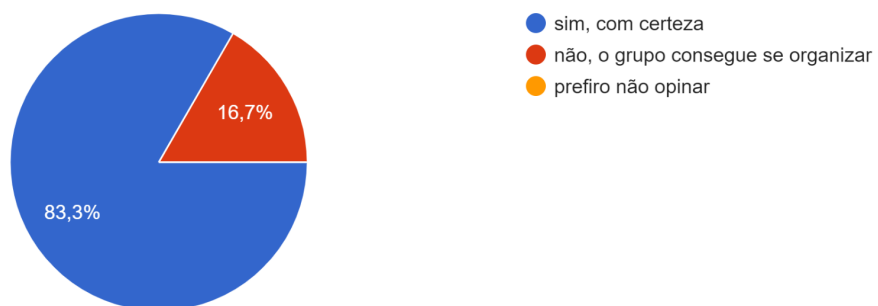
“Sim, contribui para o fortalecimento das propostas das ações.”

No Gráfico 12, percebemos que 83,3% dos entrevistados consideram interessante ter alguém entre os profissionais para coordenar e motivar as atividades de enfermagem no IFC.

Gráfico 12 – Avaliação sobre a questão: Você acredita que para a efetivação do calendário de ações seria interessante a eleição/seleção entre os profissionais de enfermagem um coordenador para organizar/motivar as atividades unificadas de enfermagem?

14. Você acredita que para a efetivação do calendário de ações seria interessante a eleição/seleção entre os profissionais de enferma.../motivar as atividades unificadas de enfermagem?

6 respostas



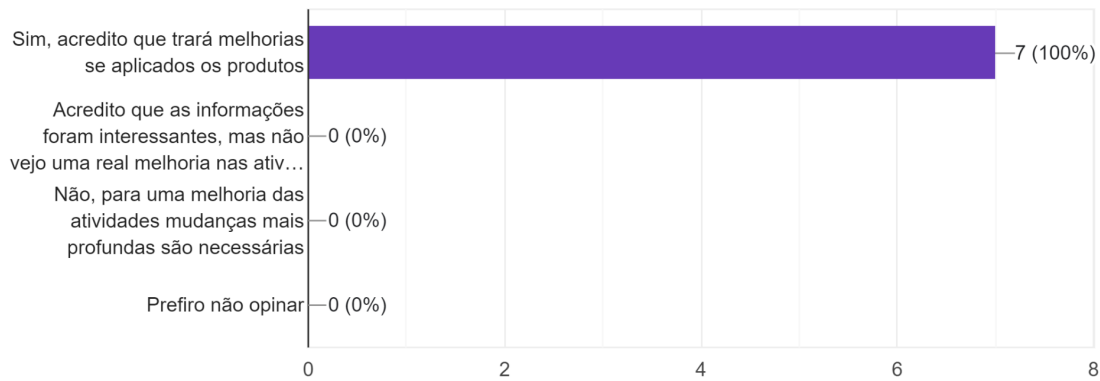
Fonte: Criado pela autora.

Percebe-se, no Gráfico 13, que 100% dos enfermeiros entendem que a pesquisa trouxe informações relevantes para a equipe de enfermagem e que a aplicação dos produtos educacionais trará melhorias nas atividades da equipe de enfermagem no IFC.

Gráfico 13 – Avaliação sobre a possibilidade de melhorias no setor de enfermagem no IFC através da pesquisa realizada e produtos educacionais gerados

15. Você considera que essa pesquisa trouxe informações ou diagnósticos que permitem auxiliar nas atividades da equipe de enfermagem no IFC e possibilitam melhorias no setor?

7 respostas



Fonte: Criado pela autora.

Para finalizar a avaliação dos produtos educacionais, questionamos aos enfermeiros(as) participantes da pesquisa quanto aos pontos fortes e fracos, e solicitamos apontamentos de intervenção nos produtos, conforme verificamos nas respostas das questões 18 e 19 a seguir.

18. Apresente os pontos que você considerou forte nos produtos educacionais.

5 respostas

“O produto contempla todas as informações necessárias à atenção de saúde do discente.”

“A educação em saúde é uma pauta escassa nos IFCs, então realmente, a pesquisa nos faz refletir sobre a importância do enfermeiro na educação.”

“O registro do histórico do estudante, o exercício do diagnóstico de enfermagem e a segurança profissional do registro efetivo.”

“clareza e objetividade.”

“A padronização dos registros para a continuidade e o aprimoramento da qualidade dos serviços de enfermagem na instituição.”

19. Apresente suas críticas quanto aos produtos apresentados e a pesquisa realizada.

Três respostas.

“O produto ficou muito bom, com todas as informações necessárias, no entanto a folha de anotação e evolução de enfermagem deveria ser separada. No enunciado evolução de enfermagem pode conter também anotações de enfermagem, tendo em vista que o técnico anota e o enfermeiro anota e evolui”.

“Não tenho críticas. os produtos parecem abrangentes para facilitar a execução do processo de enfermagem e flexíveis para serem adaptados à realidade de cada enfermeiro”.

“sem críticas. Deveria haver adesão de todos os enfermeiros e técnicos”.

Percebemos que, nas avaliações, os entrevistados são favoráveis ao produto educacional apresentado e enfatizam que os registros de enfermagem e as ações de educação em saúde padronizadas melhoram a assistência de enfermagem ao educando, contribuindo, assim, com a formação integral.

Os entrevistados apontam vantagens em ter registros padronizados como atender a legislação/resoluções do órgão fiscalizador e a melhoria na assistência de enfermagem. Para eles, os registros oferecem subsídios aos profissionais para planejamento de ações de promoção e prevenção à saúde.

O produto educacional proposto representa uma alternativa de sistematização da assistência de enfermagem no IFC, buscando contribuir com a educação integral proposta pela EPT.

5.3 Aprimoramento do produto educacional após avaliação

Quanto ao Produto Educacional I “Prontuário unificado”, após avaliação dos enfermeiros, foi possível realizar melhorias, conforme sugerido no grupo focal e no formulário de avaliação.

Abaixo apresentamos as alterações/adaptações realizadas, e adicionamos o Prontuário unificado aprimorado em Apêndice E com Anexos A e B.

Quanto ao Produto Educacional II Cronograma de ações em educação e promoção/prevenção em Saúde, realizamos uma pequena alteração, somente excluimos a “Avaliação do crescimento e desenvolvimento do adolescente” pelo fato de já fazer parte da consulta de enfermagem.

5.3.1 Alterações realizadas no produto educacional I “Prontuário unificado”, visando ao seu aprimoramento.

1 Anamnese

1.1 - Identificação do estudante

- Acrescentado moradia estudantil;
- Acrescentado número carteirinha do SUS e/ou carteira do plano de saúde.

1.2 - História Pregressa

- Acrescentado na pergunta referente às Cirurgias “há quanto tempo”;
- Acrescentado a seguinte questão: “Possui algum problema de saúde com diagnóstico estabelecido?”
- Acrescentado na questão referente aos acompanhamentos médicos “há quanto tempo”

1.3 - Informações complementares

- Alterado na questão da renda do adolescente para “renda bruta familiar”;
- Alterado a questão como sente-se com sua vida para “Você sente-se feliz com sua vida”;

2 - Consulta de enfermagem subsequente

- Acrescentado anotação de enfermagem.

3 - Encaminhamento de Saúde Unificado: Acrescentado um modelo de encaminhamento de saúde padronizado para uso dos profissionais de enfermagem no IFC.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A pesquisa apontou que os entrevistados têm uma vasta experiência na enfermagem, anteriormente à sua atuação no IFC, principalmente em ambiente hospitalar e saúde pública. Os participantes veem muitas diferenças na atuação dos locais onde já atuaram em comparação com a atuação no ambiente escolar, ao entenderem que na escola a atuação da enfermagem deve ser mais focada na prevenção e na promoção da saúde.

Os resultados indicaram que a atuação do enfermeiro no ambiente escolar é voltada, principalmente, para ações de promoção e prevenção em saúde, contribuindo, assim, com a educação integral. A análise ainda indicou que os enfermeiros se sentem educadores atuando no ambiente escolar e entendem que é fundamental ter ações e registros de enfermagem padronizados e sistematizados. Também se constatou que os enfermeiros sentem falta de uma proximidade com demais colegas para padronização de documentos e regimentos e para o planejamento de ações conjuntas e troca de experiências.

Observou-se, com a pesquisa, que os enfermeiros têm desejo de um cronograma de ações de educação em saúde construído em conjunto e que seja colocado em prática no IFC, porém desejam que sejam consideradas as especificidades de cada *campus*. Fica claro nos resultados a importância do trabalho em equipe multiprofissional para o desenvolvimento de ações, buscando uma formação integral do aluno.

Foi possível perceber que os participantes têm demasiado desejo de ter um sistema de registros padronizado, em especial se for informatizado (*software*), por acreditarem que um prontuário eletrônico facilita a forma de registros, oferece segurança aos profissionais e paciente, facilita os processos de trabalho, melhora a qualidade do atendimento ao paciente e contribui com a formação integral, pois através dos registros conhecemos o histórico de saúde dos nossos estudantes. Essas informações darão subsídios para planejamento de ações de prevenção e promoção da saúde e intervenções.

Diante disso, é importante o IFC, através da sua equipe multiprofissional e de gestão, pensar em estratégias para uma proximidade dos profissionais de enfermagem para troca de experiências, planejamento e padronização de ações, documentos, entre outros. Também é fundamental planejar a produção de um sistema informatizado para os registros da assistência de enfermagem, mas não só para a enfermagem, esse sistema deveria se estender para as equipes de atendimento ao educando, respeitando os preceitos éticos e legais de cada profissão. Cabe ressaltar que nesta pesquisa os participantes demonstraram preocupação com o tratamento de

dados dos registros, pois informações de saúde são sigilosas e devem ser seguidas as legislações e resoluções dos órgãos fiscalizadores.

Desta forma, acreditamos que o enfermeiro no ambiente escolar faz diferença na vida dos discentes, estimulando hábitos de vida mais saudáveis, o conhecimento do processo saúde/doença e o desenvolvimento da autonomia nos cuidados com sua saúde dos adolescentes, que passam a ser multiplicadores desses conhecimentos no meio em que vivem. Nesse sentido, a atuação do enfermeiro no IFC contribui de forma significativa na formação integral proposta pela EPT, através das ações de educação em saúde, dos atendimentos, orientações e consultas de enfermagem. Cabe ressaltar ainda que o enfermeiro faz parte da equipe multiprofissional do IFC, proporcionando um atendimento integral aos estudantes, melhorando sua qualidade de vida, facilitando o acesso aos serviços da rede de atendimento, principalmente para os estudantes em situação de vulnerabilidade, o que, conseqüentemente, contribui para o ensino, aprendizagem, permanência, êxito e sucesso escolar.

REFERÊNCIAS

- ABREU, Flávia Regina da Costa *et al.* Percepção das adolescentes sobre a consulta de Enfermagem na Atenção Básica de Saúde. **Revista Eletrônica Acervo Saúde**, [s. l.], v. 12, n. 5, e2988, 2020. DOI: 10.25248/reas. e2988.2020. Disponível em: <https://acervomais.com.br/index.php/saude/article/view/2988/1647>. Acesso em: 26 jul. 2024.
- ANJOS, Jussara Soares Marques *et al.* A importância do enfermeiro na promoção da saúde de adolescentes no âmbito escolar: relato de experiência. **Revista Eletrônica Acervo Saúde**, [s. l.], v. 15, n. 6, e10491, 2022. DOI: 10.25248/REAS.e10491. 2022a. Disponível em: <https://acervomais.com.br/index.php/saude/article/view/10491/6253>. Acesso em: 26 jul. 2024.
- ANJOS, Jussara Soares Marques *et al.* Atuação da enfermagem em ambiente escolar: uma revisão integrativa. **Revista Eletrônica Acervo Saúde**, [s. l.], v. 15, n. 6, e10248, 2022b. DOI: 10.25248/REAS.e10248.2022b. Disponível em: <https://acervomais.com.br/index.php/saude/article/view/10248/6190>. Acesso em: 26 jul. 2023.
- ARAUJO, Robson de Paula; MENIN, Olavo Henrique; DIAS, André Luís. Iniciação Científica para formação omnilateral: capacitação de orientadores da Educação Profissional e Tecnológica. **Revista Brasileira de Ensino de Ciência e Tecnologia**, Ponta Grossa, v. 17, p. 1-18, 2024. DOI: 10.3895/rbect.v%25vn%25i.17159. Disponível em: <https://periodicos.utfpr.edu.br/rbect/article/view/17159>. Acesso em: 26 jul. 2024.
- ASSUNÇÃO, Marhla Laiane de Brito *et al.* Educação em saúde: a atuação da enfermagem no ambiente escolar. **Rev. enferm. UFPE on line**, [Recife], v. 14, e243745, 2020. DOI: 10.5205/1981-8963.2020.243745. Disponível em: <https://periodicos.ufpe.br/revistas/index.php/revistaenfermagem/article/view/243745/34759>. Acesso em: 26 jul. 2024.
- ÁVILA, Grazielly Soares *et al.* Prontuário eletrônico na gestão do cuidado em equipes de saúde da família. **Cogitare Enfermagem**, [s. l.], v. 27, e79641, 2022. DOI: 10.5380/ce.v27i0.79641. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/cenf/a/HDNgYCbWhCSvWNdsHkrRJhQ>. Acesso em: 26 jul. 2024.
- AZEVEDO, Oswalcir Almeida de *et al.* Documentação do processo de enfermagem em instituições públicas de saúde. **Revista da Escola de Enfermagem da USP**, [s. l.], v. 53, e03471, 2019. DOI: 10.1590/S1980-220X2018003703471. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/reusp/a/NxpGwW8HpCfJVN7JhcsHFSd>. Acesso em: 26 jul. 2024.
- BARDIN, L. **Análise de conteúdo**. São Paulo: Edições 70, 2016.
- BARROS, Alba Lúcia Botura Leite de; FAKIH, Flávio Trevisani; MICHEL, Jeanne Liliane Marlene. O uso do computador como ferramenta para a implementação do processo de enfermagem: a experiência do Hospital São Paulo/Unifesp. **Revista Brasileira de Enfermagem**, Brasília, DF, v. 55, n. 6, p. 714-719, nov./dez. 2002. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/reben/a/QdnTM8kN5ZXLnBbTF8StV9j>. Acesso em: 26 jul. 2024.
- BASTOS, Patrícia de Oliveira *et al.* Atuação do enfermeiro brasileiro no ambiente escolar: revisão narrativa. **Research, Society and Development**, [s. l.], v. 10, n. 9, e31410918089, 2021. DOI: 10.33448/rsd-v10i9.18089. Disponível em: <https://rsdjournal.org/index.php/rsd/article/view/18089>. Acesso em: 26 jul. 2024.

BRASIL. **LEI N 5.905/73, DE 12 DE JULHO DE 1973.** Dispõe sobre a criação dos Conselhos Federal e Regionais de Enfermagem e dá outras providências. Disponível em: [www.planalto.gov.br > ccivil_03 > leisL5905 - Planalto](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L5905-Planalto). Acesso em 20 Mar de 2024.

BRASIL. Lei nº 11.892, de 29 de dezembro de 2008. Institui a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, cria os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, e dá outras providências. **Diário Oficial da União**, Brasília, DF, seção 145, n. 253, p. 1-3, 30 dez. 2008.

BRASIL. **Lei nº 7.498, de 25 de junho de 1986.** Dispõe sobre a regulamentação do exercício da enfermagem, e dá outras providências. Brasília, DF: Presidência da República, [1986]. Disponível em https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/17498.htm. Acesso em: 26 jul. 2024.

BRASIL. **Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990.** Dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências. Brasília, DF: Presidência da República, [1990]. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/18080.htm. Acesso em: 26 jul. 2024.

BRASIL. **Decreto Nº 7.234 de 19 de julho de 2010.** Dispõe sobre o Programa Nacional de Assistência Estudantil - PNAES.

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Ações Programáticas Estratégicas. **Orientações básicas de atenção integral à saúde de adolescentes nas escolas e unidades básicas de saúde.** Brasília, DF: Editora do Ministério da Saúde, 2013. Disponível em: https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/orientacao_basica_saude_adolescente.pdf. Acesso em: 26 jul. 2024.

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. **Programa Saúde na Escola.** Brasília, DF: Ministério da Saúde, 2017. Disponível em <https://www.scielo.br/j/reeusp/a/mLtvhfT5dbMgtLHpt5snMKw/>. Acesso em: 26 jul. 2023.

BRITO, Nilza Martins Ravazoli; VELOZO, Bruna Cristina; PAVANELLI, Rosana Jimenes. **Manual de orientação:** anotação de enfermagem. Botucatu: Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu, 2016. Disponível em: <https://solusite.com.br/site-hc/wp-content/uploads/2022/01/Manual-de-orientacao-Anotacao-de-enfermagem.pdf>. Acesso em: 26 jul. 2024.

CAPES. Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Diretoria de Avaliação. **Documento de área:** área 46: ensino. [Brasília, DF]: MEC, 2019. Disponível em: <https://www.gov.br/capes/pt-br/centrais-de-conteudo/ENSINO.pdf>. Acesso em: 26 jul. 2024.

CASTRO, Cloves Alexandre de; PLÁCIDO, Reginaldo Leandro; SCHENKEL, Cladecir Alberto. História socioespacial do trabalho no Brasil, educação profissional tecnológica e a questão regional. **Labor**, Fortaleza, v. 1, n. 24, p. 331-355, 2020. DOI: 10.29148/labor.v1i24.59992. Disponível em: <http://www.periodicos.ufc.br/labor/article/view/44200>. Acesso em: 26 jul. 2024.

CIAVATTA, Maria. O ensino integrado, a politecnia e a educação omnilateral. Por que lutamos? **Trabalho & Educação**, Belo Horizonte, v. 23, n. 1, p. 187-205, 2014. Disponível em: <https://periodicos.ufmg.br/index.php/trabedu/article/view/9303>. Acesso em: 26 jul. 2024.

COFEN. Conselho Federal de Enfermagem. **Resolução Cofen nº 514/2016**. Aprova o Guia de Recomendações para os registros de enfermagem no prontuário do paciente, com a finalidade de nortear os profissionais de Enfermagem. Brasília, DF: Cofen, 2016. Disponível em: <https://www.cofen.gov.br/wp-content/uploads/2016/06/RESOLUCAO-COFEN-514-2016.pdf>. Acesso em: 26 jan. 2024.

COFEN. Conselho Federal de Enfermagem. **Resolução Cofen nº 358/2009**. Dispõe sobre a Sistematização da Assistência de Enfermagem e a implementação do Processo de Enfermagem em ambientes, públicos ou privados, em que ocorre o cuidado profissional de Enfermagem, e dá outras providências. Brasília, DF: Cofen, 2009. Disponível em: <https://www.cofen.gov.br/wp-content/uploads/2009/10/RESOLUCAO-358-2009.pdf>. Acesso em: 26 jul. 2024.

COFEN. Conselho Federal de Enfermagem. **Resolução Cofen nº 429/2012**. Dispõe sobre o registro das ações profissionais no prontuário do paciente, e em outros documentos próprios da enfermagem, independente do meio de suporte – tradicional ou eletrônico. Brasília, DF: Cofen, 2012. Disponível em: <https://www.cofen.gov.br/resoluo-cofen-n-4292012/>. Acesso em: 26 jul. 2024.

COFEN. Conselho Federal de Enfermagem. **Resolução Cofen nº 564/2017**. Aprova o novo Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem. Brasília, DF: Cofen, 2017. Disponível em: <https://www.cofen.gov.br/wp-content/uploads/2017/12/RESOLU%C3%87%C3%83O-COFEN-N%C2%BA-564-2017.pdf>. Acesso em: 26 jul. 2024.

DIAS, Thais Gonçalves *et al.* Sistematização da assistência e processo de enfermagem na saúde da família: percepção de enfermeiros. **Journal of Nursing and Health**, [s. l.], v. 12, n. 1, e2212120794, 2022. DOI: 10.15210/jonah.v12i1.2246. Disponível em: <https://periodicos.ufpel.edu.br/index.php/enfermagem/article/view/20794>. Acesso em: 26 jul. 2024.

FEITOSA, Maria da Cruz Dias. **Percepção dos profissionais de Enfermagem acerca da implementação da sistematização da assistência de enfermagem (SAE) no âmbito do Instituto Federal do Piauí (IFPI)**. 2023. Dissertação (Mestrado em Educação Profissional e Tecnológica) – Instituto Federal do Piauí, Parnaíba, 2023. Disponível em: <http://bia.ifpi.edu.br:8080/jspui/handle/123456789/2411>. Acesso em: 26 jul. 2024.

FLICK, Uwe. **Introdução à pesquisa qualitativa**. Trad. Joice Elias Costa. 3. ed. Porto Alegre: Artmed, 2009.

FONSECA, João José Saraiva da. [Apostila de] **Metodologia da pesquisa científica**. [S. l.]: Uece, 2002. Disponível em: <http://www.ia.ufrj.br/ppgea/conteudo/conteudo-2012-1/1SF/Sandra/apostilaMetodologia.pdf>. Acesso em: 26 jul. 2024.

FRIGOTTO, Gaudêncio; CIAVATTA, Maria; RAMOS, Marise (org.). **Ensino médio integrado: concepções e contradições**. São Paulo: Cortez, 2005.

FRIGOTTO, Gaudêncio; CIAVATTA, Maria; RAMOS, Marise (org.). **Ensino médio integrado: concepção e contradições**. 3. ed. São Paulo: Cortez, 2012.

GIL, Antonio Carlos. **Como elaborar projetos de pesquisa**. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2002. GODOI, Jady Sobjak de Melo *et al.* O uso do prontuário eletrônico por enfermeiros em Unidades Básicas de Saúde brasileiras. **Journal of Health Informatics**, [s. l.], v. 4, n. 1, p. 3-9, 2012. Disponível em: <https://jhi.sbis.org.br/index.php/jhi-sbis/article/view/146>. Acesso em: 26 jul. 2024.

GODOY, Arlida Schmidt. Introdução à pesquisa qualitativa e suas possibilidades. **Revista de Administração de Empresas**, São Paulo, v. 35, n. 2, p. 57-63, mar./abr. 1995. DOI: 10.1590/S0034-75901995000200008. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/rae/a/wf9CgwXVjpLFVgpwNkCgnnC/>. Acesso em: 26 jul. 2024.

GRAU, Carme Ferré; AVELLO, Isabel M. Sancho. **Enfermagem**: fundamentos do processo de cuidar. São Paulo: DCL, 2003.

GRINSPUN, Mírian Paura Sabrosa Zippin (org.). **Educação tecnológica**: desafios e perspectivas. 2 ed. São Paulo: Cortez, 2001.

HERMIDA, Patrícia Madalena Vieira; ARAÚJO, Izilda Esmênia Muglia. Sistematização da assistência de enfermagem: subsídios para implantação. **Revista Brasileira de Enfermagem**, [s. l.], v. 59, n. 5, p. 675-679, set.-out. 2006. DOI: 10.1590/S0034-71672006000500015. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/reben/a/ZSFn7Yhx8XNG5Wtvs3G66zF>. Acesso em: 26 Mar.2024.

INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE (IFC). **Resolução nº 22/2022 – CONSUPER, de 14 de maio de 2022**. Dispõe sobre a Política de Atendimento ao Estudante do Instituto Federal Catarinense (IFC). Blumenau: IFC, 2022.

INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE (IFC). **Resolução nº 5/2019 – CONSUPER**. Dispõe sobre o Regimento Interno dos Serviços de Enfermagem no Instituto Federal Catarinense (IFC). Blumenau: IFC, 2022.

KAPLÚN, Gabriel. Material educativo: a experiência de aprendizado. **Comunicação & Educação**, São Paulo, n. 27, p. 46-60, 2003. DOI: 10.11606/issn.2316-9125.v0i27p46-60. Disponível em: <https://revistas.usp.br/comueduc/article/view/37491>. Acesso em: 26 jul. 2024.

KIRSCH, Gustavo Hanich *et al.* Promoção da saúde no espaço escolar. In: CONGRESSO INTERNACIONAL DA REDE UNIDA, 15., 2022, Vitória. **Anais [...]**. Vitória: Rede Unida, 2022. Disponível em: <http://conferencia2018.redeunida.org.br/ocs2/index.php/15CRU/15CRU/paper/view/14935>. Acesso em: 26 jul. 2024.

LIMA, Kálya Yasmine Nunes de; MOREIRA, Patricia Naiara de Oliveira; TOURINHO, Francis Solange Vieira; SANTOS, Viviane Euzébia Pereira. Assistência de enfermagem ao adolescente no âmbito escolar: uma pesquisa documental. **Revista Enfermagem UERJ**, [S. l.], v. 22, n. 2, p. 226–232, 2014. Disponível em: <https://www.epublicacoes.uerj.br/enfermagemuerj/article/view/3768>. Acesso em: 14 abr. 2024.

LIMA, Kenedy Everaldo Rufino; TORTATO, Cíntia de Souza Batista. A omnilateralidade nos projetos político-pedagógicos do Instituto Federal do Paraná. **Revista Brasileira da Educação Profissional e Tecnológica**, [s. l.], v. 1, n. 24, e15131, 2024. DOI:

10.15628/rbept.2024.15131. Disponível em:
<https://www2.ifrn.edu.br/ojs/index.php/RBEPT/article/view/15131>. Acesso em: 26 jul. 2024.

MACIEL, Ethel Leonor Noia *et al.* Projeto Aprendendo Saúde na Escola: a experiência de repercussões positivas na qualidade de vida e determinantes da saúde de membros de uma comunidade escolar em Vitória, Espírito Santo. **Ciência & Saúde Coletiva**, v. 15, n. 2, p. 389-396, 2010. DOI: 10.1590/S1413-81232010000200014. Disponível em:
<https://www.scielo.br/j/csc/a/kFrFbXyWz8QsL9j3Sr5THzS>. Acesso em: 26 jul. 2024.

MOURA, Dante Henrique. Educação básica e educação profissional e tecnológica: dualidade histórica e perspectivas de integração. **Holos**, [s. l.], v. 2, p. 4-30, 2007. DOI: 10.15628/holos.2007.11. Disponível em:
<https://www2.ifrn.edu.br/ojs/index.php/HOLOS/article/view/11>. Acesso em: 26 jul. 2024.

MUNIZ, Emanuel Avelar *et al.* Políticas de saúde e educação para a juventude no Brasil: intersectorialidade e atuação do enfermeiro. **Sanare**, Sobral, v. 20, n. 1, p. 73-80, 2021. DOI: 10.36925/sanare.v20i1.1552. Disponível em:
<https://sanare.emnuvens.com.br/sanare/article/view/1552>. Acesso em: 26 jul. 2024.

NITSCHKE, Alessandra; PLÁCIDO, Reginaldo Leandro; PITT, Henrique. O núcleo docente básico na construção curricular do ensino médio integrado em um instituto federal: avanços e limites. **Reflexão e Ação**, Santa Cruz do Sul, v. 29, n. 3, p. 41-56, 2021. DOI: 10.17058/rea.v29i3.16362. Disponível em:
<https://online.unisc.br/seer/index.php/reflex/article/view/16362>. Acesso em: 26 jul. 2024.

OLIVEIRA, Valéria Conceição de; CADETTE, Matilde Meire Miranda. Anotações do enfermeiro no acompanhamento do crescimento e desenvolvimento infantil. **Acta Paulista de Enfermagem**, [s. l.], v. 22, n. 3, p. 301-306, 2009. DOI: 10.1590/S0103-21002009000300010. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/ape/v22n3/a10v22n3.pdf>. Acesso em: 26 jul. 2024.

PACHECO, Eliezer Moreira. **Fundamentos político-pedagógicos dos institutos federais**: diretrizes para uma educação profissional e tecnológica transformadora. Natal: Ed. IFRN, 2015. Disponível em:
<https://memoria.ifrn.edu.br/bitstream/handle/1044/1018/Fundamentos%20Poli%CC%81tico-Pedago%CC%81gicos%20dos%20Institutos%20Federais%20-%20Ebook.pdf>. Acesso em: 26 jul. 2024.

PACHECO, Eliezer Moreira. **Os institutos federais**: uma revolução na educação profissional e tecnológica. Natal: Ed. IFRN, 2010. Disponível em:
<https://memoria.ifrn.edu.br/bitstream/handle/1044/1013/Os%20institutos%20federais%20-%20Ebook.pdf>. Acesso em: 26 jul. 2024.

PADILHA, Maria Itayra Coelho de Souza; MANCIA, Joel Rolim. Florence Nightingale e as irmãs de caridade: revisitando a história. **Revista brasileira de enfermagem**, [s. l.], v. 58, p. 723-726, 2005. DOI: 10.1590/S0034-71672005000600018. Disponível em:
<https://www.scielo.br/j/reben/a/ssxh6MfGXgHZxVDpBYTjX9v>. Acesso em: 26 jul. 2024.

PADOIN, Egred; AMORIM, Mário Lopes. O percurso da educação profissional no Brasil e a criação dos institutos federais nesse contexto. In: SEMINÁRIO NACIONAL DE HISTÓRIA DA CIÊNCIA E DA TECNOLOGIA, 15., 2016, Florianópolis. **Anais eletrônicos** [...].

Florianópolis: UFSC, 2016. p. 1-14, 2016. Disponível em: https://www.15snhct.sbhct.org.br/resources/anais/12/1473984255_ARQUIVO_ARTIGOSNHCTENVIADO.pdf. Acesso em: 26 jul. 2024.

PIMPÃO, Fernanda Demutti *et al.* Percepção da equipe de enfermagem sobre seus registros: buscando a sistematização da assistência de enfermagem. **Revista Enfermagem Uerj**, Rio de Janeiro, v. 18, n. 3, p. 405-410, 2010. Disponível em: https://docs.bvsalud.org/biblioref/2022/10/583653/percepcao-da-equipe-de-enfermagem-sobre-seus-registros-buscando_6qTWpiS.pdf. Acesso em: 26 jul. 2024.

PIRES, Laurena Moreira *et al.* A enfermagem no contexto da saúde do escolar: revisão integrativa da literatura. **Revista Enfermagem Uerj**, Rio de Janeiro, v. 20, n. 5, p. 668-675, 2013. Disponível em: <https://www.e-publicacoes.uerj.br/enfermagemuerj/article/view/5968>. Acesso em: 26 jul. 2024.

RAMOS, Marise. **Concepção do ensino médio integrado**. Texto apresentado em seminário promovido pela Secretaria de Educação do Estado do Pará nos dias, v. 8, 2008.

RAMOS, Marise Nogueira. Ensino médio integrado: lutas históricas e resistências em tempos de regressão. **Educação Profissional e Tecnológica em Revista**, [s. l.], v. 1, n. 1, p. 27-49, 2017. DOI: <https://doi.org/10.36524/ept.v1i1.356>. Disponível em: <https://ojs.ifes.edu.br/index.php/ept/article/view/356>. Acesso em: 26 jul. 2024.

RASCHE, Alexandra Schmitt; SANTOS, Maria da Soledade Simeão dos. Enfermagem escolar e sua especialização: uma nova ou antiga atividade. **Revista Brasileira de Enfermagem**, Brasília, DF, v. 66, n. 4, p. 607-610, 2013. DOI: 10.1590/S0034-71672013000400022. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/reben/a/3fJ8zrSXSfJP77s6yw6yyS>. Acesso em: 26 jul. 2024.

SAVIANI, Dermeval. Trabalho e educação: fundamentos ontológicos e históricos. **Revista Brasileira de Educação**, [s. l.], v. 12, n. 34, jan./abr. 2007. DOI: 10.1590/S1413-24782007000100012. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/rbedu/a/wBnPGNkvstzMTLYkmXdrkWP>. Acesso em: 26 jul. 2024.

SCHENKEL, Cladecir Alberto. **Gestão ambiental: perfil profissional e formação em cursos superiores de tecnologia e de bacharelado**. 2012. Tese (Doutorado em Ciências Humanas) – Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, 2012. DOI: 10.14393/ufu.te.2012.13. Disponível em: <https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/13630>. Acesso em: 26 jul. 2024.

SILVA, Jaqueline Miranda Barros *et al.* Perfil sócio demográfico e ocupacional dos profissionais de Enfermagem do Hemocentro Coordenador de Palmas. **Singular**, [s. l.], v. 1, n. 1, 2020. DOI: 10.33911/singularsb.v1i1.67. Disponível em: <https://ulbra-to.br/singular/index.php/SingularSB/article/view/67/53>. Acesso em: 26 jul. 2024.

SILVA, Suzana Lins da *et al.* Sistematização da assistência de enfermagem ao adolescente: consulta de enfermagem. **Revista de Enfermagem UFPE On Line**, [Recife], v. 1, n. 1, p. 1-11, 2007. DOI: 10.5205/reuol.1374-9050-1-LE.0101200701. Disponível em: <https://periodicos.ufpe.br/revistas/index.php/revistaenfermagem/article/view/5211/4471>. Acesso em: 26 jul. 2024.

SOARES, Mirelle Inácio *et al.* Sistematização da assistência de enfermagem: facilidades e desafios do enfermeiro na gerência da assistência. **Escola Anna Nery**, [s. l.], v. 19, p. 47-53,

2015. DOI: 10.5935/1414-8145.20150007. Disponível em:
<https://www.scielo.br/j/ean/a/ghYPrPYCdG68TBW5yxrGqbq>. Acesso em: 26 jul.

SUZANNE, C; SMELTZER, B. G; BARE.BRUNNER & SUDDARTH. Tratado de Enfermagem Médico-Cirúrgica. 10ª edição, v.1, Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2005, p 5 – 679. VERBI Software. **MAXQDA Analytics Pro 2024** [*computer software*]. Berlin, Germany: VERBI Software, 2024. Disponível em: <https://www.maxqda.com>. Acesso em: 26 jul. 2024.

VIEIRA, Alboni Marisa Dudeque Pianovski; SOUZA JUNIOR, Antonio. A Educação profissional no Brasil. **Interacções**, Santarém. v. 12, n. 40, p. 152-169, 2016. DOI: <https://doi.org/10.25755/int.10691>. Disponível em:
<https://revistas.rcaap.pt/interaccoes/article/view/10691>. Acesso em: 26 jul. 2024.

APÊNDICE A – ROTEIRO ENTREVISTA COM OS ENFERMEIROS

Instrumento de coleta de dados pesquisa qualitativa - Roteiro Entrevista.

1 - Caracterização dos participantes de pesquisa.

- 1.1 Nome:
- 1.2 Idade:
- 1.3 Função/cargo:
- 1.4 Quanto tempo de atuação na enfermagem:
- 1.5 Quanto tempo de atuação no IFC? Qual setor?
- 1.6 Quais outras instituições atuou anterior ao IFC no serviço de enfermagem?
- 1.7 Você visualiza muitas diferenças na atuação do profissional de enfermagem no IFC quando comparado com os outros locais que atuou? Quais diferenças?
- 1.9 Qual a seu nível de formação:

2- Experiência como profissional da enfermagem na Educação Profissional e Tecnológica no campus de atuação.

- 2.1 Na Educação Profissional e Tecnológica, você sempre atuou no IFC ou atuou em outras instituições? Quais? Quais as principais diferenças entre os locais de atuação?
- 2.2 Como você acha que deve ser a atuação da enfermagem na escola?
- 2.3 Diante da sua realidade no campus, você encontra espaço ou apoio para desenvolver as atividades educativas de prevenção e promoção à saúde? Como isso poderia melhorar, quais setores deveriam/poderiam apoiar?
- 2.4 Como é seu ambiente de trabalho, você possui um espaço adequado para sua atividade? O que poderia ser melhorado? Quais os materiais lhe faltam?
- 2.5 Você se sente motivado para inovar e buscar recursos ou ações em seu campus? Fale mais sobre isso.
- 2.6 O que poderia se apresentar como motivador para suas ações de enfermagem? Em especial as agendas educativas?
- 2.7 Você consideraria benéfico uma aproximação com os demais profissionais enfermeiros para troca de experiências e programar atividades?
- 2.8 Você sente falta de uma identidade de grupo, ou seja, aproximação e contato com os demais profissionais de enfermagem dos outros câmpus do IFC? Por qual motivo?

3 - Formas de anotações/registros das ações e atendimentos de enfermagem no seu Campus.

- 3.1 O que você entende por registros/anotações de enfermagem?
- 3.2 Você considera importante os registros/anotações dos atendimentos e ações de enfermagem? Por que?
- 3.3 Você considera importante que a forma de registros dos atendimentos e ações de enfermagem seja padronizado entre os campus, como por exemplo uma tabela ou um sistema on-line?
- 3.4 Você considera importante o IFC possuir um histórico dos registros de ações de enfermagem dos discentes e egressos do IFC? Porque?
- 3.5 De que forma você realiza os registros/anotações dos atendimentos e ações de enfermagem no seu Campus?
- 3.6 Você realiza a Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE) no seu Campus? Como são registradas as etapas do SAE?
- 3.7 Caso um sistema on-line de registros dos atendimentos e ações de enfermagem estivesse disponível, você teria condições de preenchê-lo após todas as suas ações? Porquê?

3.8 Quais são as informações que você julga indispensáveis conter em um registro de atendimento de ações de enfermagem de acordo com as suas ações desempenhadas no campus.

3.9 Quais os aplicativos ou funcionalidades seriam interessantes conter em um Sistema de Registro de Assistência de Enfermagem na qual facilitaria ou apoiaria suas atividades no IFC. Você considera que um sistema de on-line registros de atendimentos e ações de enfermagem contribuem para a formação integral? Explique

4 - Ações de educação em saúde realizadas no seu campus.

4.1 O que você entende por ações de educação/prevenção em saúde?

4.2 Você considera importante realizar ações de educação e prevenção em saúde no contexto escolar?

4.3 Quais ações de educação e prevenção em saúde são desenvolvidas no seu Campus?

4.4 Você considera importante ter um cronograma de ações de saúde unificado entre os Campus?

4.5 Quanto à construção de uma agenda e materiais de atividades educativas na promoção a saúde, você acredita que seria possível aplicar no campus em que atua?

4.6 Tem desejo que uma agenda de atividades educativas de promoção à saúde, programadas em conjunto, seja colocada em prática em todos os câmpus do IFC?

5 - Educação Profissional e Tecnológica.

5.1 O que você entende por Educação Profissional e Tecnológica?

5.2 De que forma você acredita que a sua profissão contribui na EPT?

5.3 O que você entende ou como você poderia definir a formação omnilateral?

5.4 Qual sua contribuição para a formação omnilateral dos estudantes do seu campus?

5.5 Educação integral, como você poderia definir?

5.6 O que você entende por desenvolvimento integral? Qual o papel do profissional de enfermagem nesse ponto?

5.7 Você se compreende um educador em sua função de profissional de enfermagem?

5.8 Você conhece a missão da EPT dos IFs?

APÊNDICE B – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO –

Profissionais da Educação

Prezado(a) senhor(a), você está sendo convidado(a) a participar do projeto de pesquisa intitulado: “Percepção dos Profissionais de Enfermagem sobre o Registros da Assistência de Enfermagem e sua atuação profissional no Instituto Federal Catarinense.” desenvolvida por Juliana Amadei, discente do Programa de Mestrado Profissional em Educação Profissional e Tecnológica em Rede Nacional - Polo Blumenau (ProfEPT). A pesquisa está inserida na linha de pesquisa “Organizações e Memórias de Espaços Pedagógicos na EPT”, no Macroprojeto “4 - História e Memória no contexto da EPT”, com orientação da Professora Dr. Denise Fernandes e autorizada pelo Comitê de Ética em Pesquisa do IFC (CEPSH).

O objetivo da pesquisa é compreender a percepção dos profissionais de enfermagem sobre o sistema de registro da Assistência de Enfermagem no Instituto Federal Catarinense visando a construção de um prontuário unificado e sua atuação educativa. Também pretende-se elaborar um produto educacional em forma de um prontuário unificado para uso da enfermagem e um calendário de ações educativas, fortalecendo assim o registro da assistência de enfermagem e atuação em ações educativas na Instituição.

O método de obtenção de dados previsto para esta pesquisa é através de entrevista com os profissionais de enfermagem que prestam assistência de enfermagem. Sua participação ocorrerá de forma voluntária e consistirá na participação de uma entrevista por meio de plataforma virtual em um primeiro momento e a posteriori, um questionário, para a validação do produto educacional.

Todas as informações prestadas serão confidenciais, utilizadas apenas em publicações e/ou eventos científicos, mas sempre sendo garantido o sigilo da sua identificação e participação. Caso alguma pergunta lhe ofereça constrangimento, o (a) Sr.(a) tem a escolha de não responder ou de interromper a entrevista sem nenhum prejuízo.

Sua participação nesta pesquisa pode trazer alguns riscos, tais como: A coletas de dados provocarem algum tipo de desconforto (de ordem subjetiva), entre os quais podemos mencionar: invasão de privacidade; responder a questões sensíveis, tais como atos ilegais; revitimizar e perder o autocontrole e a integridade ao revelar pensamentos e sentimentos nunca revelados; discriminação e estigmatização a partir do conteúdo revelado; divulgação de dados; tomar o tempo para responder as perguntas das entrevistas individuais semiestruturadas.

Nesses casos, as medidas/providências tomadas serão: a garantia do acesso aos resultados da produção de dados decorrentes da participação na pesquisa. Esta garantia ocorrerá por meio da disponibilização de forma impressa, digital e/ou adaptada das transcrições das entrevistas individuais/coletivas semi estruturadas ou grupos focais e do texto do relatório final. A minimização de desconfortos, garantindo local reservado e liberdade para não responder questões constrangedoras.

A pesquisadora estará preparada para a aplicação de técnicas de produção dos dados. Ficará atenta aos sinais de desconforto e garantirá a não violação e a integridade dos documentos (danos físicos, cópias, rasuras) caso sejam entregues pelos entrevistados. A pesquisadora assegurará a confidencialidade e a privacidade, a proteção da imagem e a não estigmatização, garantindo a não utilização das informações em prejuízo dos entrevistados, inclusive em termos de autoestima, de prestígio e/ou econômico/financeiro.

Destacam-se também os possíveis riscos característicos do ambiente virtual, meios eletrônicos, ou atividades não presenciais, em função das limitações das tecnologias utilizadas. Além disso, existem limitações dos pesquisadores para assegurar total confidencialidade e potencial risco de sua violação dos dados da pesquisa, portanto, serão tomadas todas as providências para a garantia da confidencialidade, os sujeitos da pesquisa que vierem a sofrer

qualquer tipo de dano previsto ou não no termo de consentimento e resultante de sua participação na pesquisa, seja indenizado pelo dano, nos termos da Lei. Ainda, caso o participante apresente gasto financeiro em sua participação no estudo, esse será ressarcido pelos pesquisadores.

A possibilidade de divulgação de voz e imagem do entrevistado, somente ocorrerá com o consentimento do mesmo, caso a divulgação seja importante para a pesquisa e haja interesse do participante na divulgação. Nesse caso, será lavrado um termo de autorização de uso de voz e imagem, solicitando a sua permissão. Não havendo seu consentimento, seu nome, dados pessoais e/ou o material que indique sua participação será mantido sob sigilo, você não será identificado (a) em nenhuma publicação que possa resultar.

Sua participação é extremamente importante, mas enfatizo que você tem plena autonomia para decidir se quer ou não participar, bem como desistir da participação nesta pesquisa no momento em que desejar, sem necessidade de qualquer explicação e sem nenhuma forma de penalização. Também não sofrerá nenhum prejuízo caso decida não participar, ou desistir da mesma. No entanto, gostaria muito de poder contar com a sua participação.

Os benefícios dos resultados da pesquisa serão diretos e indiretos. Diretos ao compartilhar e compreender as percepções e anseios dos profissionais de enfermagem no IFC, possibilitar uma melhor organização dos registros da enfermagem de maneira unificada, sugerir e organizar um calendário de ações de prevenção e promoção à saúde. Indiretos ao possibilitar ações educativas integradas entre os campus de prevenção e promoção à saúde, possibilitar os registros de forma unificada criando um histórico de ações da enfermagem, possibilitar a segurança para os profissionais e da Instituição com o registro de todos os atendimentos e necessidades dos discentes atendidos. Possibilitar dados acadêmicos de referência para as discussões acerca das ações de enfermagem em ambiente escolar.

Esta pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos (CEPSH) do Instituto Federal Catarinense (IFC). O Comitê tem por objetivo assegurar os interesses dos sujeitos participantes de pesquisas científicas, em sua integridade e dignidade. Caso persistam dúvidas, sugestões e/ou denúncias após os esclarecimentos dados pela equipe científica desta pesquisa, o CEPSH do IFC está disponível para atendê-lo, localizado junto ao IFC Campus Camboriú, pelo telefone (47) 2104-0882 ou pelo endereço eletrônico cepsh@ifc.edu.br. Em caso de dúvidas sobre a pesquisa ou para relatar algum problema, a qualquer momento que considerar necessário, você poderá contatar a pesquisadora Juliana Amadei pelo Telefone: (47) 997524711 e e-mail: juliana.amadei@ifc.edu.br.

Ao final do trabalho, será garantido o acesso aos resultados da produção de dados decorrentes da participação nesta pesquisa. Esta garantia ocorrerá por meio da disponibilização de forma impressa, digital e/ou adaptada do texto final da dissertação, e caso solicitado, a tabulação das entrevistas e questionários.

Finalizamos aqui o TCLE, caso você considere suficiente os esclarecimentos redigidos sobre as finalidades e atividades da presente pesquisa, caso concorde com a participação nesta pesquisa, solicitamos o preenchimento de seus dados e sua assinatura e em seguida, uma via deste termo assinada por você e pelas pesquisadoras será enviada para você por e-mail.

No momento do questionário on-line, caso aceite participar da pesquisa, será necessário marcar a opção “aceito”. Ao informar que você está de acordo e deseja participar, este documento será considerado assinado e consentido por você. Por fim, quando tiver respondido todas as questões, deverá clicar em enviar as respostas. Tanto este TCLE para a entrevista, quanto o registro de consentimento do questionário ficarão disponíveis para o/a participante solicitar o acesso sempre que necessário, podendo imprimir caso considerar necessário, mas salientamos que é importante que guarde as assinatura e em seguida, uma via deste termo assinada por você e pelas pesquisadoras será enviada para você por e-mail.

Desde já agradecemos sua participação!

Blumenau, Novembro de 2023.

Nome completo do participante:

Telefone:

E-mail:

Assinatura: (podendo essa ser digital)

Juliana Amadei

Rua Heinz Krelling, 156

89245000, Araquari

Telefone: (47) 997524711

E-mail: juliana.amadei@ifc.edu.br

Assinatura:

APÊNDICE C – PRODUTO EDUCACIONAL

Instituto Federal Catarinense (IFC)

Setor - Saúde/Ambulatório

Produto Educacional I

Sistematização da enfermagem no IFC

Prezados pais e responsáveis por estudantes ingressantes nos cursos Técnicos Integrados do IFC.

Este formulário faz parte da sistematização do serviço de enfermagem no IFC e será utilizado para subsidiar os serviços de Atenção à Saúde. Nele devem ser adicionadas informações sobre o estudante.

Instrumento de consulta de enfermagem com adolescente	
Formulário Anamnese (realizar no ingresso do estudante, com auxílio dos pais ou sob consulta individual)	
1 - Identificação do estudante	
Nome completo:	
Nome social:	
Data de Nascimento:	Idade:
curso:	turma:
Email do estudante:	
Email do responsável:	
Edereço: Rua:	Nº
Bairro:	Cidade/UF:
Telefone residencial:	Celular:
Nome da Mãe:	Profissão:
Telefone - trabalho (mãe):	Celular

Celular:	
Nome do pai:	Celular:
Telefone - trabalho (pai):	Celular
Outro responsável	Parentesco:
Telefone residencial:	Celular:
Possui algum convênio médico? Sim () Não () Qual?	
Qual tipo sanguíneo? () A - () B - () O - () AB - () A+ () B+ () O + () AB +	
2 - História Pregressa	
Doenças crônicas: (exemplo diabetes, hipertensão, etc) () Sim () Não Qual?	
Possui alergias: () Sim () Não Qual?	
Cirurgias: () Sim () Não Qual?	
Realiza algum acompanhamento médico? () Sim () Não Qual?	
Uso de medicamentos contínuo? () Sim () Não Qual?	
*O receituário dos medicamentos citados deve ser apresentado no setor de saúde e atualizados quando houver troca de medicação.	
3 - Informações complementares	
Renda do adolescente:	
Vínculo familiar: Quantos membros são na família?	
Grau de parentesco? (ex: pai, mãe, irmão etc)	
Moradia do estudante:() reside com a família () reside em moradia estudantil	
() Reside com outro responsável. Qual?	

Realiza atividade física regularmente? () Sim () Não Qual/Quais?
Alimentação: Quantas refeições o estudante faz durante o dia? () 1; () 2; () 3; () mais do que 3; () Não sei.
O estudante possui alguma restrição alimentar? () Sim () Não Qual?
Sono e repouso: Em média, quantas horas o estudante dorme? () menos que 6 horas; () 6 a 8 horas; () mais do que 8 horas
Como é avaliado o sono do estudante? () Dorme bem, possui um sono contínuo e não tem nenhuma dificuldade. () Não dorme bem, acorda durante o sono e possui dificuldade para iniciar o sono. Motivos que dificultam o sono: _____
O estudante faz uso de algum medicamento para dormir? () Sim () Não Qual?
Crença/espiritualidade:
Você sente-se feliz com sua vida:
Planos para o futuro:
4 - Fatores de Risco
Assinale abaixo se há algum fator de risco relacionado à saúde do adolescente: () Fumo; () Uso de álcool; () Estresse; () Obesidade; () Desnutrição; () Sedentarismo; () Uso de drogas. Quais?
Algum membro da família faz uso de álcool e/ou outras drogas?
5 - Acompanhamentos
O estudante faz algum acompanhamento especializado? (ex: Ansiedade, Depressão, Transtorno de Déficit de Atenção com Hiperatividade(TDAH, entre outros). () Sim () Não Em caso afirmativo. Qual?
A caderneta de vacinação do estudante está atualizada? () Sim () Não
Em relação aos exames periódicos (ex: sangue, urina, etc realizados pelo adolescente): () realiza exames periódicos anualmente. () não realiza exames periódicos anualmente.

Este formulário será utilizado para subsidiar os serviços de Atenção à Saúde, Atenção Psicológica e Serviço Social, havendo necessidade de utilização destas informações por outros profissionais da equipe escolar:

() **Ciente** que o serviço de Atenção à saúde repassa informações fornecidas neste formulário de Anamnese para outros profissionais da equipe escolar (técnicos administrativos e docentes) se verificado a necessidade e/ou conforme legislação.

Declaro que as informações aqui fornecidas são a mais pura expressão da verdade. Desde já autorizo a verificação dos dados, sabendo que a omissão ou falsidade de informações resultará nas penalidades cabíveis conforme a lei 2848/40.

_____, _____ de _____, de _____

Assinatura do estudante

Assinatura do responsável

Assinatura do Serviço de Atenção à Saúde

Instituto Federal Catarinense - IFC

Setor - Saúde/Ambulatório

Profissionais: Enfermeiros

Sistematização da enfermagem no IFC

Instrumento de consulta de enfermagem com adolescente	
Consulta de enfermagem subsequente	
Data:	Hora:
Motivo da consulta/queixa principal:	
Exame físico	

Pressão arterial:	Pulso:	Saturação:
Temperatura:		
Medidas antropométricas: Peso:	Estatuta:	IMC:
Classificação do IMC: *Sugestão:utilizar a calculadora de IMC tua saúde disponível em www.tuasaude.com › calculadora › imc		
Alterações na pele (feridas, lesões,manchas, acnes):		
Avaliação cavidade oral (data da última avaliação odontológica):		
Queixas respiratórias:		
Consumo alimentar/hidratação:		
Queixas auditivas/oculares:		
Eliminações vesicais/intestinais:		
História menstrual - DUM:		
Atividade sexual/historia sexual:		
Contracepção:		
Identidade de gênero (qual gênero se identifica: homem, mulher, transgênero,intersexual...): Orientação sexual (atração, desejo,afetividade, prática sexuais - homoafetivo, bifaetivo,heteroafetivo,assexual...):		
Sexualidade (corrimento,verrugas,feridas outros):		
Avaliação de exames: () com alterações () sem alterações		
Aspectos gerais:		
Diagnóstico de enfermagem:		

Instituto Federal Catarinense (IFC)

Setor: Ambulatório

Profissionais: Enfermeiros e técnicos de enfermagem

Ficha de Acolhimento de Enfermagem

1 - Identificação

Nome _____

Data _____ Hora _____

Idade _____ Data de nascimento _____

Curso _____ Turma _____

2 Queixa

principal _____

7

3 - Sinais Vitais: Pressão arterial _____ mmhg Pulso _____ Bpm

Saturação _____ Temperatura _____

4 - Procedimentos: () curativo () Administração de medicamentos () HGT

Evolução de

enfermagem _____

Professional:carimbo e assinatura

Produto Educacional II
Cronograma de ações de educação e prevenção em saúde

Instituto Federal Catarinense - IFC

Setor: Ambulatório - SISAE

Profissionais: Enfermeiros, técnicos de enfermagem e equipe multidisciplinar:

Produto Educacional II
Cronograma de ações de educação e prevenção em saúde

O Serviço de Atenção à Saúde na escola contribui para formação integral dos estudantes por meio das ações de promoção, prevenção de doenças e agravos à saúde, visando um enfrentamento das vulnerabilidades que comprometem ou podem vir a comprometer o desenvolvimento pleno de crianças, adolescentes e jovens no cotidiano escolar. Diante disso, elaborei um cronograma de ações de promoção e prevenção em Saúde conforme informações que vocês trouxeram nas entrevistas para suas considerações e apontamentos.

Cronograma de ações em educação e promoção/prevenção em Saúde.

Janeiro - Realizar Anamnese (histórico de saúde) dos estudantes adolescentes ingressantes no ensino médio integrado conforme informações do prontuário unificado.

Fevereiro - Avaliação do Crescimento e Desenvolvimento: Avaliar peso, altura, IMC e registrar informações no prontuário unificado.

Março - Prevenção da gravidez na adolescência e métodos contraceptivos.

Abril - Imunização: Planejar campanhas de vacinação juntamente com a UBS para atualização de caderneta de vacinação e ações específicas do campus.

Mai - Saúde Bucal e ações específicas do campus.

Junho Branco - Mês de Conscientização e Prevenção ao uso de drogas e ações específicas do Campus.

Setembro - Campanha Setembro Amarelo - Saúde mental.

Outubro - Campanha Outubro Rosa - Prevenção do câncer de mama e de colo de útero.

Novembro - Campanha Novembro Azul - Saúde do homem

Dezembro - Campanha Dezembro vermelho - Prevenção das DSTs/AIDS, Saúde Sexual

Sugestões de consulta de material em sites bibliográficos e ações.

Jan/ Fev: Avaliação do Crescimento e Desenvolvimento: Avaliar peso, altura, IMC e registrar informações no prontuário unificado.

Planejar atividades na semana de integração em parceria com docentes de educação física.

*Sugestão:utilizar a calculadora de IMC tua saúde disponível em [www.tuasaude.com › calculadora › imc](http://www.tuasaude.com/calculadora-imc)

Mar - Prevenção da gravidez na adolescência e métodos contraceptivos.

Ações - Produção de matéria para site institucional, instagram do Campus, email para estudantes.

Palestras, oficinas, rodas de conversa, dinâmica, peça teatral sobre o tema em parceria com a equipe multidisciplinar, docentes e/ou secretaria de saúde do município.

Abril - Imunização

Planejar campanhas de vacinação juntamente com a UBS para atualização de caderneta de vacinação do adolescente e ações específicas do campus.

Divulgar a ação em parceria com a Cecom do campus pelos meios de comunicação do IFC.

Enviar termo de autorização para os pais e responsáveis assinarem explicando a ação e especificando as vacinas que serão aplicadas no discente.

Maio - Saúde Bucal

Ações - Planejar e realizar atividades em parceria com a secretaria de saúde como oficinas, palestra, roda de conversa, entre outras.

Campanha setembro Amarelo

Ações - Produção de matéria para site institucional, instagram do Campus, email para estudantes e servidores.

Palestra e/ou oficinas/roda de conversa sobre o tema em parceria com serviço de psicologia do Campus e secretaria de saúde.

Campanhas nacionais: [setembroamarelo.org.br › o-movimento](http://setembroamarelo.org.br)

Campanha Outubro Rosa:

Ações - Produção de matéria para site institucional, instagram do Campus, email para estudantes e servidores.

Decoração alusiva ao setor e /ou Campus sobre a campanha.

Palestra e/ou oficinas/roda de conversa sobre o tema.

Caminhada Rosa em parceria com a rede feminina de combate ao câncer, secretaria municipal de saúde e demais entidades parceiras.

Decoração alusiva ao setor e /ou Campus sobre a campanha.

Campanhas nacionais: Site www.gov.br › assuntos › campanhas

Campanha novembro azul.

Ações: Produção de material informativo para site institucional, instagram do Campus, email para estudantes e servidores.

Palestra e/ou oficinas/roda de conversa sobre o tema.

Ação dia da saúde (barraca ou no ambulatório) em parceria com secretaria de saúde com verificação de pressão arterial, HGT e orientações sobre saúde do homem.

Decoração alusiva ao setor e /ou Campus sobre a campanha.

Campanhas nacionais: Site www.gov.br › assuntos › campanhas

Campanha Dezembro vermelho

Ações: Produção de material informativo para site institucional, instagram do Campus, email para estudantes e servidores.

Campanha de testes rápidos em parceria com a secretaria de saúde com orientações sobre IST e HIV/AIDS.

Campanhas nacionais: bvsms.saude.gov.br › dezembro-vermelho

Quadro 1. Registros de ações de educação em saúde

Data	Hora	Ação	Nº Participantes

ANEXO I do Produto Educacional II

DIAGNÓSTICOS DE ENFERMAGEM

Diagnósticos e Intervenções de Enfermagem O quadro abaixo apresenta uma sugestão para os principais diagnósticos de enfermagem para o adolescente, tendo como referência a Classificação Internacional para a Prática de Enfermagem (CIPE), atrelada à Classificação Internacional de Atenção Primária (CIAP) e seguida das principais intervenções de enfermagem. Neste contexto é importante destacar que o Enfermeiro mediante a avaliação, embasado em conhecimento científico, possui autonomia para realização de outros diagnósticos e estabelecer um plano de cuidados, considerando sempre a singularidade do indivíduo, a integralidade do cuidado e recursos disponíveis na rede de saúde, para atender as necessidades dos usuários. Uma vez que os adolescentes procuram com menor frequência os serviços de saúde, os enfermeiros, dentre as possíveis intervenções de enfermagem, devem realizar intervenções referente a sexualidade, IST, testes rápidos para IST, métodos contraceptivos e saúde mental, bem como realizar atividades educativas no ambiente escolar. Avistamos que se trata de uma oportunidade de investigação de dados, elementos de grande importância para a saúde desta população.

QUADRO 2. Principais diagnósticos e intervenções de enfermagem, segundo a CIPE/CIAP.

Principais diagnóstico / resultados de enfermagem – CIPE	CIAP	Principais Intervenções de Enfermagem
- Abuso de álcool (ou Alcoolismo)	- P15 abuso crônico de álcool - P16 abuso agudo de álcool	- Encaminhar para profissional médico ou serviço de urgência, se necessário; - Aconselhar sobre uso de álcool;- Encaminhar para serviços de psicologia e social do campus - Apoiar condição psicológica; - Apoiar família; - Encaminhar para avaliação e atendimento psicológico em serviço de referência se necessário; - Avaliar resposta psicossocial ao plano de cuidado; - Facilitar acesso ao tratamento; - Monitorar abstinência; - Realizar atividades educativas de prevenção ao uso de álcool com a comunidade escolar.
- Abuso de drogas	- P19 abuso de drogas	- Encaminhar para o serviço de emergência, se necessário; - Encaminhar para os serviços de psicologia e serviço social do campus; -Encaminhar para atendimento psicológico em serviço de referência se necessário; - Encaminhar para terapia de grupo de apoio; - Facilitar acesso ao tratamento; - Orientar sobre consequências do abuso de drogas; - Orientar sobre manejo (controle) dos sintomas de abstinência; - Orientar sobre prevenção de recaída; - Apoiar

		processo familiar de enfrentamento; - Avaliar adesão ao regime terapêutico; - Promover (proporcionar, fornecer) apoio emocional; - Reforçar conquistas; Realizar atividades educativas de prevenção ao uso de álcool com a comunidade escolar.
- Abuso de tabaco (ou de fumo)	- P17 abuso de tabaco	- Aconselhar paciente; - Encaminhar para grupo de tabagismo mais próximo; - Encaminhar para avaliação e atendimento psicológico do campus; - Orientar sobre exposição ao tabagismo secundário (passivo); - Realizar atividades educativas de prevenção ao uso de tabaco na escola.
- Adesão ao regime de imunização	- A98 medicina preventiva/ manutenção de saúde	- Realizar reforço positivo para manter esquema vacinal em dia.
- Autoimagem negativa	- P23 sinais/sintomas relacionados ao comportamento do adolescente	- Apoiar imagem corporal, positiva; - Identificar percepções alteradas; - Obter dados sobre condição psicológica; - Solicitar apoio da equipe multiprofissional.
- Automutilação	- P23 Sinais/sintomas relacionados ao comportamento do adolescente - P29 sinais/sintomas psicológicos, outros - - P76 perturbações depressivas - S18 laceração/corte	- Avaliar ferimentos; - Encaminhar para consulta e avaliação médica; - Realizar curativo de acordo com a cobertura indicada; - Obter dados sobre condição psicológica; - Reforçar comportamento, positivo; - Promover estabelecimento de limites; - Orientar sobre controle de impulso; - Solicitar apoio da equipe multiprofissional ; - Notificar violência autoprovocada; - Monitorar adesão ao regime terapêutico; - Avaliar situação vacinal.
- Baixa autoestima	- P23 sinais/sintomas relacionados ao comportamento do adolescente - P76 perturbações depressivas - A18 preocupação com aparência	- Encorajar afirmações positivas; - Facilitar capacidade para comunicar sentimentos; - Obter dados sobre condição psicológica; - Encaminhar para avaliação e atendimento psicológico do Campus - Solicitar apoio da equipe multiprofissional .
- Capaz de executar o autocuidado com a pele com acne	- S06 erupção cutânea localizada - S07 erupção cutânea generalizada - S21 sinais/ sintomas da textura da pele	- Reforçar a capacidade positiva de executar os cuidados com a pele e com alimentação equilibrada.

- Cólica menstrual presente; - Descarga (ou fluxo) menstrual anormal; - Menorragia	- X02 dores menstruais - W06 menstruação excessiva - X07 Menstruação irregular/ frequente	- Orientar quanto a hábitos de higiene corporal e íntima; - Orientar a realizar registro dos sintomas e datas; - Orientar aplicação de calor local com média intensidade, em baixo ventre, enquanto tiver dor; - Orientar a realizar exercício físico moderado e aumentar ingesta hídrica; - Orientar sobre os riscos de automedicação; - Encaminhar para avaliação médica se necessário.
- Comportamento sexual eficaz; - Conhecimento sobre comportamento sexual eficaz	- P23 sinais/sint. comportamento adolescente - A98 medicina preventiva/ manutenção de saúde	- Reforçar orientações sobre métodos de prevenção das Infecções Sexualmente Transmissíveis; - Reforçar para prevenção de gravidez indesejada e de métodos contraceptivos e de barreira.
- Comportamento sexual problemático; - Potencial para risco de promiscuidade; - Relação sexual iniciado; - Relação sexual de risco; - Risco de gestação, não intencional; - Estado de gravidez não planejada	- Z04 problemas socioculturais - P23 sinais/sint. comportamento adolescente	- Orientar sobre métodos de prevenção das Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST); - Orientar para prevenção de gravidez indesejada e métodos contraceptivos e de barreira; - Encaminhar para consulta ginecológica; - Em casos de sinais e sintomas de IST seguir Protocolo de IST/HIV; - Realizar atividades educativas com a comunidade escolar.
- Desenvolvimento de adolescente, prejudicado; - Crescimento e desenvolvimento incompatíveis com a idade	- A18 preocupação com aparência; - T10 atraso crescimento - T99 outras doenças endoc./met./nutric ionais	- Identificar e gerir os medos, dúvidas, preconceitos e valores dos adolescentes; - Orientar que a maturação sexual está correlacionada a fatores ambientais e genéticos; - Encaminhar para avaliação médica. Vigilância contínua com consultas a cada 6 meses para monitoramento das alterações. - Orientar alimentação saudável e prática de exercícios físicos regulares; -
- Diabetes - Hiperglicemia - Hipoglicemia	- T87 Hipoglicemia - T89 Diabetes insulino dependente - T90 Diabetes não insulino dependente	- Orientar alimentação saudável e prática de atividade física; - Orientar sobre sinais de alerta para casos de glicemia alterada; - Gerenciar Hiperglicemia; - Gerenciar Hipoglicemia; - Encaminhar para o serviço de urgência, se necessário; - Encaminhar para equipe multidisciplinar para acompanhamento; - Seguir protocolo de diabetes para adolescente.
- Exposição Sexual desprotegida	- P23 Sinais/Sintomas do comportamento do adolescente; - W02 Medo de estar grávida - W10 Contracepção pós-coital	- Orientar sobre a importância do uso de métodos contraceptivos; - Orientar sobre prevenção de IST; - Promover apoio emocional; - Realizar atividades educativas sobre prevenção de IST's. Encaminhar Unidade Básica de Saúde para realizar testagem rápida para HIV, Sífilis e Hepatites Virais. Encaminhar para testagem rápida de

		gravidez, se necessário.-Seguir Protocolo de Profilaxia Pós Exposição, se necessário.
- Falta de conhecimento sobre gestação	- W02 Medo de estar grávida - W29 Sinais/sintomas da gravidez.	Se gestação confirmada: seguir o fluxograma de pré-natal/ encaminhar para consultas de pré natal. Se gestação não confirmada:Orientar e encaminhar para consulta ginecológica e uso de anticoncepcional. Orientar sobre prevenção das Infecções Sexualmente Transmissíveis. Encaminhar para Unidade Básica de Saúde para realizar teste rápido de gravidez e de HIV, Sífilis,Hepatites Virais e BHCG.
- Gestação (Gravidez); - Período de gravidez (especificar trimestre);	- W78 Gravidez	- Orientar a importância do pré-natal para a saúde dela e de seu filho; - Facilitar o futuro exercício da paternidade e da maternidade adolescente, acolhendo as adolescentes grávidas e seus parceiros. Encaminhar para consultas de pré natal e acompanhar. Envolver também os seus familiares; - Pela possibilidade de vulnerabilidade em adolescentes grávidas na faixa etária de 10 a 14 anos, deve-se promover assistência qualificada, com abordagem diferenciada, considerando a necessidade de um maior número de consultas e as questões éticas e legais; - Seguir protocolo de pré-natal.
- Gestação não planejada; - Período de gravidez (especificar trimestre);	W79 Gravidez não desejada;	- Orientar sobre os direitos acerca da gestação: atenção ao pré-natal, assistência ao parto e ao nascimento, rede de proteção social com condições diferenciadas para continuidade dos estudos, licença-maternidade, programas específicos para famílias de baixa renda, utilização de creche e encaminhar para consultas de pre natal na rede de atendimento. - Encaminhar para serviço social do campus para mediação de conflitos familiares decorrentes da gravidez não planejada, em que o fator familiar é determinante para a não aceitação da gravidez. - Orientar sinais e sintomas de alerta: febre, calafrios, hemorragia, dor abdominal, dor no baixo ventre, secreção vaginal com odor fétido ou dor ao urinar. Ressaltar a importância de procurar o serviço de urgência mais próximo caso apresente quaisquer desses sintomas. - Informar sobre o risco de práticas caseiras para a interrupção da gravidez. • Em caso de violência sexual: orientar sobre possibilidades de adoção, caso opte(m) pela continuidade da gestação e não haja desejo ou condições de permanecer com a criança; Informar que a legislação brasileira permite a interrupção da gestação para os casos

		previstos em lei (violência sexual, risco de morte para a mulher, anencefalia fetal). Realizar a notificação de violência sexual. Seguir protocolo de pré-natal.
- Humor deprimido	- P03 Tristeza/ Sensação de depressão	- Obter dados sobre condição psicológica; - Encaminhar para o serviço de psicologia do Campus. - Identificar percepções alteradas; - Solicitar apoio da equipe multiprofissional; - Facilitar acesso ao tratamento; - Monitorar adesão à medicação; promover apoio emocional; - Incentivar a participação em grupos terapêuticos
- Ideação suicida	- P76 Perturbações depressivas - P99 Outras perturbações psicológicas	- Obter dados sobre condição psicológica; - Encaminhar para o serviço de psicologia do Campus. - Facilitar capacidade para comunicar sentimentos; - Identificar percepções alteradas; - Solicitar apoio da equipe multiprofissional; - Monitorar adesão ao tratamento; - Promover apoio emocional; - Implementar precauções contra o suicídio com orientações aos familiares para vigilância; - Incentivar a participação em grupos terapêuticos.
- Ingestão de alimentos insuficiente	- T08 Perda peso - P86 anorexia nervosa, bulimia	- Monitorar o IMC; - Orientar sobre alimentação saudável; - Monitorar ingestão de alimentos; - Estimular busca de atividades prazerosas como hobbies, ter animal de estimação, fazer trabalho voluntário, participação em atividades de grupos como dança, teatro, música, arte, etc. - Solicitar apoio da equipe multiprofissional
- Ingestão de alimentos, excessiva	- T02 Apetite excessivo - T07 Aumento peso - T82 Obesidade	- Monitorar o IMC; - Encaminhar para avaliação médica se constatado obesidade; - Orientar sobre alimentação saudável; - Incorporar a prática de atividade física regular; - Estimular busca de atividades prazerosas como hobbies, ter animal de estimação, fazer trabalho voluntário, participação em atividades de grupos como dança, teatro, música, arte, etc; - Solicitar apoio da equipe multidisciplinar.
-Integridade da pele prejudicada ; - Potencial para Risco de acne	- S06 Erupção cutânea localizada; - S07 Erupção cutânea generalizada;- S21 Sinais/ sintomas da textura da pele.	- Cuidados com a pele, quanto à higiene - lavar o rosto duas vezes por dia com sabonete neutro e água em temperatura ambiente; - Orientar alimentação evitando gordura e frituras;- Orientar não friccionar ou comprimir a acne; - Orientar a não usar maquiagem nem cremes comedogênicos; - Orientar a utilizar cremes e maquiagem com base aquosa e a não abusar da exposição ao sol; - Usar bloqueadores solares não oleosos; - Encaminhar para avaliação médica, se necessário.
- Não Adesão ao Regime de Imunização	- A98 Medicina preventiva/	- Avaliar caderneta de vacinação e encaminhar para a atualização do esquema vacinal; - Planejar e

	manutenção de saúde	promover campanha de vacinação no campus juntamente com a UBS para atualização de caderneta de vacinação e orientações.
- Pressão arterial alterada	- K85 Pressão arterial elevada - K86 Hipertensão sem complicações - K87 Hipertensão com complicações	- Orientar sobre a doença; - Orientar sobre alimentação saudável; - Orientar sobre uso dos medicamentos ; - Orientar sobre prevenção de complicações com a manutenção de níveis pressóricos normais e controle de fatores de risco (tabagismo, estresse, bebida alcoólica e sedentarismo); - Estimular o autocuidado, adesão ao tratamento e envolver familiares no cuidado; - Estimular a participação em grupos educativos; - Orientar modificações do estilo de vida Alimentação saudável: Dieta rica em frutas, vegetais e alimentos com baixa densidade calórica e baixo teor de gorduras saturadas e totais; - Diminuição de ingestão de sal; Limite da ingestão diária de bebidas alcoólicas; - Abandono do tabagismo Estimular a execução de atividades físicas de acordo com a limitação de cada cliente; - Encaminhar para nutricionista e avaliação médica.
- Situação de violência		- Encaminhar para o serviço social do campus. - Seguir protocolo de Prevenção de violência à criança e ao adolescente.
- Tentativa de suicídio	- P77 Suicídio/ tentativa de suicídio	- Se necessário, encaminhar para o serviço de emergência ou consulta e avaliação médica; - Obter dados sobre condição psicológica; - Facilitar capacidade para comunicar sentimentos; Identificar percepções alteradas; - Encaminhar para serviço de psicologia do Campus; - Solicitar apoio da equipe multiprofissional; - Notificar violência autoprovoada; Monitorar adesão ao tratamento; - Promover apoio emocional; - Implementar precauções contra o suicídio com orientações aos familiares para vigilância; - Incentivar a participação em grupos terapêuticos.
- Visão Eficaz	- A98 Medicina preventiva/ manutenção de saúde	- Orientar sobre fatores de risco para visão como uso excessivo de telas entre outros.-Encaminhar para avaliação com oftalmologista periodicamente.
- Visão, Prejudicada	- F28 Limitação funcional/incapacidade - F29 Outros sinais/ sintomas oculares	Encaminhar para avaliação médica/oftalmologista.

APÊNDICE D – QUESTIONÁRIO AVALIAÇÃO PRODUTO EDUCACIONAL

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO - TCLE

Prezado(a) senhor(a), você está sendo convidado(a) a participar do projeto de pesquisa intitulado: **“Percepção dos Profissionais de Enfermagem sobre o Registros da Assistência de Enfermagem e sua atuação profissional no Instituto Federal Catarinense.”** desenvolvida por Juliana Amadei, discente do Programa de Mestrado Profissional em Educação Profissional e Tecnológica em Rede Nacional - Polo Blumenau (ProfEPT). A pesquisa está inserida na linha de pesquisa “Organizações e Memórias de Espaços Pedagógicos na EPT”, no Macroprojeto “4 - História e Memória no contexto da EPT”, com orientação da Professora Dr. Denise Fernandes e autorizada pelo Comitê de Ética em Pesquisa do IFC (CEPSH).

O objetivo da pesquisa é compreender a percepção dos profissionais de enfermagem sobre o sistema de registro da Assistência de Enfermagem no Instituto Federal Catarinense visando a construção de um prontuário unificado e sua atuação educativa. Também pretende-se elaborar um produto educacional em forma de um prontuário eletrônico para uso da enfermagem e um calendário de ações educativas, fortalecendo assim o registro da assistência de enfermagem e atuação em ações educativas na Instituição.

O método de obtenção de dados previsto para esta pesquisa é através de entrevista com os profissionais de enfermagem que prestam assistência de enfermagem. Sua participação ocorrerá de forma voluntária e consistirá na participação de uma entrevista por meio de plataforma virtual em um primeiro momento e a posteriori, um questionário, para a validação do produto educacional.

Todas as informações prestadas serão confidenciais, utilizadas apenas em publicações e/ou eventos científicos, mas sempre sendo garantido o sigilo da sua identificação e participação. Caso alguma pergunta lhe ofereça constrangimento o(a) Sr.(a) tem a escolha de não responder ou de interromper a entrevista sem nenhum prejuízo.

Sua participação nesta pesquisa pode trazer alguns riscos, tais como: A coleta de dados provocarem algum tipo de desconforto (de ordem subjetiva), entre os quais podemos mencionar: invasão de privacidade; responder a questões sensíveis, tais como atos ilegais; revitimizar e perder o autocontrole e a integridade ao revelar pensamentos e sentimentos nunca revelados; discriminação e estigmatização a partir do conteúdo revelado; divulgação de dados; tomar o tempo para responder as perguntas das entrevistas individuais semiestruturadas.

Nesses casos, as medidas/providências tomadas serão: a garantia do acesso aos resultados da produção de dados decorrentes da participação na pesquisa. Esta garantia ocorrerá por meio da disponibilização de forma impressa, digital e/ou adaptada das transcrições das entrevistas individuais/coletivas semi estruturadas ou grupos focais e do texto do relatório final. A minimização de desconfortos, garantindo local reservado e liberdade para não responder questões constrangedoras.

A pesquisadora estará preparada para a aplicação de técnicas de produção dos dados. Ficará atenta aos sinais de desconforto e garantirá a não violação e a integridade dos documentos (danos físicos, cópias, rasuras) caso sejam entregues pelos entrevistados. A pesquisadora assegurará a confidencialidade e a privacidade, a proteção da imagem e a não estigmatização, garantindo a não utilização das informações em prejuízo dos entrevistados, inclusive em termos de autoestima, de prestígio e/ou econômico/financeiro.

Destacam-se também os possíveis riscos característicos do ambiente virtual, meios eletrônicos, ou atividades não presenciais, em função das limitações das tecnologias utilizadas. Além disso, existem limitações dos pesquisadores para assegurar total confidencialidade e potencial risco de sua violação dos dados da pesquisa, portanto, serão tomadas todas as providências para a garantia da confidencialidade, deletando os registros de e-mail e dos dados em nuvem e

armazenando adequadamente os dados coletados, e ainda garantir que os sujeitos da pesquisa que vierem a sofrer qualquer tipo de dano previsto ou não no termo de consentimento e resultante de sua participação na pesquisa, seja indenizado pelo dano, nos termos da Lei.

A possibilidade de divulgação de voz e imagem do entrevistado, somente ocorrerá com o consentimento do mesmo, caso a divulgação seja importante para a pesquisa e haja interesse do participante na divulgação. Nesse caso, será lavrado um termo de autorização de uso de voz e imagem, solicitando a sua permissão. Não havendo seu consentimento, seu nome, dados pessoais e/ou o material que indique sua participação será mantido sob sigilo, você não será identificado (a) em nenhuma publicação que possa resultar.

Sua participação é extremamente importante, mas enfatizo que você tem plena autonomia para decidir se quer ou não participar, bem como desistir da participação nesta pesquisa no momento em que desejar, sem necessidade de qualquer explicação e sem nenhuma forma de penalização. Também não sofrerá nenhum prejuízo caso decida não participar, ou desistir da mesma. No entanto, gostaria muito de poder contar com a sua participação.

Os benefícios dos resultados da pesquisa serão diretos e indiretos. Diretos ao compartilhar e compreender as percepções e anseios dos profissionais de enfermagem no IFC, possibilitar uma melhor organização dos registros da enfermagem de maneira unificada, sugerir e organizar um calendário de ações de prevenção e promoção à saúde. Indiretos ao possibilitar ações educativas integradas entre os campus de prevenção e promoção à saúde, possibilitar os registros de forma unificada criando um histórico de ações da enfermagem, possibilitar a segurança para os profissionais e da Instituição com o registro de todos os atendimentos e necessidades dos discentes atendidos. Possibilitar dados acadêmicos de referência para as discussões acerca das ações de enfermagem em ambiente escolar.

Esta pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos (CEPSH) do Instituto Federal Catarinense (IFC). O Comitê tem por objetivo assegurar os interesses dos sujeitos participantes de pesquisas científicas, em sua integridade e dignidade. Caso persistam dúvidas, sugestões e/ou denúncias após os esclarecimentos dados pela equipe científica desta pesquisa, o CEPSH do IFC está disponível para atendê-lo, localizado junto ao IFC *Campus* Camboriú, pelo telefone (47) 2104-0882 ou pelo endereço eletrônico cepsh@ifc.edu.br. Em caso de dúvidas sobre a pesquisa ou para relatar algum problema, a qualquer momento que considerar necessário, você poderá contatar a pesquisadora Juliana Amadei pelo *Telefone*: (47) 997524711 e e-mail: juliana.amadei@ifc.edu.br.

Ao final do trabalho, será garantido o acesso aos resultados da produção de dados decorrentes da participação nesta pesquisa. Esta garantia ocorrerá por meio da disponibilização de forma impressa, digital e/ou adaptada do texto final da dissertação, e caso solicitado, a tabulação das entrevistas e questionários.

Finalizamos aqui o TCLE, caso você considere suficiente os esclarecimentos redigidos sobre as finalidades e atividades da presente pesquisa, caso concorde com a participação nesta pesquisa, solicitamos o preenchimento de seus dados e sua assinatura e em seguida, uma via deste termo assinada por você e pela pesquisadora será enviada para você por e-mail.

No momento do questionário on-line, caso aceite participar da pesquisa, será necessário marcar a opção “aceito”. Ao informar que você está de acordo e deseja participar, este documento será considerado assinado e consentido por você. Por fim, quando tiver respondido todas as questões, deverá clicar em enviar as respostas. Tanto este TCLE para a entrevista, quanto o registro de consentimento do questionário ficarão disponíveis para o/a participante solicitar o acesso sempre que necessário, podendo imprimir caso considerar necessário, mas salientamos que é importante que guarde as cópias que serão enviadas para você.

Desde já agradecemos sua participação!

Blumenau, Agosto de 2023.

E-mail*

E-mail válido

Este formulário está coletando e-mails.

Consentimento para participação

☐ Aceito

☐ Não aceito

1. Você considera adequado o conteúdo a ser registrado no prontuário de assistência de enfermagem apresentado?

☐ Adequado

☐ Não adequado

☐ Incompleto

☐ Outros

2. Caso tenha assinalado não adequado ou incompleto, por favor dê suas sugestões abaixo. Por que? Quais itens retiraria? Quais itens adicionaria?

Texto de resposta longa

3. Quais as vantagens que você identifica ao fazer o registro da assistência de enfermagem em prontuário padronizado? Pode ser selecionado mais de uma opção.

☐ Entrar em conformidade com o COREN

☐ Auxiliar em processos internos de atendimento ao paciente

☐ Realizar registro oficial das ações prestadas no atendimento e orientação

☐ Criar um histórico que possibilita análise e novos planejamentos

☐ Outros

4. Quais as desvantagens que você identifica ao fazer o registro da assistência de enfermagem em prontuário padronizado? Pode ser selecionado mais de uma opção.

☐ Tomar muito tempo para realizar os registros

☐ Inutilidade dos dados após o registro

☐ Impossibilidade de somar essa função as demandas do setor

☐ Criar dados sensíveis sobre a vida e necessidades dos discentes

☐ Outros

5. Você considera que as anotações/registros da assistência de enfermagem no IFC em prontuário padronizado de fato irão melhorar a assistência de enfermagem ao paciente?

☐ Sim

☐ Não

☐ Prefiro não opinar

☐ Outros

6. Quais motivos acredita que as anotações/registros da assistência de enfermagem em prontuário padronizado no IFC podem melhorar de fato a assistência de enfermagem ao paciente? Por que?

Texto de resposta longa

7. Você considera que os registros da assistência de enfermagem e as ações de prevenção e promoção a saúde contribuem para a formação integral? Explique.

Texto de resposta longa

8. Você considera possível aplicar o calendário unificado entre os campus do IFC de ações de educação em saúde?

☐ Sim

☐ Não

☐ sim, se eu tiver ajuda de outros servidores

☐ sim, se houver uma força tarefa coletiva entre os campus

☐ não tenho interesse em aplicar o calendário de ações educativas

() Outros

9. Você se sente motivado em fazer parte destas ações de registro e de ações de educação em saúde?

() Sim

() Não

() Prefiro não opinar

() Outros

10. Quanto ao calendário apresentado de ações de educação em saúde unificado, quais itens retiraria? Quais itens adicionaria?

Texto de resposta longa

11. Você se sente educador ao realizar as ações de educação em saúde?

() sim, sinto-me um educador

() Não, sinto-me um enfermeiro

() outros

12. Ao realizar atividades e as ações de educação em saúde, acredita que essas contribuem para a formação omnilateral? Por que?

() Sim

() Não

() Outros

13. Você considera necessário o contínuo contato com os colegas profissionais de enfermagem dos demais campus para que essas ações sejam realizadas e fortalecidas? Por qual motivo?

Texto de resposta longa

14. Você acredita que para a efetivação do calendário de ações seria interessante a eleição/seleção entre os profissionais de enfermagem um coordenador para organizar/motivar as atividades unificadas de enfermagem?

() Sim, com certeza

() não, o grupo consegue se organizar

() Prefiro não opinar

() Outros

15. Você considera que essa pesquisa trouxe informações ou diagnósticos que permitem auxiliar nas atividades da equipe de enfermagem no IFC e possibilitam melhorias no setor?

() Sim, acredito que trará melhorias se aplicados os produtos

() Acredito que as informações foram interessantes, mas não vejo uma real melhoria nas atividades

() Não, para uma melhoria das atividades mudanças mais profundas são necessárias

() Prefiro não opinar

() Outros

16. Caso você considerou que a pesquisa de fato não foi suficiente para trazer melhorias para o setor, quais pontos deixaram ou deveriam ser levantados/explorados?

Texto de resposta longa

17. Quais sugestões você poderia apontar para melhorar os produtos educacionais, tanto o sistema padronizado de registro da assistência, quanto o calendário de ações educativas?

Texto de resposta longa

18. Apresente os pontos que você considerou forte nos produtos educacionais.

Texto de resposta longa

19. Apresente suas críticas quanto aos produtos apresentados e a pesquisa realizada.

Texto de resposta longa

APÊNDICE E – PRODUTO EDUCACIONAL APRIMORADO

Instituto Federal Catarinense (IFC)

Setor - Saúde/Ambulatório

Produto Educacional I

Sistematização da enfermagem no IFC

Prezados pais e responsáveis por estudantes ingressantes nos cursos Técnicos Integrados do IFC.

Este formulário faz parte da sistematização do serviço de enfermagem no IFC e será utilizado para subsidiar os serviços de Atenção à Saúde. Nele devem ser adicionadas informações sobre o estudante.

Instrumento de consulta de enfermagem com adolescente	
Formulário Anamnese (realizar no ingresso do estudante, com auxílio dos pais ou sob consulta individual)	
1 - Identificação do estudante	
Nome completo:	
Nome social:	
Data de Nascimento:	Idade:
curso:	turma:
Moradia estudantil:	
Email do estudante:	
Email do responsável:	
Edereço: Rua:	Nº
Bairro:	Cidade/UF:
Telefone residencial:	Celular:
Nome da Mãe:	Profissão:
Telefone - trabalho (mãe):	Celular

Celular:		
Nome do pai:	Celular:	
Telefone - trabalho (pai):	Celular	
Outro responsável	Parentesco:	
Telefone residencial:	Celular:	
Possui algum convênio médico? Sim () Não () Qual?		
Nº Carteirinha do plano:		
Nº Cartão SUS:		
Qual tipo sanguíneo? () A - () B - () O - () AB - () A+ () B+ () O + () AB +		
2 - História Pregressa		
Doenças crônicas: (exemplo diabetes, hipertensão, etc) () Sim () Não Qual?		
Possui alergias: () Sim () Não Qual?		
Cirurgias: () Sim () Não Qual?		
Há quanto tempo?		
Possui algum problema de saúde com diagnóstico estabelecido?		
Realiza algum acompanhamento médico? () Sim () Não Qual?		
Há quanto tempo?		
Uso de medicamentos contínuo? () Sim () Não Qual?		
*O receituário dos medicamentos citados deve ser apresentado no setor de saúde e atualizados quando houver troca de medicação.		
3 - Informações complementares		
Renda Bruta familiar:		
Vínculo familiar: Quantos membros são na família?		

Grau de parentesco? (ex: pai, mãe, irmão etc) Moradia do estudante:(☐) reside com a família (☐) reside em moradia estudantil
(☐) Reside com outro responsável. Qual?
Realiza atividade física regularmente? (☐)Sim (☐) Não Qual/Quais?
Alimentação: Quantas refeições o estudante faz durante o dia? (☐) 1; (☐) 2; (☐) 3; (☐) mais do que 3; (☐) Não sei.
O estudante possui alguma restrição alimentar? (☐) Sim (☐) Não Qual?
Sono e repouso: Em média, quantas horas o estudante dorme? (☐) menos que 6 horas; (☐) 6 a 8 horas; (☐) mais do que 8 horas
Como é avaliado o sono do estudante? (☐) Dorme bem, possui um sono contínuo e não tem nenhuma dificuldade. (☐) Não dorme bem, acorda durante o sono e possui dificuldade para iniciar o sono. Motivos que dificultam o sono: _____
O estudante faz uso de algum medicamento para dormir? (☐) Sim (☐) Não Qual?
Crença/espiritualidade:
Você sente-se feliz com sua vida:
Planos para o futuro:
4 - Fatores de Risco
Assinale abaixo se há algum fator de risco relacionado à saúde do adolescente: (☐) Fumo; (☐) Uso de álcool; (☐) Estresse; (☐) Obesidade; (☐) Desnutrição; (☐) Sedentarismo; (☐) Uso de drogas. Quais?
Algum membro da família faz uso de álcool e/ou outras drogas?
5 - Acompanhamentos
O estudante faz algum acompanhamento especializado? (ex: Ansiedade, Depressão, Transtorno de Déficit de Atenção com Hiperatividade(TDAH, entre outros). (☐) Sim (☐) Não Em caso afirmativo. Qual?
A caderneta de vacinação do estudante está atualizada? (☐) Sim (☐) Não
Em relação aos exames periódicos(ex: sangue, urina, etc realizados pelo adolescente):

- () realiza exames periódicos anualmente.
 () não realiza exames periódicos anualmente.

Este formulário será utilizado para subsidiar os serviços de Atenção à Saúde, Atenção Psicológica e Serviço Social, havendo necessidade de utilização destas informações por outros profissionais da equipe escolar:

() **Ciente** que o serviço de Atenção à saúde repassa informações fornecidas neste formulário de Anamnese para outros profissionais da equipe escolar (técnicos administrativos e docentes) se verificado a necessidade e/ou conforme legislação.

Declaro que as informações aqui fornecidas são a mais pura expressão da verdade. Desde já autorizo a verificação dos dados, sabendo que a omissão ou falsidade de informações resultará nas penalidades cabíveis conforme a lei 2848/40.

_____, _____ de _____, de _____

Assinatura do estudante

Assinatura do responsável

Assinatura do Serviço de Atenção à Saúde

Instituto Federal Catarinense - IFC

Setor - Saúde/Ambulatório

Profissionais: Enfermeiros

Sistematização da enfermagem no IFC

Instrumento de consulta de enfermagem com adolescente

Consulta de enfermagem subsequente

Data:

Hora:

Motivo da consulta/queixa principal:

Exame físico		
Pressão arterial:	Pulso:	Saturação:
Temperatura:		
Medidas antropométricas: Peso:	Estatura:	IMC:
Classificação do IMC: *Sugestão:utilizar a calculadora de IMC tua saúde disponível em www.tuasaude.com › calculadora › imc		
Alterações na pele (feridas, lesões,manchas, acnes):		
Avaliação cavidade oral(data da última avaliação odontológica):		
Queixas respiratórias:		
Consumo alimentar/hidratação:		
Queixas auditivas/oculares:		
Eliminações vesicais/intestinais:		
História menstrual - DUM:		
Atividade sexual/historia sexual:		
Contraceção:		
Identidade de gênero(qual gênero se identifica: homem, mulher, transgenero,intersexual...): Orientação sexual (atração, desejo,afetividade, prática sexuais - homoafetivo, biafetivo,heteroafetivo,assexual...):		
Sexualidade (corrimento,verrugas,feridas outros):		
Avaliação de exames: () com alterações () sem alterações		
Aspectos gerais:		
Diagnóstico de enfermagem:		

Evolução de enfermagem:
Anotação de enfermagem:
Profissional: carimbo e assinatura

Setor: Ambulatório - SISAE

Profissionais: Enfermeiros, técnicos de enfermagem e equipe multidisciplinar:

Produto Educacional II

Cronograma de ações de educação e prevenção em saúde

O Serviço de Atenção à Saúde na escola contribui para formação integral dos estudantes por meio das ações de promoção, prevenção de doenças e agravos à saúde, visando um enfrentamento das vulnerabilidades que comprometem ou podem vir a comprometer o desenvolvimento pleno de crianças, adolescentes e jovens no cotidiano escolar. Diante disso, elaborei um cronograma de ações de promoção e prevenção em Saúde conforme informações que vocês trouxeram na entrevistas para suas considerações e apontamentos.

Cronograma de ações em educação e promoção/prevenção em Saúde.

Janeiro/Fevereiro - Realizar Anamnese (histórico de saúde) dos estudantes adolescentes ingressantes no ensino médio integrado conforme informações do prontuário unificado.

Março - Prevenção da gravidez na adolescência e métodos contraceptivos.

Abril - Imunização: Planejar campanhas de vacinação juntamente com a UBS para atualização de caderneta de vacinação e ações específicas do campus.

Mai - Saúde Bucal e ações específicas do campus.

Junho Branco - Mês de Conscientização e Prevenção ao uso de drogas e ações específicas do Campus.

Setembro - Campanha Setembro Amarelo - Saúde mental.

Outubro - Campanha Outubro Rosa - Prevenção do câncer de mama e de colo de útero.

Novembro - Campanha Novembro Azul - Saúde do homem

Dezembro - Campanha Dezembro vermelho - Prevenção das DSTs/AIDS, Saúde Sexual

Sugestões de consulta de material em sites bibliográficos e ações.

Jan/ Fev: Avaliação do Crescimento e Desenvolvimento: Avaliar peso, altura, IMC e registrar informações no prontuário unificado.

Planejar atividades na semana de integração em parceria com docentes de educação física.

*Sugestão: utilizar a calculadora de IMC tua saúde disponível em www.tuasaude.com › calculadora › imc

Mar - Prevenção da gravidez na adolescência e métodos contraceptivos.

Ações - Produção de matéria para site institucional, instagram do Campus, email para estudantes.

Palestras, oficinas, rodas de conversa, dinâmica, peça teatral sobre o tema em parceria com a equipe multidisciplinar, docentes e/ou secretaria de saúde do município.

Abril - Imunização

Planejar campanhas de vacinação juntamente com a UBS para atualização de caderneta de vacinação do adolescente e ações específicas do campus.

Divulgar a ação em parceria com a Cecom do campus pelos meios de comunicação do IFC.

Enviar termo de autorização para os pais e responsáveis assinarem explicando a ação e especificando as vacinas que serão aplicadas no discente.

Maio - Saúde Bucal

Ações - Planejar e realizar atividades em parceria com a secretaria de saúde como oficinas, palestra, roda de conversa, entre outras.

Campanha setembro Amarelo

Ações - Produção de matéria para site institucional, instagram do Campus, email para estudantes e servidores.

Palestra e/ou oficinas/roda de conversa sobre o tema em parceria com serviço de psicologia do Campus e secretaria de saúde.

Campanhas nacionais: setembroamarelo.org.br > o-movimento

Campanha Outubro Rosa:

Ações - Produção de matéria para site institucional, instagram do Campus, email para estudantes e servidores.

Decoração alusiva ao setor e /ou Campus sobre a campanha.

Palestra e/ou oficinas/roda de conversa sobre o tema.

Caminhada Rosa em parceria com a rede feminina de combate ao câncer, secretaria municipal de saúde e demais entidades parceiras.

Decoração alusiva ao setor e /ou Campus sobre a campanha.

Campanhas nacionais: Site www.gov.br > assuntos > campanhas

Campanha novembro azul.

Ações: Produção de material informativo para site institucional, instagram do Campus, email para estudantes e servidores.

Palestra e/ou oficinas/roda de conversa sobre o tema.

Ação dia da saúde (barraca ou no ambulatório) em parceria com secretaria de saúde com verificação de pressão arterial, HGT e orientações sobre saúde do homem.

Decoração alusiva ao setor e /ou Campus sobre a campanha.

Campanhas nacionais: Site www.gov.br > assuntos > campanhas

Campanha Dezembro vermelho

Ações: Produção de material informativo para site institucional, instagram do Campus, email para estudantes e servidores.

Campanha de testes rápidos em parceria com a secretaria de saúde com orientações sobre IST e HIV/AIDS.

Campanhas nacionais: bvsms.saude.gov.br > dezembro-vermelho

Quadro 1. Registros de ações de educação em saúde

Data	Hora	Ação	Nº Participantes

ANEXO A – DIAGNÓSTICOS DE ENFERMAGEM

Diagnósticos e Intervenções de Enfermagem O quadro abaixo apresenta uma sugestão para os principais diagnósticos de enfermagem para o adolescente, tendo como referência a Classificação Internacional para a Prática de Enfermagem (CIPE), atrelada à Classificação Internacional de Atenção Primária (CIAP) e seguida das principais intervenções de enfermagem. Neste contexto é importante destacar que o Enfermeiro mediante a avaliação, embasado em conhecimento científico, possui autonomia para realização de outros diagnósticos e estabelecer um plano de cuidados, considerando sempre a singularidade do indivíduo, a integralidade do cuidado e recursos disponíveis na rede de saúde, para atender as necessidades dos usuários. Uma vez que os adolescentes procuram com menor frequência os serviços de saúde, os enfermeiros, dentre as possíveis intervenções de enfermagem, devem realizar intervenções referente a sexualidade, IST, testes rápidos para IST, métodos contraceptivos e saúde mental, bem como realizar atividades educativas no ambiente escolar. Avistamos que se trata de uma oportunidade de investigação de dados, elementos de grande importância para a saúde desta população.

QUADRO 2. Principais diagnósticos e intervenções de enfermagem, segundo a CIPE/CIAP.

Principais diagnóstico / resultados de enfermagem – CIPE	CIAP	Principais Intervenções de Enfermagem
- Abuso de álcool (ou Alcoolismo)	- P15 abuso crônico de álcool - P16 abuso agudo de álcool	- Encaminhar para profissional médico ou serviço de urgência, se necessário; - Aconselhar sobre uso de álcool;- Encaminhar para serviços de psicologia e social do campus - Apoiar condição psicológica; - Apoiar família; - Encaminhar para avaliação e atendimento psicológico em serviço de referência se necessário; - Avaliar resposta psicossocial ao plano de cuidado; - Facilitar acesso ao tratamento; - Monitorar abstinência; - Realizar atividades educativas de prevenção ao uso de álcool com a comunidade escolar.
- Abuso de drogas	- P19 abuso de drogas	- Encaminhar para o serviço de emergência, se necessário; - Encaminhar para os serviços de psicologia e serviço social do campus; -Encaminhar para atendimento psicológico em serviço de referência se necessário; - Encaminhar para terapia de grupo de apoio; - Facilitar acesso ao tratamento; - Orientar sobre consequências do abuso de drogas; - Orientar sobre manejo (controle) dos sintomas de abstinência; - Orientar sobre

		prevenção de recaída; - Apoiar processo familiar de enfrentamento; - Avaliar adesão ao regime terapêutico; - Promover (proporcionar, fornecer) apoio emocional; - Reforçar conquistas; Realizar atividades educativas de prevenção ao uso de álcool com a comunidade escolar.
- Abuso de tabaco (ou de fumo)	- P17 abuso de tabaco	- Aconselhar paciente; - Encaminhar para grupo de tabagismo mais próximo; - Encaminhar para avaliação e atendimento psicológico do campus; - Orientar sobre exposição ao tabagismo secundário (passivo); - Realizar atividades educativas de prevenção ao uso de tabaco na escola.
- Adesão ao regime de imunização	- A98 medicina preventiva/ manutenção de saúde	- Realizar reforço positivo para manter esquema vacinal em dia.
- Autoimagem negativa	- P23 sinais/sintomas relacionados ao comportamento do adolescente	- Apoiar imagem corporal, positiva; - Identificar percepções alteradas; - Obter dados sobre condição psicológica; - Solicitar apoio da equipe multiprofissional.
- Automutilação	- P23 Sinais/sintomas relacionados ao comportamento do adolescente - P29 sinais/sintomas psicológicos, outros - - - P76 perturbações depressivas - S18 laceração/corte	- Avaliar ferimentos; - Encaminhar para consulta e avaliação médica; - Realizar curativo de acordo com a cobertura indicada; - Obter dados sobre condição psicológica; - Reforçar comportamento, positivo; - Promover estabelecimento de limites; - Orientar sobre controle de impulso; - Solicitar apoio da equipe multiprofissional ; - Notificar violência autoprovocada; - Monitorar adesão ao regime terapêutico; - Avaliar situação vacinal.
- Baixa autoestima	- P23 sinais/sintomas relacionados ao comportamento do adolescente - P76 perturbações depressivas - A18 preocupação com aparência	- Encorajar afirmações positivas; - Facilitar capacidade para comunicar sentimentos; - Obter dados sobre condição psicológica; - Encaminhar para avaliação e atendimento psicológico do Campus - Solicitar apoio da equipe multiprofissional .
- Capaz de executar o autocuidado com a pele com acne	- S06 erupção cutânea localizada - S07 erupção cutânea generalizada - S21 sinais/ sintomas da textura da pele	- Reforçar a capacidade positiva de executar os cuidados com a pele e com alimentação equilibrada.
- Cólica menstrual presente; - Descarga (ou fluxo) menstrual anormal; - Menorragia	- X02 dores menstruais - W06 menstruação excessiva - X07 Menstruação irregular/frequente	- Orientar quanto a hábitos de higiene corporal e íntima; - Orientar a realizar registro dos sintomas e datas; - Orientar aplicação de calor local com média intensidade, em baixo ventre, enquanto tiver

		dor; - Orientar a realizar exercício físico moderado e aumentar ingestão hídrica; - Orientar sobre os riscos de automedicação; - Encaminhar para avaliação médica se necessário.
- Comportamento sexual eficaz; - Conhecimento sobre comportamento sexual eficaz	- P23 sinais/sint. comportamento adolescente - A98 medicina preventiva/ manutenção de saúde	- Reforçar orientações sobre métodos de prevenção das Infecções Sexualmente Transmissíveis; - Reforçar para prevenção de gravidez indesejada e de métodos contraceptivos e de barreira.
- Comportamento sexual problemático; - Potencial para risco de promiscuidade; - Relação sexual iniciado; - Relação sexual de risco; - Risco de gestação, não intencional; - Estado de gravidez não planejada	- Z04 problemas socioculturais - P23 sinais/sint. comportamento adolescente	- Orientar sobre métodos de prevenção das Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST); - Orientar para prevenção de gravidez indesejada e métodos contraceptivos e de barreira; - Encaminhar para consulta ginecológica; - Em casos de sinais e sintomas de IST seguir Protocolo de IST/HIV; - Realizar atividades educativas com a comunidade escolar.
- Desenvolvimento de adolescente, prejudicado; - Crescimento e desenvolvimento incompatíveis com a idade	- A18 preocupação com aparência; - T10 atraso crescimento - T99 outras doenças endoc./met./nutric ionais	- Identificar e gerir os medos, dúvidas, preconceitos e valores dos adolescentes; - Orientar que a maturação sexual está correlacionada a fatores ambientais e genéticos; - Encaminhar para avaliação médica. Vigilância contínua com consultas a cada 6 meses para monitoramento das alterações. - Orientar alimentação saudável e prática de exercícios físicos regulares; -
- Diabetes - Hiperglicemia - Hipoglicemia	- T87 Hipoglicemia - T89 Diabetes insulino dependente - T90 Diabetes não insulino dependente	- Orientar alimentação saudável e prática de atividade física; - Orientar sobre sinais de alerta para casos de glicemia alterada; - Gerenciar Hiperglicemia; - Gerenciar Hipoglicemia; - Encaminhar para o serviço de urgência, se necessário; - Encaminhar para equipe multidisciplinar para acompanhamento; - Seguir protocolo de diabetes para adolescente.
- Exposição Sexual desprotegida	- P23 Sinais/Sintomas do comportamento do adolescente; - W02 Medo de estar grávida - W10 Contracepção pós-coital	- Orientar sobre a importância do uso de métodos contraceptivos; - Orientar sobre prevenção de IST; - Promover apoio emocional; - Realizar atividades educativas sobre prevenção de IST's. Encaminhar Unidade Básica de Saúde para realizar testagem rápida para HIV, Sífilis e Hepatites Virais. Encaminhar para testagem rápida de gravidez, se necessário. - Seguir Protocolo de Profilaxia Pós Exposição, se necessário.

- Falta de conhecimento sobre gestação	- W02 Medo de estar grávida - W29 Sinais/sintomas da gravidez.	Se gestação confirmada: seguir o fluxograma de pré-natal/ encaminhar para consultas de pré natal. Se gestação não confirmada: Orientar e encaminhar para consulta ginecológica e uso de anticoncepcional. Orientar sobre prevenção das Infecções Sexualmente Transmissíveis. Encaminhar para Unidade Básica de Saúde para realizar teste rápido de gravidez e de HIV, Sífilis, Hepatites Virais e BHCG.
- Gestação (Gravidez); - Período de gravidez (especificar trimestre);	- W78 Gravidez	- Orientar a importância do pré-natal para a saúde dela e de seu filho; - Facilitar o futuro exercício da paternidade e da maternidade adolescente, acolhendo as adolescentes grávidas e seus parceiros. Encaminhar para consultas de pré natal e acompanhar. Envolver também os seus familiares; - Pela possibilidade de vulnerabilidade em adolescentes grávidas na faixa etária de 10 a 14 anos, deve-se promover assistência qualificada, com abordagem diferenciada, considerando a necessidade de um maior número de consultas e as questões éticas e legais; - Seguir protocolo de pré-natal.
- Gestação não planejada; - Período de gravidez (especificar trimestre);	W79 Gravidez não desejada;	- Orientar sobre os direitos acerca da gestação: atenção ao pré-natal, assistência ao parto e ao nascimento, rede de proteção social com condições diferenciadas para continuidade dos estudos, licença-maternidade, programas específicos para famílias de baixa renda, utilização de creche e encaminhar para consultas de pré natal na rede de atendimento. - Encaminhar para serviço social do campus para mediação de conflitos familiares decorrentes da gravidez não planejada, em que o fator familiar é determinante para a não aceitação da gravidez. - Orientar sinais e sintomas de alerta: febre, calafrios, hemorragia, dor abdominal, dor no baixo ventre, secreção vaginal com odor fétido ou dor ao urinar. Ressaltar a importância de procurar o serviço de urgência mais próximo caso apresente quaisquer desses sintomas. - Informar sobre o risco de práticas caseiras para a interrupção da gravidez. • Em caso de violência sexual: orientar sobre

		possibilidades de adoção, caso opte(m) pela continuidade da gestação e não haja desejo ou condições de permanecer com a criança; Informar que a legislação brasileira permite a interrupção da gestação para os casos previstos em lei (violência sexual, risco de morte para a mulher, anencefalia fetal). Realizar a notificação de violência sexual. Seguir protocolo de pré-natal.
- Humor deprimido	- P03 Tristeza/ Sensação de depressão	- Obter dados sobre condição psicológica; - Encaminhar para o serviço de psicologia do Campus. - Identificar percepções alteradas; - Solicitar apoio da equipe multiprofissional ; - Facilitar acesso ao tratamento; - Monitorar adesão à medicação; Promover apoio emocional; - Incentivar a participação em grupos terapêuticos
- Ideação suicida	- P76 Perturbações depressivas - P99 Outras perturbações psicológicas	- Obter dados sobre condição psicológica; - Encaminhar para o serviço de psicologia do Campus.- Facilitar capacidade para comunicar sentimentos; - Identificar percepções alteradas; - Solicitar apoio da equipe multiprofissional ; - Monitorar adesão ao tratamento; - Promover apoio emocional; - Implementar precauções contra o suicídio com orientações aos familiares para vigilância; - Incentivar a participação em grupos terapêuticos.
- Ingestão de alimentos insuficiente	- T08 Perda peso - P86 anorexia nervosa, bulimia	- Monitorar o IMC; - Orientar sobre alimentação saudável; - Monitorar ingestão de alimentos; - Estimular busca de atividades prazerosas como hobbies, ter animal de estimação, fazer trabalho voluntário, participação em atividades de grupos como dança, teatro, música, arte, etc. - Solicitar apoio da equipe multiprofissional
- Ingestão de alimentos, excessiva	- T02 Apetite excessivo - T07 Aumento peso - T82 Obesidade	- Monitorar o IMC; - Encaminhar para avaliação médica se constatado obesidade; - Orientar sobre alimentação saudável; - Incorporar a prática de atividade física regular; - Estimular busca de atividades prazerosas como hobbies, ter animal de estimação, fazer trabalho voluntário, participação em atividades de grupos como dança, teatro, música, arte, etc; - Solicitar apoio da equipe multidisciplinar.
-Integridade da pele prejudicada ; - Potencial para Risco de acne	- S06 Erupção cutânea localizada; - S07 Erupção cutânea generalizada;-	- Cuidados com a pele, quanto à higiene - lavar o rosto duas vezes por dia com sabonete neutro e água em temperatura

	S21 Sinais/ sintomas da textura da pele.	ambiente; - Orientar alimentação evitando gordura e frituras; - Orientar não friccionar ou comprimir a acne; - Orientar a não usar maquiagem nem cremes comedogênicos; - Orientar a utilizar cremes e maquiagem com base aquosa e a não abusar da exposição ao sol; - Usar bloqueadores solares não oleosos; - Encaminhar para avaliação médica, se necessário.
- Não Adesão ao Regime de Imunização	- A98 Medicina preventiva/ manutenção de saúde	- Avaliar caderneta de vacinação e encaminhar para a atualização do esquema vacinal; - Planejar e promover campanha de vacinação no campus juntamente com a UBS para atualização de caderneta de vacinação e orientações.
- Pressão arterial alterada	- K85 Pressão arterial elevada - K86 Hipertensão sem complicações - K87 Hipertensão com complicações	- Orientar sobre a doença; - Orientar sobre alimentação saudável; - Orientar sobre uso dos medicamentos ; - Orientar sobre prevenção de complicações com a manutenção de níveis pressóricos normais e controle de fatores de risco (tabagismo, estresse, bebida alcoólica e sedentarismo); - Estimular o autocuidado, adesão ao tratamento e envolver familiares no cuidado; - Estimular a participação em grupos educativos; - Orientar modificações do estilo de vida Alimentação saudável: Dieta rica em frutas, vegetais e alimentos com baixa densidade calórica e baixo teor de gorduras saturadas e totais; - Diminuição de ingestão de sal; Limite da ingestão diária de bebidas alcoólicas; - Abandono do tabagismo Estimular a execução de atividades físicas de acordo com a limitação de cada cliente; - Encaminhar para nutricionista e avaliação médica.
- Situação de violência		- Encaminhar para o serviço social do campus. - Seguir protocolo de Prevenção de violência à criança e ao adolescente.
- Tentativa de suicídio	- P77 Suicídio/ tentativa de suicídio	- Se necessário, encaminhar para o serviço de emergência ou consulta e avaliação médica; - Obter dados sobre condição psicológica; - Facilitar capacidade para comunicar sentimentos; Identificar percepções alteradas; - Encaminhar para serviço de psicologia do Campus; - Solicitar apoio da equipe multiprofissional; - Notificar violência autoprovocada; Monitorar adesão ao tratamento; - Promover

		apoio emocional; - Implementar precauções contra o suicídio com orientações aos familiares para vigilância; - Incentivar a participação em grupos terapêuticos.
- Visão Eficaz	- A98 Medicina preventiva/ manutenção de saúde	- Orientar sobre fatores de risco para visão como uso excessivo de telas entre outros.- Encaminhar para avaliação com oftalmologista periodicamente.
- Visão, Prejudicada	- F28 Limitação funcional/incapacidade - F29 Outros sinais/ sintomas oculares	Encaminhar para avaliação médica/oftalmologista.

Outra sugestão para diagnóstico de enfermagem pode ser utilizado Nanda - I - disponível em deenfermagem.com

**ANEXO B – MODELO DE ENCAMINHAMENTO DE SAÚDE PADRONIZADO
PARA USO DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM NO IFC**

Inserir logótipo da Instituição

Encaminhamento Serviço de Atenção à saúde n ____/ano ____ – SISAIE -IFC

_____, ____ de ____ de 20 ____

A Unidade Básica de Saúde

Estudante:

Curso:

Endereço da estudante:

Assunto: Encaminhamento Avaliação Geral de Saúde.

Cumprimentando-os cordialmente,

Encaminho a/o estudante _____, ____ anos, regularmente matriculada
em nossa Instituição, no Curso _____ para avaliação médica, pois

(relatório da situação)

Considerando o histórico acima exposto e o fato que a estudante pode apresentar prejuízos na sua aprendizagem devido ao contexto de saúde, encaminho a mesma para uma avaliação clínica geral de seu quadro de saúde.

Atenciosamente,

Enfermeira(o)

coren

siape